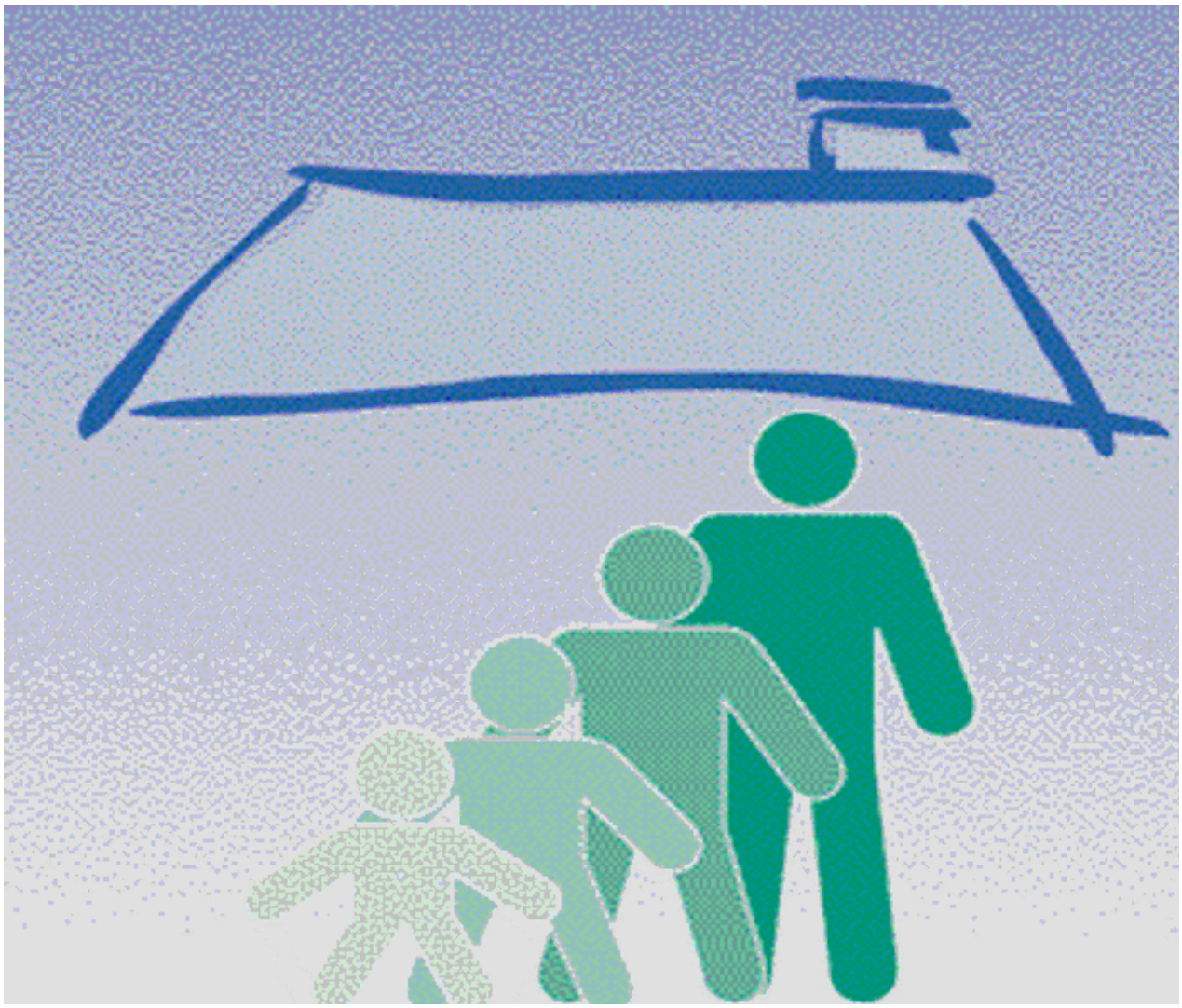
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2016

Manuel de l'intervieweur (IPAO/ITAO)



Division de la planification et de la recherche en matière de collecte

No. de référence : 75411-6651.2 Code de projet : 4145/4146

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Table des matières

Dans ce manuel Le présent manuel comporte les sections suivantes :

Page

1. Aperçu de l'enquête....1-1
   Aperçu....1-2
      Introduction....1-2
   Ce qu'il y a de nouveau dans l'enquête....1-3
      Introduction....1-3
      Quoi de neuf....1-3
      Retour au numéro de téléphone 1....1-3
      Dépliants....1-3
   Ce qu'il y a de nouveau dans l'enquête (suite)....1-4
      Couplage avec les données fiscales....1-4
   Renseignements sur l'enquête....1-5
      Introduction....1-5
      Objectifs....1-5
      Utilisateurs et utilisations....1-6
      Contenu....1-7
      Codes de projet....1-7
      Calendrier de l'enquête....1-8
      Taux de réponse....1-8
      Durée de l'interview....1-8
      Nature volontaire / obligatoire de l'enquête....1-8
      Échantillon....1-9
      Population cible....1-9
      Base de sondage....1-9
      Unité d'échantillonnage et de collecte....1-10
      Chevauchement des échantillons....1-10
      Mode de collecte....1-10
      Sélection du répondant....1-11
      Validation....1-11
      Programme d'observation et de rétroaction du contrôle de la qualité....1-11
   Relations avec les répondants....1-12
      Introduction....1-12
      Fournitures....1-12
      Lettre de présentation....1-12
      Lettre de non-contact....1-12
      Lettre de refus....1-12
      Dépliant....1-12
      Questions et réponses....1-13
      Participation récente à d'autres enquêtes de Statistique Canada..1-15

2. Application de collecte et procédures....2-1
   Aperçu....2-2
      Introduction....2-2
   Application de collecte....2-3
      Introduction....2-3
      Dans le champ / hors champ....2-3

Interview par procuration....2-3
Interview partielle....2-3
Partage et couplage des données....2-4
Qu'est-ce que ça veut dire? 2-7
Exemples d'études faites à l'aide d'un fichier de couplage....2-8
Importance d'informer le répondant 2-8
Codes de résultat....2-8
Procédures de collecte 2-11
Introduction....2-11
Liste....2-11
Composante Contact/ démographie (Entrée)....2-11
Logements....2-12
Introduction....2-15
Définition d'un ménage 2-15
Lieu de résidence habituel 2-15
Règles sur la composition du ménage 2-15
Protection de la vie privée et préoccupations des parents....2-19
Étapes à suivre 2-19
Notes essentielles....2-20
Transfert de cas des ITAO aux IPAO....2-20
Retour au numéro de téléphone 1....2-21
Phases de la collecte 2-21
ITAO − Importance de 5 et 20 tentatives....2-22
Interview délicate 2-22
Lecture des questions délicates....2-22
Réactions émotives du répondant et votre rôle 2-23
Items de non-réponse....2-23
Ressources pour le répondant 2-24
ITAO 2-25
Introduction....2-25
Qui fait l'objet d'un dépistage. 2-25
Action durant le dépistage....2-25
Cas envoyé au dépistage....2-26
Légalité de l'utilisation des données obtenues de sources publiques 2-26
Confidentialité 2-27
IMPORTANT....2-27

3. Questionnaire....3-1
Aperçu du questionnaire 3-2
Introduction....3-2
Disposition 3-2
ITAO du module Entrée 3-3
Coordonnées 3-4
Plusieurs numéros de téléphone (ITAO seulement)....3-5
IPAO par téléphone 3-5
Aperçu du questionnaire - Entrée 18+....3-6
Introduction....3-6
Nombre de multiples (MU) 3-6
MU_N01 3-6
Logements multiples....3-6
Contact (CN)....3-7
Aperçu du questionnaire - Entrée 12-17....3-19
Aperçu du questionnaire - Modules sur la santé 3-28

Introduction 3-28
Modules des questions sur la santé et socio-démographique (C2) 3-28
Guide des modules 3-28
Format des questions 3-28
Numérotage des questions 3-29
Refus / Ne sait pas 3-29
Introduction 3-29
Modules thématiques pour 2016 3-30
Modules communs pour 2016 3-31
Modules optionnels pour 2016 3-32
Aperçu 3-38
Nouveaux modules pour 2016 3-38
Réponse rapide 3-38
Modules avec des instructions particulières 3-39
Glossaire 3-40
Blessures (INJ) 3-46
Introduction 3-46
Aperçu du questionnaire - Sortie 3-91
Aperçu 3-91
Introduction 3-91

19. Annexes 4-1
Annexe A – Glossaire A-1
Annexe B – Guide de référence / fiche de consultation rapide B-1
Annexe C – Codes de résultat C-1
Annexe D – Modules par province / territoire D-1
Annexe E – Adresse dans le champ de l'enquête (18+) E-1
Annexe F – Documents pour le répondant F-1
Annexe G – Questions et réponses G-1

1. Aperçu de l'enquête

Dans ce chapitre Le présent chapitre comporte les sections suivantes :

Page

Aperçu 1-2
Introduction 1-2
Ce qu'il y a de nouveau dans l'enquête....1-3
Introduction 1-3
Quoi de neuf 1-3
Retour au numéro de téléphone 1....1-3
Dépliants....1-3
Ce qu'il y a de nouveau dans l'enquête (suite)....1-4
Couplage avec les données fiscales 1-4
Renseignements sur l'enquête....1-5
Introduction 1-5
Objectifs....1-5
Utilisateurs et utilisations....1-6
Contenu 1-7
Codes de projet 1-7
Calendrier de l'enquête....1-8
Taux de réponse....1-8
Durée de l'interview 1-8
Nature volontaire / obligatoire de l'enquête 1-8
Échantillon 1-9
Population cible 1-9
Base de sondage....1-9
Unité d'échantillonnage et de collecte....1-10
Chevauchement des échantillons 1-10
Mode de collecte....1-10
Sélection du répondant 1-11
Validation....1-11
Programme d'observation et de rétroaction du contrôle de la qualité 1-11
Relations avec les répondants 1-12
Introduction 1-12
Fournitures 1-12
Lettre de présentation 1-12
Lettre de non-contact 1-12
Lettre de refus....1-12
Dépliant 1-12
Questions et réponses 1-13
Participation récente à d'autres enquêtes de Statistique Canada..1-15

Introduction

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une enquête transversale menée par Statistique Canada qui permet de recueillir des renseignements sur l'état de santé des canadiens. L'enquête a commencé à recueillir des données en 2001, mais elle le fait de façon continuelle seulement depuis 2007. L'ESCC demeurera en mode de collecte continue en 2016.

Ce manuel a été préparé afin de donner des conseils et d'apporter de l'aide aux intervieweurs IPAO et ITAO pendant la formation et durant la collecte de cette information vitale sur la santé. Il est important de bien connaître ce manuel et de veiller à ce qu'il soit à votre disposition en tout temps pendant votre travail durant l'ESCC.

Le présent chapitre présente des renseignements généraux sur l'enquête et des directives concernant l'information destinée au répondant et fournit :

- les nouveaux points saillants de l'enquête
- l'utilité des données
- les lettres et dépliants
- les questions et réponses.

Ce qu’il y a de nouveau dans l’enquête

Introduction

L’ESCC 2015 faisait partie d’un remaniement global de l’enquête. Par conséquent, pour la période de collecte de 2016, aucun changement majeur n’a été apporté à l’enquête ni à l’application.

Pour le moment, il existe un seul nouveau module pour l’ESCC 2016, Attachement au médecin (MDA). Ce module est optionnel et offert uniquement en Colombie-Britannique.

Quoi de neuf

1. ITAO – Retour du numéro de téléphone 2 au numéro de téléphone 1.
2. ITAO/IPAO – Dépliants – Maintenant propres à chaque province/territoire.
3. Couplage avec les données fiscales.

Retour au numéro de téléphone 1

Une mise à jour a été apportée à l’application de 2016 pour l’échantillon de 18 ans et plus qui comporte plusieurs numéros de téléphone.

Une mise à jour a été apportée à l’échantillon de 18 ans et plus qui comporte plusieurs numéros de téléphone. Cette mise à jour fait suite à l’ajout de la fonction « arrêter-transférer » à l’ESCC 2015 (pour les transferts des ITAO aux IPAO).

Lorsque la fonction arrêter-transférer sera activée (mise en marche), voici ce qui se produira pour les cas qui sont passés au numéro de téléphone 2 (TELNUM2) parce qu’il n’y a pas eu de contact au numéro de téléphone 1 (TELNUM1) :

- Si le TELNUM2 a le code de résultat 2, 3 ou 5, l’application reviendra au TELNUM1.
- Le TELNUM1 continuera d’être composé jusqu’à ce que le cas soit résolu ou jusqu’à la fin de la période de collecte (si le TELNUM1 a le code de résultat 2, 3 ou 5, il sera envoyé comme code final.

Cela a été programmé dans l’application; il vous faudra simplement suivre le numéro de téléphone fourni à l’écran.

Dépliants

Pour 2016, chaque province/territoire aura dorénavant son propre dépliant de l’ESCC. Chaque dépliant renfermera des renseignements sur la province ou le territoire, y compris des références et des utilisations particulières des données de l’ESCC (selon le cas) dans cette région.

Par ailleurs, la présentation générale du dépliant variera selon la province ou le territoire, chaque dépliant étant d’une couleur différente et utilisant des images de villes comme fond qui sont propres à la province ou au territoire.

Couplage avec les données fiscales

Le questionnaire/application de 2016 a été modifié pour que l’on ne pose plus la question sur le revenu aux répondants ayant des enregistrements qui contiennent des données fiscales couplables (à moins qu’ils ne refusent l’énoncé relatif au couplage dans le module ADM). Ces cas seront préidentifiés par le bureau central. La question INC sera posée aux personnes dont les enregistrements ne pourront pas être couplés avec les données fiscales (une fois encore préidentifiées par le BC). Ce changement a été apporté dans l’application et se fera automatiquement.

Renseignements sur l'enquête

Introduction

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une enquête transversale annuelle qui permet de recueillir des renseignements sur l'état de santé, l'utilisation des services de santé et les déterminants de la santé au sein de la population canadienne. Réalisée auprès d'un grand échantillon de répondants (65 000), elle a été conçue pour fournir des estimations fiables à l'échelle de la région sociosanitaire.

Les renseignements provenant de l'ESCC permettent aux chercheurs et aux analystes de suivre l'état de santé de la population ainsi que l'impact des programmes de santé par régions sociosanitaires. Les résultats de l'enquête permettront aussi une étude plus détaillée des groupes démographiques par exemple, les aînés, les autochtones vivant hors réserves et les mères monoparentales.

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes marque un tournant en ce qui concerne la collecte d'information sur la santé de la population canadienne. Elle fournit des données précieuses et en temps opportun sur son état de santé, les facteurs de risque et l'utilisation des soins de santé. À partir de l'information recueillie au cours des années précédentes, on peut comparer les caractéristiques de la santé de la population non seulement au niveau des provinces et des territoires, mais aussi au niveau des régions sociosanitaires locales.

Une région sociosanitaire désigne une aire géographique dont la planification, les dépenses et le contrôle relatifs à la santé relèvent d'une entité administrative unique. Le ministère de la santé provincial et territorial a déterminé que 117 régions sociosanitaires ont été identifiées à travers le pays.

Statistique Canada sépare ou regroupe occasionnellement certaines régions sociosanitaires à l'intérieur d'une province pour des fins d'échantillonnage.

Objectifs

Les objectifs principaux de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont les suivants :

1. **Fournir des estimations sur la santé d'une façon régulière et opportune.**

   Non seulement est-il nécessaire d'obtenir plus de données, mais celles-ci doivent être reçues de façon régulière et opportune. Ceci permet le suivi des tendances et des comportements et permet de découvrir les répercussions des changements de politiques et de programmes.

2. **Fournir des estimations aux niveaux provinciaux et par région socio sanitaire.**

   Les renseignements doivent être recueillis aux niveaux provinciaux et intra provinciaux, selon la région sociosanitaire. Lorsque les données sont recueillies à ces niveaux, il est alors possible de les adapter de façon à répondre aux besoins spécifiques des communautés et de les mettre à leur service.

Objectifs (suite)

3. Fournir une certaine souplesse afin de modifier le contenu de manière à répondre aux besoins uniques des régions, des provinces et des territoires.

En offrant certains choix dans le contenu de l'enquête, nous permettons aux régions sociosanitaires de sélectionner des sujets qui leur paraissent importants tout en fournissant un contenu commun pour faire des comparaisons à tous les niveaux.

Utilisateurs et utilisations

La santé représente un enjeu de premier plan aux yeux du public. Qu'il s'agisse du nombre de travailleurs de la santé, de statistique sur la maladie, des effets du style de vie sur la santé, les gens sont préoccupés et désirent en connaître plus sur les sujets qui les touchent.

Les données sont utilisées pour :

- la planification ;
- les budgets et dépenses ; et
- le développement et suivi de programmes et de politiques.

Les principaux utilisateurs des données recueillies sont :

- Santé Canada;
- les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé ;
- les planificateurs régionaux de la Santé à travers le pays ;
- les chercheurs universitaires ;
- les médias ;
- les compagnies d'assurance et les entreprises pharmaceutiques ainsi que les consultants

Contenu

L'ESCC a une approche centrée sur la santé de la population fournit des indicateurs liés au bien-être mental et social, la qualité de vie, la satisfaction de vivre, le revenu, l'emploi et les conditions de travail, l'éducation et d'autres facteurs influençant la santé.

Le contenu porte sur trois principaux domaines d'intérêt :

1. **Les facteurs déterminants de la santé** sont des facteurs qui aident à déterminer ce qui rend une personne en bonne santé ou en moins bonne santé, comme le tabagisme, l'activité physique et la sécurité alimentaire. La majorité des recherches sur la santé démontrent que nous devons regarder la situation de la santé dans son ensemble pour examiner les facteurs qui affectent notre santé, autant au sein du système de soins de santé que dans l'environnement extérieur. La santé est déterminée par des interactions complexes entre des facteurs sociaux et économiques, l'environnement physique et le comportement individuel. Nous faisons référence à ces facteurs comme des « facteurs déterminants de la santé ».

2. **Les indicateurs de l'état de santé** sont établis en fonction de l'état de santé d'un individu, d'un groupe ou d'une population à un moment précis, selon des normes connues comme les problèmes de santé chroniques et les blessures.

3. **L'utilisation du système de santé.** Les modules qui touchent l'utilisation du système de santé visent à mesurer l'utilisation des services comme le dépistage du cancer colorectal, les vaccins contre la grippe, et les soins à domicile.

Codes de projet

Toutes les heures travaillées doivent être imputées aux codes de projet suivants :

Description	Code
IPAO	4145
ITAO	4146
ITAO nord	4430

Calendrier de l'enquête

Le tableau ci-dessous présente les différentes dates pour l'ESCC.

ID de la période de collecte	Date de début	Date de fin
201601	4 janvier, 2016	31 mars, 2016
201604	4 avril, 2016	30 juin, 2016
201607	4 juillet, 2016	30 septembre, 2016
201610	3 octobre, 2016	24 décembre, 2016

Nota : Ces dates peuvent changer suite à des contraintes opérationnelles.

Taux de réponse

Le taux de réponse cible pour l'ESCC 2016 est **65.5%** dans l'ensemble, IPAO et ITAO comprises.

Durée de l'interview

L'interview de l'ESCC durera environ **60** minutes.

La composante C2, composée des modules sur la santé et sur les renseignements sociodémographiques, durera en moyenne de **45 à 50** minutes. Accordez de **10 à 15** minutes supplémentaires pour compléter les composantes Entrée, Sortie et la Liste des membres du ménage.

Nature volontaire / obligatoire de l'enquête

L'ESCC est une enquête à participation volontaire en vertu de la *Loi sur la statistique.*

Échantillon

Ce tableau présente l'échantillon de l'enquête.

Bureau régional	ITAO	IPAO	Transferts de l'ITAO à l'IPAO prévus
Halifax	8,945	3,156	1,363
Sherbrooke/Montréal	16,946	3,222	2,193
Sturgeon Falls/Toronto	26,028	4,461	3,864
Ouest	27,547	7,901	5,045
Total	**79,465**	**18,740**	**12,465**

Population cible

L'ESCC vise la population âgée de **12 ans et plus** vivant dans les dix provinces et les trois territoires.

Sont exclus du champ de l'enquête les personnes vivant dans les réserves et autres peuplements autochtones des provinces, les membres à temps plein des Forces canadiennes, la population vivant en établissement et les personnes vivant dans les régions sociosanitaires : Région du Nunavik et Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James au Québec. En tout, ces exclusions représentent moins de 3 % de la population cible.

Par contre, l'échantillon proviendra de deux bases (aréolaire et de la PFCE). Chaque base portera sur un groupe d'âge différent et une unité d'échantillonnage différente.

Base de sondage

L'échantillon pour l'ESCC de 2016 proviendra de la base aréolaire (BSEM) et de la base de sondage de la PFCE (Prestation fiscale canadienne pour enfants). Voici un résumé de certains renseignements importants sur la base aréolaire et la base de sondage de la PFCE.

	Base aréolaire		Base de la PFCE
Population	18 ans et plus		12 à 17 ans
Unité d'échantillonnage	Logement		Personne
Unité de collecte	Personne		Personne
Mode de collecte	ITAO	Transferts IPAO et ITAO-IPAO	ITAO
Sélection du répondant	Sélection aléatoire		Présélectionné

Unité d'échantillonnage et de collecte

BASE ARÉOLAIRE

- Un **échantillon de logements** est sélectionné (de manière à cibler la population de 18 ans et plus).
- Un membre du ménage admissible (18+) sera sélectionné au hasard par l'application pour remplir le questionnaire.
- Les cas débuteront en étant IPAO s'ils n'ont pas de numéros de téléphone disponibles.
- Les cas ayant au moins un numéro de téléphone disponible débuteront en étant ITAO.
- Les numéros de téléphone hors service et les numéros de téléphone qui ne sont pas associés à la bonne adresse seront transférés automatiquement aux IPAO.

BASE DE LA PFCE

- Un **échantillon de personnes** est sélectionné à partir de la base de la PFCE (de manière à cibler la population de 12 à 17 ans).
- Un enfant (de 12 à 17 ans) est présélectionné pour remplir le questionnaire (environnement ITAO seulement).
- Les cas « pas de contact » seront dépistés.

Chevauchement des échantillons

La méthodologie d'échantillonnage de l'ESCC est conçue de manière à éviter les chevauchements entre les modes de collecte (IPAO et ITAO) ainsi que les enquêtes répétées au cours d'une période de deux ans. Il est donc peu probable qu'un ménage ait récemment été échantillonné pour l'ESCC ou échantillonné deux fois au cours du même cycle de collecte.

Cependant, dans les rares cas où un adulte et un enfant vivant dans le même ménage sont choisis, les deux seraient considérés être dans le champ de l'enquête et admissibles pour remplir l'ESCC.

Mode de collecte

Le mode de collecte pour l'ESCC de 2015 sera l'ITAO, l'IPAO et le transfert des ITAO aux IPAO.

Mode	Échantillon
ITAO	La totalité de l'échantillon sélectionné à partir de la base de la PFCE et la totalité de l'échantillon sélectionné à partir de la base aréolaire comportant au moins un numéro de téléphone disponible commenceront par des ITAO.
IPAO	La totalité de l'échantillon sélectionné à partir de la base aréolaire sans numéro de téléphone commencera par des IPAO.
ITAO à IPAO	Seuls les cas de la base aréolaire peuvent être transférés aux IPAO.

Sélection du répondant

Un membre admissible du ménage âgé de 18 ans ou plus sera sélectionné au hasard par l'application pour remplir le questionnaire. Tous les enfants âgés de 12 à 17 ans seront présélectionnés.

Validation

Pour s'assurer de l'exactitude et de la qualité des données recueillies lors de la collecte, les gestionnaires et superviseurs des bureaux régionaux communiqueront avec des ménages choisis au hasard afin de vérifier qu'une interview a eu lieu. Ils fourniront également de façon régulière un rapport de progrès aux intervieweurs.

Programme d'observation et de rétroaction du contrôle de la qualité

L'observation est un outil de gestion nécessaire, utilisé pour assurer la qualité des données et le respect des échéances.

Le programme d'observation des IPAO représente simplement un autre outil de contrôle de la qualité qui mesure objectivement la qualité de l'interaction entre vous et le répondant et, jusqu'à un certain degré, l'interaction entre vous et l'instrument d'enquête.

Le processus d'observation et de rétroaction est objectif et complet.

L'observateur examine des comportements particuliers et des ensembles de compétences, puis discute de ses observations avec vous au cours d'une séance de commentaires.

Pendant le contrôle de la qualité des ITAO, le personnel des bureaux régionaux écoutera les appels téléphoniques dans l'environnement ITAO au moyen du système d'écoute actuel, conformément aux directives d'observation, et fournira une rétroaction aux intervieweurs.

Pendant le contrôle de la qualité des IPAO, des parties de l'interview sont enregistrées. Les observateurs des IPAO écoutent les enregistrements pour vérifier si l'intervieweur respecte les quatre facteurs essentiels d'une interview réussie et s'il respecte les exigences propres à l'enquête pour assurer la qualité des données durant l'activité de collecte. Veuillez consulter le manuel des OES afin de passer en revue les quatre facteurs essentiels d'une interview réussie (se préparer, s'engager, effectuer et clore l'interview). Les superviseurs fourniront une rétroaction aux intervieweurs.

L'observateur fournira des commentaires constructifs, encourageants et pondérés à tous les intervieweurs en fonction de ce qu'ils auront dit au répondant.

Relations avec les répondants

Introduction

La clé du succès pour obtenir des données précises est une bonne relation avec les répondants. L'ESCC dispose de plusieurs ressources. On peut faire appel aux intervieweurs pour renseigner les répondants quant à l'importance de l'enquête et aux usages qu'on en fait, ainsi que pour répondre aux questions et réagir aux éventuels refus de participer.

Fournitures

Veuillez vous assurer que vous avez reçu les fournitures suivantes. Vous devez les avoir sous la main durant les interviews :

- Manuel de l'intervieweur,
- Note aux parents/tuteurs,
- Guide de référence rapide,
- Liste des grappes et diagramme (F02);
- Brochure (spécifique à la province),
- Lettre de présentation
- Avis de visite.

Lettre de présentation

Un exemplaire de la lettre de présentation se trouve à l'annexe F.

Lettre de non-contact

Une copie de la lettre de non-contact utilisée pour l'enquête est présentée à l'annexe E.

Lettre de refus

Une copie de la lettre de refus utilisée pour l'enquête figure à l'annexe F.

Dépliant

Vous seront fournis avec des copies supplémentaires des brochures par votre bureau régional.

Questions et réponses

Le tableau suivant renferme des exemples des questions de base que les répondants pourraient poser et des réponses que l'intervieweur devrait donner.
La liste complète des questions et réponses se trouve à l'annexe F.

Questions	Réponses
Qu'est-ce que l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes?	L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est une **enquête nationale sur la santé** composée d'un échantillon représentatif de personnes habitant au Canada qui répondront à des questions sur leur santé et leur bien-être, les facteurs influant sur leur santé et leur utilisation des services de santé. L'enquête fournira des renseignements aux intervenants locaux de santé à des fins d'évaluation et de planification des programmes de promotion de la santé.
Quels sont les objectifs de l'Enquête?	Appuyer les services locaux de santé en leur communiquant des renseignements à jour qui leur permettent d'évaluer les politiques et les programmes existants et d'en concevoir de nouveaux, adaptés à leurs collectivités. Obtenir de chaque province, des renseignements sur la santé qui soient actuels, détaillés et uniformes.
Quels genres de questions poserez-vous?	L'enquête pose une variété de questions sur les sujets suivants : • l'état actuel de votre santé • les comportements que l'on croit associés à votre santé • l'utilisation que vous faites des services de santé • des données sociodémographiques au sujet de votre ménage
Qui se sert de ces renseignements? À quelles fins?	• **Les ministères provinciaux de la santé et les ministères du gouvernement fédéral** s'appuieront sur ces renseignements pour prendre des décisions de financement, élaborer des priorités et cerner les secteurs de préoccupation afin d'établir de nouveaux programmes, de nouvelles politiques et de nouvelles lois. • **Les chercheurs** disposeront, plus que jamais, de données sur la santé leur permettant de suivre de près, d'analyser et de mesurer les facteurs qui nuisent à la santé et d'en faire état.

Questions et réponses

Qui se sert de ces renseignements? À quelles fins? (suite)	• **Les ministères provinciaux de la santé et les ministères du gouvernement fédéral** s'appuieront sur ces renseignements pour prendre des décisions de financement, élaborer des priorités et cerner les secteurs de préoccupation afin d'établir de nouveaux programmes, de nouvelles politiques et de nouvelles lois. • **Les chercheurs** disposeront, plus que jamais, de données sur la santé leur permettant de suivre de près, d'analyser et de mesurer les facteurs qui nuisent à la santé et d'en faire état.

Refus motivé par la participation récente à une enquête

Un répondant peut refuser d'être interviewé parce qu'il a récemment répondu à une enquête de Statistique Canada. Dans ce genre de situation, il est important que les intervieweurs posent des questions pour déterminer s'il s'agissait véritablement d'une enquête menée par Statistique Canada, le moment où cette enquête a été réalisée, si elle a été effectuée en personne ou par téléphone, et s'il s'agissait de l'ESCC.

Participation récente à d'autres enquêtes de Statistique Canada

Une personne ou un ménage peut être interviewé pour l'ESCC s'il a participé à une autre enquête de Statistique Canada. C'est vrai même lorsque l'enquête à laquelle il a récemment répondu était aussi une enquête sur la santé. Il est essentiel que les intervieweurs transmettent cette information aux répondants réticents.

Si...	Alors...	Et...
… le répondant refuse de participer parce qu'il a récemment participé à l'ESCC (ou à une autre enquête), que ce soit en personne ou par téléphone	…rassemblez le plus d'information possible auprès du répondant	…demandez au superviseur d'envoyer une demande de vérification au domaine spécialisé par le JIRA.
… le domaine spécialisé et la méthodologie peuvent confirmer que le répondant a récemment participé à l'ESCC	le domaine spécialisé enverra des instructions pour accorder le code 63 au cas	…votre superviseur entrera le code final 63 – A déjà répondu à cette enquête
… le domaine spécialisé et la méthodologie confirment que le répondant a participé à une autre enquête de StatCan,	le domaine spécialisé enverra des instructions pour accorder le code 66 au cas	...votre superviseur entrera le code final 66 – Chevauchement des échantillons
… le cas n'est pas vérifié par le domaine spécialisé comme un cas de récente participation	…on demandera à l'intervieweur de faire toutes les tentatives de conversion du refus, avec un accent sur la sélection aléatoire des ménages et/ou l'importance des précieux renseignements sur la santé qui sont recueillis.	Si le répondant refuse toujours, il faut utiliser le code final du refus (code 80) et inscrire la raison du refus (à OC_ N04), soit 9 – « A récemment participé à une enquête (ne veut pas participer à une autre enquête) ».

2. Application de collecte et procédures

Dans ce chapitre Le présent chapitre comporte les sections suivantes :

Page

Aperçu 2-2
Introduction 2-2
Application de collecte 2-3
Introduction 2-3
Dans le champ / hors champ 2-3
Interview par procuration....2-3
Interview partielle 2-3
Partage et couplage des données....2-4
Qu’est-ce que ça veut dire? 2-7
Exemples d’études faites à l’aide d’un fichier de couplage....2-8
Importance d’informer le répondant 2-8
Codes de résultat....2-8
Procédures de collecte 2-11
Introduction 2-11
Liste 2-11
Composante Contact/ démographie (Entrée) 2-11
Logements....2-12
Introduction 2-15
Définition d'un ménage 2-15
Lieu de résidence habituel 2-15
Règles sur la composition du ménage 2-15
Protection de la vie privée et préoccupations des parents....2-19
Étapes à suivre 2-19
Notes essentielles....2-20
Transfert de cas des ITAO aux IPAO 2-20
Retour au numéro de téléphone 1....2-21
Phases de la collecte 2-21
ITAO − Importance de 5 et 20 tentatives....2-22
Interview délicate 2-22
Lecture des questions délicates 2-22
Réactions émotives du répondant et votre rôle 2-23
Items de non-réponse 2-23

Aperçu

Introduction

Le présent chapitre présente :

- les différentes caractéristiques de l'enquête
- les procédures de l'enquête.

Application de collecte

Introduction

Cette section présente les différentes caractéristiques de l'application de collecte.

Dans le champ / hors champ

Les colonies huttériennes sont incluses dans la base de sondage pour l'ESCC.

Cependant, il y a des défis lors d'interview téléphonique.

- Il y a des ménages avec une ligne directe, mais généralement la ligne téléphonique disponible est un numéro principal pour le tableau de distribution de la colonie.
- Assurez-vous de prendre contact avec une personne vivant à l'adresse sélectionnée et de recueillir des données seulement pour cette adresse.
- Il pourrait y avoir une limite de temps de dix minutes par appel téléphonique. L'appel en question se termine sans préavis.

Interview par procuration

L'interview par procuration fait référence à une interview menée avec **un autre membre renseigné du ménage,** ou dans de **très rares circonstances avec un non-membre renseigné du ménage,** au nom du répondant choisi.

Tous les efforts doivent être faits pour mener une interview avec le répondant choisi.

On ne doit avoir recours à une interview par procuration que si **l'état physique ou mental du répondant** fait en sorte qu'il lui est **impossible** de faire l'interview durant la période de collecte.

Si l'interview par personne interposée est menée avec un non-membre du ménage, l'intervieweur doit écrire une **Remarque (F4)** pour expliquer la relation entre le répondant et la « non-membre du ménage » ainsi que la raison pour laquelle l'interview est menée avec un non-membre du ménage.

Un exemple de non-membre du ménage serait un enfant ou un membre de la famille qui s'occupe du répondant choisi, mais qui n'habite pas avec lui.

Interview partielle

La limite pour les interviews partielles de l'ESCC est la première question du module sur **les soins de santé primaires** (**PHC_Q005**).

Partage et couplage des données

Statistique Canada a conclu une entente de partage de données, prévue à l'article 12 de la Loi sur la statistique, pour partager les résultats de cette enquête avec

- les ministères provinciaux et territoriaux de la santé ,
- Santé Canada et,
- l'Agence de santé publique du Canada.

L'information donnée par les répondants peut seulement être divulguée avec leur consentement. Les questions de partage de données sont posées à la fin de l'interview, dans le module ADM. ADM_R025 s'applique à toutes les provinces et territoires excepté au Québec et ADM_R030 s'applique au Québec seulement. Les questions de partage de données sont également posées dans le module de sortie (PS_) si on est sorti du cas avant qu'il soit terminé, et après la limite de l'interview partielle, à la première question dans le module sur les soins de santé primaires (PHC_Q005).

Si le répondant choisit de partager ses renseignements avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada, ces derniers doivent eux aussi prendre des mesures de sécurité afin de protéger les données et d'assurer la confidentialité. Comme résultat de la signature de l'accord de partage de données, ces organismes ont les mêmes obligations que Statistique Canada envers la protection de la confidentialité des données.

Les ententes conclues avec ces ministères leur **interdisent** de **divulguer toute information permettant d'identifier** les répondants à partir de données recueillies par Statistique Canada. Les ministères ne peuvent diffuser que des données agrégées à partir de l'information reçue de Statistique Canada.

Statistique Canada ne publie que des résumés statistiques dans lesquels **l'identité des personnes ne peut jamais être dévoilée.**

Le partage des données vise à :

- permettre à ceux qui sont responsables des services de soins de santé (les ministères provinciaux et territoriaux de la santé) de travailler directement avec les données de l'enquête;
- réduire le fardeau de réponse du répondant, en ne recueillant les données qu'une fois;
- améliorer la qualité des résultats de l'enquête;
- réduire les coûts de la collecte.

Les provinces et les territoires se servent des renseignements partagés pour « coupler » le fichier de partage avec d'autres fichiers qui sont en leur possession, comme les dossiers sur les hospitalisations et sur l'utilisation de certains services précis.

Partage et couplage des données (suite)

Nous informons les répondants de ce couplage de données en leur lisant l'énoncé suivant.

ADM_Q005 **: Statistique Canada et votre ministère de la santé provincial pourraient combiner vos réponses avec des renseignements provenant d'autres enquêtes ou de sources administratives. Ceci pourrait inclure des sources de données comprenant des renseignements portant sur l'utilisation passée et courante des services de santé, par exemple les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les bureaux de médecins.**

Les répondants peuvent refuser le couplage de leurs renseignements. Si le répondant a été informé du couplage et qu'il donne son consentement, on lui demande ensuite de donner son numéro d'assurance maladie. Si le répondant s'oppose au couplage de données, ceci sera inscrit et aucun couplage ne sera fait.

Qu'est-ce que le « couplage de données »?

Par « couplage de données » on entend la mise en liaison des réponses aux questionnaires avec des renseignements contenus dans les dossiers de santé provinciaux. Ces renseignements peuvent comprendre des données relatives aux visites chez le médecin ou les admissions à l'hôpital. Ils ne comprennent aucun renseignement personnel provenant des dossiers médicaux que tiennent les médecins sur leurs patients.

Le couplage de données nous permet de rendre les réponses aux questions plus utiles et fiables.

Pourquoi effectuons-nous le couplage des données?

Il est important de jumeler les données relatives à l'état de santé et aux indicateurs de la santé avec les coûts réels des soins de santé. Avec d'autres renseignements recueillis au cours de l'enquête, le jumelage des données contribue à répondre à des questions telles que les suivantes :

- Les personnes les plus nécessiteuses reçoivent-elles les services de santé dont elles ont besoin?
- Est-ce que la consultation régulière d'un médecin ou le fait de se soumettre régulièrement à un examen physique aide les gens à rester en bonne santé?
- Le stress vécu au travail et à la maison a-t-il une incidence sur le nombre de fois que les gens consultent un médecin?
- Y a-t-il une continuité dans les soins de santé? Y a-t-il un lien entre cette continuité et un meilleur état de santé?

Qui effectue le couplage des données?

Le couplage des données est effectué par les ministères provinciaux de la Santé, dans un contexte de confidentialité et de sécurité Seuls les renseignements recueillis durant l'enquête peuvent être mis en liaison avec ces autres renseignements.

Partage et couplage des données (suite)

Quand effectue-t-on le couplage? / Combien de temps dure-t-il?

Le jumelage des données n'est assujetti à aucune limite de temps; il peut être effectué n'importe quand après la réalisation de l'enquête. Cela ne signifie pas pour autant que l'on tient une base de données permanente; les demandes de jumelage de données doivent répondre à une question précise du domaine de la recherche à un moment précis.

Par exemple, en 2006, un chercheur pourrait vouloir étudier les taux de cancer chez les répondants qui ont déclaré être fumeurs cinq ans auparavant. On pourrait alors effectuer un jumelage ponctuel des patients atteints d'un cancer en 2006 avec des données de l'ESCC cycle 2,1, afin d'étudier d'éventuels liens.

La prochaine fois que l'on étudiera une question similaire (par exemple, cinq ans plus tard), il faudra obtenir une nouvelle autorisation de jumelage auprès du gouvernement provincial.

Qu'est-ce qui garantit que les renseignements vont demeurer confidentiels?

Les ministères provinciaux de la Santé sont tenus par serment de préserver la confidentialité des données. Aucun renseignement susceptible de révéler l'identité d'une personne ne demeure dans les fichiers couplés, sous peine de sanctions prévues par la loi.

En outre, les provinces ont leurs propres règles strictes en ce qui a trait au jumelage de données. Ainsi, les renseignements demandés doivent être utilisés uniquement à des fins de recherche et pour le jumelage autorisé par l'instance provinciale. Dans la plupart des cas, une seule personne a accès aux fichiers de jumelage.

Qu'est-ce que ça veut dire?

Un fichier de **partage** est un fichier qui contient des données pour tous les répondants qui ont accepté de partager leur information et remis aux ministères de la santé.

Le fichier de **partage** ne contient pas de renseignements permettant d'identifier les répondants, comme le nom, l'adresse et le numéro de carte santé du répondant.

Cependant, si le répondant accepte le **partage des données**, Statistique Canada pourrait fournir ces renseignements d'identification aux ministères provinciaux et territoriaux de la santé.

Les provinces/territoires se servent de ces renseignements pour coupler le fichier de partage avec d'autres fichiers qui sont en leur possession, comme les dossiers sur les hospitalisations et sur l'utilisation de certains services. Le **fichier de couplage** est le résultat de cet appariement; il sert à étudier certaines questions plus pointues qui ne peuvent être examinées avec le fichier de partage.

Les renseignements permettant d'identifier les répondants sont fournis aux provinces/territoires sur demande et uniquement pour des études précises. Ces renseignements sont fournis dans un fichier séparé qui doit être détruit dès que le fichier de jumelage a été créé.

Rappel :

- Le fichier de **couplage** contient uniquement des enregistrements pour les répondants qui ont accepté le partage et le jumelage de l'information les concernant. **Aucun renseignement d'identification** comme le nom, l'adresse, la date de naissance ou les renseignements de la carte santé n'est conservé dans le fichier de couplage. Ces renseignements sont détruits après la création du fichier de couplage.
- Le fichier de couplage ne contient pas de renseignements permettant d'identifier personnellement un répondant et n'est utilisé qu'au sein du ministère provincial/territorial de la santé.
- Tout comme pour Statistique Canada, il est **interdit aux ministères provinciaux et territoriaux de la santé de divulguer toute information qui pourrait être utilisée pour identifier** directement ou indirectement une personne.
- Les ministères provinciaux et territoriaux de la santé et Statistique Canada sont **tenus de protéger l'information et d'en préserver la confidentialité.**

Exemples d'études faites à l'aide d'un fichier de couplage

- Pour déterminer si les coûts des soins de santé sont moindres pour les personnes actives que pour les autres, un ministère de la santé fait le couplage des données d'enquête sur l'activité physique avec des données tirées des factures de médecins.
- Pour étudier le profil socioéconomique (âge, sexe, revenu, statut d'immigrant) et l'état de santé (auto déclaré, nombre de maladies chroniques) des personnes qui font appel à ses services, un programme d'info-santé recueille le numéro de carte santé de tous ceux qui appellent et apparie ces numéros aux données de l'ESCC.
- Pour savoir quels sont les médicaments qui sont prescrits le plus souvent pour soigner des maladies comme l'arthrite ou l'angine, le ministère de la santé d'une province fait le jumelage des données de l'ESCC sur les maladies chroniques avec l'information tirée d'un programme d'assurance-médicaments pour les personnes âgées.

Importance d'informer le répondant

Si un répondant hésite à fournir ces renseignements, informez-le que :

- Les renseignements fournis vont demeurer confidentiels
- Les renseignements seront utilisés uniquement à des fins statistiques
- Les renseignements seront fournis uniquement aux ministères provinciaux de la Santé, qui sont tenus de respecter les mêmes exigences que Statistique Canada en matière de confidentialité.
- Soyez prêt(e) à répondre à toute question que peuvent poser les répondants.

Codes de résultat

Il est important de coder chaque cas correctement. La liste complète des codes de résultat et des définitions de l'ESCC se trouve à l'annexe C du présent manuel.

Les intervieweurs devraient se familiariser avec tous les codes de résultat, en particulier les suivants :

Codes de résultat 02, 03 et 05

- 02 - Numéro de téléphone inexact
- 03 - Numéro de téléphone hors service
- 05 - Message enregistré

Les intervieweurs ITAO doivent utiliser les codes 2, 3 et 5 comme codes finals pour permettre à l'application d'utiliser tous les numéros de téléphone disponibles avant que le cas ne soit finalisé. Un message apparaîtra pour informer les intervieweurs lorsque d'autres numéros seront disponibles. Une fois que tous les numéros seront utilisés et qu'aucun contact n'aura été établi, un cas se verra attribuer automatiquement le code 68 en vue de son transfert aux IPAO.

Codes de résultat 04, 11, 12, 13, 14 et 15

Les cas comportant les codes suivants peuvent être considérés en vue d'un transfert aux IPAO à la fin de la phase 2.

- 04 - Tonalité indiquant que tous les circuits sont occupés, bruits étranges, silence total
- 11 - Personne à la maison/Pas de réponse
- 12 - Ligne occupée - tonalité normale
- 13 - Répondeur ou service de réponse — pas de message laissé
- 14 - Répondeur ou service de réponse — message laissé
- 15 - Filtrage, blocage ou appel acheminé à un autre numéro

Une fois encore, nous tenons à souligner l'importance de bien utiliser les codes susmentionnés et de pouvoir faire une distinction claire entre le code de résultat 5 (message enregistré) et les codes de résultat 12, 13 et 14.

Code de résultat 27

- 27 - Contact avec une personne qui n'est pas membre du ménage (ITAO et IPAO).

Code de résultat 29

- 29 - Interview en personne demandée / requise (ITAO)

Le code de résultat 29 doit être utilisé uniquement lorsqu'une interview personnelle est demandée par un répondant. Les interviews personnelles ne devraient pas être offertes. Un superviseur vérifiera les cas portant le code 29 et leur attribuera manuellement le code 68.

Codes de résultat 30 , 36 et 38

- 30 - Dépistage/recherche requis
- 36 - Impossible de dépister / rechercher
- 38 - Rendez-vous avec la source de dépistage / recherche

Les codes de résultat 30, 36 et 38 devraient être utilisés principalement pour le groupe de 12 à 17 ans des ITAO. Le dépistage n'est pas permis pour le groupe de 18 ans et plus des ITAO et des IPAO, mais certaines recherches peuvent être nécessaires.

Code de résultat 61

- 61 - Non admissible en raison de l'âge est utilisé uniquement pour l'ESCC

C'est un code automatique qui est utilisé pour veiller à ce que la limite d'âge soit respectée dans chaque base de sondage.

Codes de résultat 63 et 66

- 63 - A déjà été interviewé pour cette enquête
- 66 - Chevauchement des échantillons

Les codes de résultat 63 et 66 devraient être approuvés par le secteur spécialisé.

Demandez à votre superviseur d'envoyer une demande dans JIRA en vue d'une approbation par le secteur spécialisé.

Code de résultat 68

- 68 - Transféré sur le terrain

Ce code s'applique aux ITAO seulement; il sert à transférer les cas des ITAO aux IPAO. Les cas portant les codes finals 2, 3 et 5 se voient automatiquement attribuer le code 68 en vue du transfert aux IPAO. Vos superviseurs attribueront manuellement le code 68 aux cas portant le code final 29 et aux cas identifiés par le secteur spécialisé en vue du transfert aux IPAO.

Nota : Pas de transfert des IPAO aux ITAO.

Procédures de collecte

Introduction

Cette section présente les procédures à suivre dans des cas particuliers.

Liste

La section Contact / démographie constitue la première partie du questionnaire et est également nommée « Entrée ».

La présente section vise à recueillir des renseignements sur le ménage, y compris une **liste** des membres du ménage, leur âge, leurs relations et d'autres renseignements démographiques.

Ces renseignements peuvent être obtenus auprès d'un membre adulte du ménage âgé de 18 ans ou plus. L'application sélectionnera automatiquement, à partir de l'information obtenue, un membre de ce ménage qui sera appelé à remplir le questionnaire.

Les noms des répondants âgés de 12 à 17 ans sont sélectionnés avant que le contact soit établi.

Composante Contact/ démographie (Entrée)

La composante Contact/démographie est la première section du questionnaire à remplir. Cette section inclut les coordonnées du répondant, la composition du ménage, des renseignements démographiques (pour chacun des membres du ménage), des renseignements sur le logement et la langue de l'interview. Cette composante est aussi connue sous le nom « Entrée ».

Pour 2016, l'ESCC comporte deux entrées différentes pour l'ITAO, mais une seule entrée pour l'IPAO. Une entrée est utilisée pour les répondants adultes âgés de 18 ans ou plus, et l'autre, pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

S'il faut sélectionner un répondant adulte pour un cas, les réponses à la composante Entrée peuvent être fournies par un adulte informé membre du ménage. La sélection du répondant se fera automatiquement lorsque cette section aura été remplie. Le répondant sélectionné doit par la suite répondre au reste du questionnaire.

Si un enfant a été présélectionné comme répondant pour un cas, les réponses à la composante Entrée doivent être obtenues auprès du parent ou tuteur figurant sur la liste ou d'un autre adulte bien informé. Si un enfant sélectionné de 17 ans vit seul et qu'il n'y a pas d'adulte dans le ménage, on peut lui demander de remplir la composante Entrée. Il est quand même nécessaire d'établir une liste même si un répondant a été présélectionné.

Par la suite, on peut demander à l'enfant de remplir le reste du questionnaire, à condition d'avoir obtenu l'autorisation parentale au préalable.

Logements

Afin d'assurer la couverture exacte de l'échantillon, il est important de comprendre les concepts de logement, de ménage et de lieu de résidence habituel. Il importe aussi de déterminer les logements admissibles ou non. Les tableaux sur les pages suivantes font état des logements admissibles et inadmissibles aux fins de la présente enquête.

Définition d'un logement

Un logement est un ensemble de pièces d'habitation où une personne ou un groupe de personnes vivent ou pourraient vivre (p. ex., résidence privée, appartement, duplex, etc. – et dans de très rares cas, des institutions ou des hôpitaux).

Logements admissibles

Les logements admissibles à la présente enquête sont principalement des logements où réside habituellement une personne ou un groupe de personnes.

TYPE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS ADMISSIBLES
Résidence privée	Une résidence privée est un logement qu'une ou plusieurs personnes considèrent comme leur lieu de résidence habituel. Un lieu de résidence habituel est le logement où une personne loge habituellement. Cette personne peut être : • Un membre de la famille • Un(e) locataire • Un(e) pensionnaire • Un(e) employé(e) Exemples : • Maison (unifamiliale, double, en rangée) • Duplex ou triplex • Appartement • Maison mobile
Résidence privée ET entreprise	Une résidence privée et entreprise est un logement qui fait office de lieu de résidence habituel et d'entreprise menée à partir de la maison. Le nom de l'entreprise peut être mentionné quand on répond au téléphone.

TYPE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS ADMISSIBLES
Logement collectif **Non-institutionnels**	Un logement de nature communale ou une maison privée occupée par 10 personnes ou plus sans aucun lien de parenté (si moins de 10 personnes y résident, il est classé comme une maison privée), et doit avoir au moins une personne qui considère ce logement comme étant sa résidence habituelle. Exemples : • Un centre d'hébergement ou une maison de chambres • Un motel, un hôtel ou une maison de chambres pour touristes • Une résidence d'employés, un camp de travail, une mission, un foyer de groupe ou le YM/YWCA.
Logement collectif institutionnels	Un logement qui est institutionnel peut être, sous certaines conditions, considéré comme étant dans la portée de l'enquête. • Établissement pour personnes ayant une incapacité • Établissement de soins infirmiers • Établissement de soins pour enfants et mineurs • Établissement pour délinquants et jeunes contrevenants * Si il ya des propriétaires, employés ou les conjoints de patients / résidents vivants dans ces institutions et le considèrent comme leur lieu habituel de résidence, le logement serait partie du champ de l'enquête. Autres exemples : • Résidence pour personnes âgées • Établissement religieux (p.ex. : monastère, couvent) * Si ces établissements offrent peu ou un minimum de soins aux résidents, le logement ferait partie du champ de l'enquête.
Logement Secondaire/ Saisonnier	Résidence privée qui constitue la résidence habituelle de n'importe quelle personne au moment de l'enquête. Exemples : • Chalet ou résidence de vacances • Roulotte • Résidence secondaire (p. ex., utilisée pour travailler ou fréquenter une école à l'extérieur) *Une personne doit vivre au logement pour la majorité de l'année pour que celui-ci soit dans le champ de l'enquête.

Logements inadmissibles

Pour la présente enquête, un logement inadmissible est principalement un logement qui ne constitue pas la résidence habituelle des répondants ou qui est un établissement institutionnel.

Type de logements inadmissibles	LOGEMENTS INADMISSIBLES
Logement Secondaire/ Saisonnier	Résidence privée qui n'est pas la résidence habituelle de n'importe quelle personne au moment de l'enquête. Exemples : • Chalet ou résidence de vacances, • Roulotte, • Résidence secondaire (p. ex., utilisée pour travailler ou fréquenter une école à l'extérieur).
Entreprise seulement	Le logement est occupé par une entreprise seulement et personne ne le considère comme étant sa résidence habituelle.
Établissements institutionnels	Logement qui tient lieu d'établissement institutionnel (hors du champ de l'enquête) Exemples : • Hôpital • Établissement de soins de longue durée • Résidence pour personnes âgées et religieux offrant des **soins complets-modérés** • Établissement ayant de l'équipement pour handicapés, pour le soin des enfants ou des mineurs, pour les jeunes délinquants et les maisons de soins infirmiers comptant que des résidents qui y vivent (pas conjoints, propriétaires ou employés qui y vivent) • Centre de traitement • Établissement pénitencier

Introduction

Pour obtenir une bonne couverture et pour éviter les dédoublements, il est important de comprendre quels sont les membres d'un ménage qui doivent figurer sur la liste. Les prochains paragraphes donnent une explication à propos des membres que l'intervieweur doit inclure ou exclure de la liste. Dans certains cas, un membre peut être hors du champ de l'enquête (comme un enfant de moins de 12 ans, un membre à temps plein des Forces armées canadiennes (FAC), etc.), mais il est tout de même très important de l'inclure dans la liste des membres du ménage. L'application en tient compte au moment de choisir le répondant.

Définition d'un ménage

Un ménage désigne toute personne ou tout groupe de personnes vivant dans un logement. Il peut se composer :

- d'une personne vivant seule,
- d'une famille partageant le même logement, ou
- d'un groupe de personnes sans lien de parenté qui partagent le même logement.

Lieu de résidence habituel

Logement où vit habituellement la personne. La personne peut être :

- un membre de la famille
- un locataire
- un chambreur
- un pensionnaire
- un employé

Règles sur la composition du ménage

Les règles sur la composition du ménage servent à déterminer qui doit être inclus comme membre du ménage lors des questions démographiques. Certaines règles identifient les personnes qui ne doivent pas être incluses (par exemple, les visiteurs étrangers).

Pour être inclus dans la liste des membres d'un ménage, le répondant doit :

- **considérer le logement comme son lieu de résidence habituel,**

ou

- **habiter le logement pendant la période d'enquête et ne pas avoir de lieu de résidence habituel ailleurs.**

Énumérer **toutes** les personnes qui considèrent le logement choisi comme leur lieu de résidence habituel.

PERSONNES PRÉSENTES DANS UN LOGEMENT QUI DOIVENT ÊTRE INCLUSES ET FAIRE PARTIE DE LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE

Les immigrants reçus qui ont une résidence au Canada

Les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui remplissent les critères suivants :

- membres à temps partiel (des réserves) des FAC;
- employés civils du ministère de la Défense nationale;
- membres vivant dans un ménage avec d'autres personnes qui ne font pas partie des FAC

Étudiants

- Les étudiants célibataires sont inclus dans le logement de leurs parents s'ils y ont passé 30 jours ou plus au cours des 12 derniers mois. Sinon, ils sont inclus dans le logement qu'ils occupent pendant la période d'enquête.

Pensionnaires d'institutions

- Les personnes qui résident dans une institution depuis moins de six mois et qui considèrent le logement sélectionné comme leur lieu de résidence habituel.

Membres du personnel d'une institution et leur famille

- Les personnes qui déclarent que l'institution est leur domicile et qui n'ont pas d'autre lieu de résidence habituel.
- Ceci inclut les propriétaires (et leurs familles), employés (et leurs familles) ou époux(se) des patients/résidents qui vivent en institution.

Personnes ayant deux logements

- Les personnes qui ont un domicile au Canada et un second domicile à l'extérieur du Canada sont considérées comme résidents habituels de leur logement au Canada.
- Les personnes qui ont deux logements au Canada, si elles occupent le logement choisi la majeure partie de l'année.

Personnes mariées

- Les personnes qui n'occupent actuellement pas le logement choisi de leur conjoint à cause de leur travail ou de leurs études.

Enfants de parents séparés ou divorcés

- Les enfants qui vivent en garde partagée chez les deux parents (c.-à-d., passent autant de temps avec chaque parent) devraient être considérés comme étant des résidents habituels du logement s'ils sont présents dans ce ménage au moment de dresser la liste des membres du ménage.
- Les enfants de parents séparés ou divorcés qui passent plus de la moitié de leur temps dans la résidence choisie.

PERSONNES PRÉSENTES DANS UN LOGEMENT QUI DOIVENT ÊTRE INCLUSES ET FAIRE PARTIE DE LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE, suite

Résidents non permanents

- Les résidents non permanents (RNP) sont des personnes qui résident au Canada et qui ne sont ni citoyens canadiens ni immigrants reçus. Ils sont :
  - o des personnes qui demandent le statut de réfugiés;
  - o des étudiants étrangers qui fréquentent un établissement d'enseignement au Canada en tant que titulaires d'un visa d'étudiant;
  - o des étrangers qui séjournent au Canada en tant que titulaires d'un permis de travail;
  - o des titulaires d'un permis ministériel les autorisant à résider au Canada;
  - o des personnes qui appliquent pour le statut d'immigrant reçu et qui sont commanditées par un membre de leur famille qui a déjà reçu ce statut;
  - o des personnes à la charge de gens faisant partie de l'une ou l'autre des quatre catégories précédentes et qui ne sont pas nées au Canada.

RÉPONDANTS PRÉSENTS DANS UN LOGEMENT ET QUI NE DOIVENT PAS FAIRE PARTIE DE LA LISTE DES MEMBRES DU MÉNAGE

Résidents étrangers

- Les représentants de gouvernements étrangers et leur famille
- Les visiteurs étrangers

Étudiants

- Les étudiants célibataires qui ont passé moins de 30 jours au cours des 12 derniers mois au logement de leurs parents

Membres des Forces armées canadiennes

- Les membres à temps plein des Forces armées canadiennes (les étudiants inscrits à un programme de formation des officiers administré par les FAC sont considérés comme membres des FAC régulières)
- Les personnes qui ont terminé leur service militaire à temps plein depuis au plus 30 jours

Nota : Si des membres des FAC ainsi que des civils vivent dans le logement choisi, les questions sur les données démographiques doivent être posées au sujet de tous les membres du ménage.

Personnes ayant deux résidences

- Les personnes qui ont deux logements au Canada et qui n'occupent pas le logement choisi pendant la majeure partie de l'année

Pensionnaires d'institutions

- Les personnes qui résident depuis au moins six mois dans une institution (par exemple, une prison ou un hôpital)

Personnes mariées

- Les personnes mariées qui occupent un logement sélectionné autre que celui de leur conjoint à cause de leur travail ou de leurs études.

Enfants de parents séparés ou divorcés

- Les enfants qui vivent en garde partagée chez les deux parents (c.-à-d., passent autant de temps avec chaque parent) ne devraient pas être considérés comme étant des résidents habituels du logement s'ils ne sont pas présents dans ce ménage au moment de dresser la liste des membres du ménage.
- Les enfants de parents séparés ou divorcés qui passent moins de la moitié de leur temps dans la résidence choisie

Protection de la vie privée et préoccupations des parents

Certains parents pourraient s'inquiéter lorsqu'on pose des questions délicates à leurs enfants de **12 à 17 ans**. Les étapes suivantes devraient les rassurer.

Étapes à suivre

Lorsqu'un enfant de **12 ans à 15 ans** est sélectionné pour l'enquête, les intervieweurs doivent :

1) **Obtenir la permission verbale du parent/tuteur avant de procéder à l'interview de l'enfant sélectionné**. Un nouveau module fut ajouté au bloc Entrée du questionnaire. Quand le répondant sélectionné est âgé de moins de 16 ans, un consentement verbal doit être obtenu d'un parent ou tuteur. Si ce n'est possible, vous devez appuyer sur le <F10> afin de sortir du questionnaire et poursuivre avec un rendez-vous ou un autre code de résultat approprié parmi les codes 23, 24 et 25.
2) **Respecter la vie privée.** Si l'intimité ne peut pas être maintenue lors de l'interview avec un jeune, au téléphone (quelqu'un d'autre écoute sur la ligne téléphonique), le cas doit être codé comme un refus avec une note permanente expliquant que la confidentialité ne pouvait être respectée.
3) **Si le parent/tuteur est hésitant à donner son consentement au partage et couplage ;** l'intervieweur doit expliquer l'importance de l'enquête et comment les données seront utilisées pour aider les enfants.
4) **Si les parents désirent plus de renseignements concernant le** genre **de questions posées au cours de l'enquête ;** l'intervieweur peut leur dire de se reporter aux sujets d'enquête énumérés dans la Note aux parents. Si le parent/tuteur désire obtenir le texte des questions, une copie de cette version informatisée sera toutefois disponible dans les bureaux régionaux. Le personnel du bureau régional devra envoyer une copie aux parents dès que possible.
5) Si l'enfant est âgé de moins de 14 ans, les parents seront demandés la permission de **partager** l'information recueillie et si l'enfant est âgé de moins de 18 ans, les parents seront demandés la permission de **coupler** l'information recueillie.
6) **Certaines questions doivent être répondues par un parent ou tuteur**. Le module "PMK" (La personne la mieux renseignée auprès du ménage) est introduit pour les cas de répondants âgés de moins de 18 ans. Pour les répondants de 12 à 17 ans sélectionnés dans la base de la PFCE, l'enquête demandera à la PMR de répondre à certains modules avant la fin de l'interview. Dans de rares cas, lorsque le ménage ne comprend pas de personne de plus de 17 ans, on saute le module de la PMR et on considère que le répondant peut répondre aux questions sur le ménage.

Notes essentielles

Une note essentielle sert à relever des erreurs démographiques particulières qui ont une incidence sur la qualité des données. Les notes essentielles commencent par trois astérisques (***) et sont entrées dans les notes permanentes.

Les seules utilisations acceptables des notes essentielles sont les modifications apportées au répondant sélectionné :

- Nom
- Sexe
- Âge
- Date de naissance
- Relation avec les autres membres du ménage

La modification de l'information sur le numéro de carte d'assurance-maladie, l'adresse, le code postal ou le numéro de téléphone (y compris le téléphone cellulaire) ne constitue pas une note essentielle.

Ces corrections peuvent être entrées dans les notes permanentes sans les trois astérisques initiaux.

Il est important que les intervieweurs n'utilisent les notes essentielles qu'au besoin, ce qui aide à isoler les erreurs démographiques cruciales dans les données, qui sont mises à jour plus tard dans le processus.

Transfert de cas des ITAO aux IPAO

Pendant chaque phase, des cas seront transférés des ITAO aux IPAO.

Le code de résultat 68 sera utilisé pour transférer des cas des ITAO aux IPAO. Le code 68 s'applique **uniquement** aux répondants ITAO de 18 ans et plus (de la base aréolaire).

Il n'y aura pas de transferts de la base de la PFCE et pas de transferts des IPAO aux ITAO.

Les cas de 18 ans et plus des ITAO ayant le code final 02, 03 ou 05 recevront ***automatiquement** le code final 68 et seront transférés aux IPAO. Votre superviseur vérifiera les cas portant le code 29 et leur attribuera manuellement le code 68. Les cas portant le code 68 seront annulés dans les ITAO.

Le secteur spécialisé approuvera certains cas ayant reçu le code final 04, 11, 12, 13 ou 15 en vue d'un transfert.

Nota : *Si aucun autre numéro de téléphone n'est disponible.

Retour au numéro de téléphone 1

Une mise à jour a été apportée à l'échantillon de 18 ans qui comporte plusieurs numéros de téléphone. Cette mise à jour tient compte de l'ajout de la fonction arrêter-transférer dans l'ESCC 2015.
Une fois que la fonction arrêter-transférer est activée (mise en fonction), voici ce qui se produit pour les cas qui passeront au numéro de téléphone 2 (TELNUM2) parce qu'il n'y a pas eu de contact au numéro de téléphone 1 (TELNUM1) :

- Si le TELNUM2 a le code de résultat 2, 3 ou 5, l'application reviendra au TELNUM1.
- Le TELNUM1 continuera d'être composé jusqu'à ce que le cas soit résolu ou jusqu'à la fin de la période de collecte (si le TELNUM1 a le code de résultat 2, 3 ou 5, il sera envoyé comme code final.

Cela a été programmé dans l'application; il vous faudra simplement suivre le numéro de téléphone fourni à l'écran.

Phases de la collecte

Phase 1 – premier mois de la période de collecte :

- La collecte commence pour toutes les régions urbaines et certaines régions rurales des ITAO et des IPAO;
- Les ITAO relèvent les cas pour le dépistage ou le transfert aux IPAO;
- Les cas sont transférés aux IPAO pendant la nuit;
- Les IPAO reçoivent et attribuent les cas transférés;
- Les IPAO planifient la collecte dans les régions rurales où la collecte n'est pas commencée.

Nota : À la fin de la phase 1, il faut essayer chaque cas ITAO **au moins cinq fois.**

Phase 2 – deuxième mois de la période de collecte :

- Les ITAO continuent de relever les cas à transférer aux IPAO;
- Les IPAO sont en mode de collecte complète (toutes les régions rurales et urbaines);
- Les transferts des ITAO aux IPAO se poursuivent;
- Le dépistage continue;
- Les IPAO continuent d'accepter et d'attribuer les cas transférés.

Nota : À la fin de la phase 2, il est recommandé d'essayer chaque cas des ITAO **au moins 20 fois.** Tous les cas des ITAO à transférer aux IPAO seront relevés avant la fin de la phase 2.

Phase 3 – les quatre dernières semaines de la période de collecte :

- La collecte se poursuit pour les ITAO et les IPAO;
- Le secteur spécialisé relève les cas à transférer pour améliorer les taux de réponse dans les régions urbaines, au besoin.

Nota : Les transferts visant à améliorer les taux de réponse doivent être effectués avant la fin de la semaine 1 durant le troisième mois de la période de collecte. Tous les autres transferts ayant dépassé cette date limite doivent être approuvés par le secteur spécialisé.

ITAO – Importance de 5 et 20 tentatives

Pourquoi demandons-nous cinq tentatives avant la fin du premier mois et 20 tentatives avant la fin du deuxième mois?

Plus les tentatives d'appels exigés sont faites tôt par les ITAO pendant la période de collecte, plus on peut repérer rapidement les cas comportant un problème lié au numéro de téléphone et les transférer aux intervieweurs IPAO. Plus vite les intervieweurs IPAO reçoivent les cas transférés, plus ils ont le temps d'y travailler et de les résoudre à titre de répondants ou de les résoudre parce qu'ils sont hors champ. Selon les recherches menées au cours de l'ESCC 2015, faire cinq tentatives avant le premier mois et 20 avant la fin du deuxième mois permet d'obtenir des réponses/répondants.

Interview délicate

Les étapes suivantes devraient vous aider à vous sentir à l'aise, tout comme le répondant, quand vous recueillez des données pour des questions de nature délicate.

Lecture des questions délicates

Lisez toute question délicate de façon claire et avec confiance.

Posez toute question délicate ou embarrassante de la même façon que les autres questions. La plupart des répondants vont répondre facilement, librement et honnêtement à ce genre de questions, en partie parce qu'ils se rendent compte que nous avons des raisons scientifiques importantes de les poser, et en partie parce que nos intervieweurs traitent ces questions avec la même absence d'émotivité et la même neutralité que dans le cas de toutes les autres questions.

Mais ce qui est encore plus important, vous devez veiller à ne pas donner l'impression de manifester une curiosité indue.

Surveillez votre vocabulaire. Utilisez des mots objectifs et neutres. Si un répondant utilise des mots crus pour répondre aux questions, ne les utilisez pas à votre tour. En utilisant des termes neutres, comme «les cycles menstruels», vous finirez par amener le répondant à utiliser vos propres mots. Ne riez pas et ne prêtez pas attention à des blagues ou à des plaisanteries de mauvais goût ou de nature trop personnelle. Gardez le silence pour indiquer au répondant que ce genre d'interaction ne fait pas partie de votre recherche. Votre image doit être celle d'un professionnel sérieux qui fait un travail de recherche tout aussi sérieux. Cela ne devrait pas vous empêcher de faire la distinction entre une remarque faite avec bonne humeur par un répondant un peu nerveux et une blague qui est tout simplement de mauvais goût.

Réactions émotives du répondant et votre rôle

Ne soyez pas surpris si un répondant réagit de façon émotive durant l'interview et se met à rire ou même à pleurer lors de certaines questions. Gardez votre attitude professionnelle et amicale et continuez de poser des questions, afin de ramener l'attention du répondant sur la tâche. Proposez une courte pause, afin de permettre au répondant de prendre un mouchoir ou un verre d'eau s'il a été emporté par l'émotion. Laissez-lui quelques minutes pour retrouver le calme et poursuivez ensuite l'interview.

Souvenez-vous que les mots ne sont pas toujours nécessaires. Le silence et la pause sont quelques fois d'excellents outils et témoignent d'un respect envers le répondant. Si le répondant est trop troublé ou ému pour continuer, demandez de fixer un nouveau rendez-vous pour terminer l'interview.

Rappelez-vous qu'une enquête sur la santé utilise les mêmes techniques que les autres enquêtes. De plus, comme vous le savez, l'échantillon pour cette enquête est la population générale. Les répondants seront les mêmes que pour les autres enquêtes sur lesquelles vous travaillez habituellement.

Ne faites pas de commentaires ou n'évoquez pas spontanément des expériences personnelles même si le répondant vous le demande. Établissez un rapport harmonieux, mais non un lien d'amitié. Rappelez-vous si le répondant souhaite parler à quelqu'un ou a besoin d'autres ressources, veuillez le référer à la ligne provinciale d'information sur la santé (info-santé). Vous pourriez être tenté de continuer la discussion après l'interview, mais vous devez vous souvenir que vous êtes un intervieweur professionnel de Statistique Canada.

Items de non-réponse

À l'image de toutes les enquêtes volontaires, les répondants ont le droit de refuser de répondre à une question à n'importe quel moment pendant l'interview. Nous essayons de réduire au minimum les items de non-réponse pour maintenir la qualité des données, mais nous devons aussi être sensibles aux répondants dans le contexte d'une enquête sur la santé.

Si le répondant devient visiblement très vexé, hésite ou n'est pas disposé à répondre à une question spécifique ou un groupe de questions dû à la nature du contenu, utilisez votre meilleur jugement en inscrivant une non-réponse et passez à la prochaine question. En étant conscient de l'information fournie dans cette section et pendant la formation, vous devriez être capable de faire la distinction entre un refus «typique» et un refus amené par la détresse émotionnelle ou un autre type de détresse.

Nota : Les intervieweurs ne devraient pas inscrire un item non-réponse de leur propre initiative. Offrez toujours au répondant l'option de répondre avant de passer à la prochaine question. Si une question ou un groupe de questions est sauté dû à la détresse émotionnelle, inscrivez une remarque (F4) ou une note permanente qui indique la raison du refus.

Ressources pour le répondant

A tout moment, si le répondant demande de l'aide pour des troubles alimentaires, vous pouvez lui suggérer de consulter son médecin ou un autre professionnel de la santé.

Vous pouvez également fournir le numéro de téléphone provincial (sans frais) d'information sur la santé (voir ci-dessous).

Lignes d'écoute téléphonique disponibles 24h/24 par province :

Province:	Organisation:	Numéro:
Colombie-Britannique	HealthLinkBC Info SantéCB	8-1-1 7-1-1 (ATS)
Alberta	HEALTHLink Alberta Info Santé Alberta	1-866-408-5465 Edmonton : 780-408-5465 Calgary : 403-943-5465
Saskatchewan	HealthLine/ Ligne santé	8-1-1 1-888-425-4444 (ATS)
Manitoba	Health Links/ Info Santé	1-888-315-9257 Winnipeg : 204-788-8200
Ontario	Télésanté Ontario	1-866-797-0000 1-866-797-0007 (ATS)
Québec	Info-Santé	8-1-1 *(non applicable à Terres-Cries-de-la-Baie-James ou Nunavik)*
Nouveau-Brunswick	Tele-Care/Télé-Soins	8-1-1 1-866-213-7920 (ATS)
Île-du-Prince-Édouard	N/A	N/A
Nouvelle-Écosse	Healthlink/Info Santé	8-1-1 7-1-1 (ATS)
Terre-Neuve	Healthline /Ligne santé	1-888-709-2929 1-888-709-3555 (ATS)

Au Québec, vous pouvez donner le numéro de téléphone du «Centre local de services communautaires (CLSC)» le plus proche.

ITAO

Introduction

Dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), la composante de dépistage servira à retrouver les répondants qui n'ont qui n'ont pu être joints au moyen des numéros de contact du bureau central.

Le dépistage sera autorisé uniquement dans les conditions suivantes :

1. Un enfant doit avoir été présélectionné comme répondant de la base de sondage de l'ESCC pour le cas.
2. Tous les numéros de téléphone donnés pour le cas doivent être épuisés avant que le dépistage ne puisse avoir lieu. Les cas pour lesquels un enfant a été présélectionné comme répondant peuvent avoir jusqu'à quatre numéros de téléphone.
3. Un maximum de 10 minutes par cas est autorisé pour le dépistage.

Qui fait l'objet d'un dépistage.

Les personnes suivantes devraient être dépistées :

- Le parent/tuteur des répondants sélectionnés qui ne peut pas être joint
- Les membres du ménage peuvent être dépistés pour trouver le répondant.
- Le répondant qui vit de façon autonome/seul.

Action durant le dépistage

Nous procéderons comme suit durant le dépistage d'un cas :

SI…	**et/,mais …**	**alors…**
Le parent /tuteur a déménagé à l'intérieur de Canada.	... l'enfant sélectionné a déménagé avec le parent/tuteur	…dépister le parent/tuteur et mener l'interview (incluant le Yukon, TNO et le Nunavut). Mettez à jour l'adresse dans la composante de l'entrée.
Le parent /tuteur a déménagé à l'extérieur de Canada.	... l'enfant sélectionné a déménagé avec le parent/tuteur	...ne pas dépister. Le cas est considéré hors champ pour l'ESCC.
Le parent /tuteur n'a pas déménagé.	... l'enfant sélectionné a déménagé par ex, le collège, famille d'accueil, adoption ou vit seul	…dépister l'enfant et mener l'interview Mettez à jour l'adresse dans la composante de l'entrée.
Le parent /tuteur a changé de numéro de téléphone.		…dépister le parent/tuteur et mener l'interview.

Action durant le dépistage (suite)

Le dépistage **ne doit pas** être effectué dans les cas suivants :

- L'enfant a quitté le Canada
- L'enfant est décédé
- L'enfant a été institutionnalisé (famille d'accueil)

Si le répondant choisi est absent pour la durée de la collecte et ne peut être joint par téléphone, **vous devez** coder ce cas 20 Final (Absent pour la durée de l'enquête). Ne pas interviewé un autre membre du ménage par procuration.

Cas envoyé au dépistage

Les cas sont automatiquement envoyés au dépistage par l'application si le cas a été codé 2, 3 ou 5 et n'a pas d'autres numéros de téléphone.

Certains cas peuvent aussi être envoyés au dépistage manuellement par l'intervieweur si le code 30 a été sélectionné dans la composante de « sortie » (OC-N02).

Nota : Un cas ne doit pas être envoyé au dépistage si un nouveau numéro a été obtenu lors du contact avec ce répondant. Ce nouveau numéro doit être soumis au bloc TRA (information dépistage) et sera donc mis à jour le lendemain. Dès que cette information est mise à jour dans le bloc TRA, vous ne devez pas y accéder la journée même, car cette information sera perdue.

Légalité de l'utilisation des données obtenues de sources publiques

Il n'est pas nécessaire de confirmer les numéros de téléphone obtenus des personnes-ressources durant le dépistage.

L'adresse et le numéro de téléphone peuvent servir au dépistage, même s'ils n'ont pas été obtenus d'une source publique. Par exemple, une adresse ou un numéro de téléphone fourni, ou obtenu, pour un répondant choisi ou un membre de la famille, peuvent tenir lieu de point de contact pour dépister une PC ou un membre de la famille, même si la source n'était pas publique. L'adresse ou le numéro de téléphone peuvent désigner une résidence, une entreprise, etc.

Confidentialité

Le nom des membres du ménage est affiché dans la case « Démographie » au bas de l'écran de la fonction de dépistage.

Durant le dépistage, vous pouvez utiliser ces renseignements personnels pour confirmer un répondant, sans divulguer aucune autre information.

Par exemple, vous NE POUVEZ PAS divulguer le nom des membres d'un ménage à un répondant ou à une source de dépistage. Toutefois, lorsque vous devez confirmer que vous parlez à la bonne personne, vous pouvez poser une question du genre « Quel est le nom de votre époux(se)? … âge de votre époux(se)?… » etc.

IMPORTANT

La date de naissance du répondant et le nom de l'enquête ne doivent JAMAIS être divulgués.

3. Questionnaire

Dans ce chapitre Le présent chapitre comporte les sections suivantes :

Page

Aperçu du questionnaire 3-2
Introduction 3-2
Disposition 3-2
ITAO du module Entrée 3-3
Coordonnées 3-4
Plusieurs numéros de téléphone (ITAO seulement) 3-5
IPAO par téléphone 3-5
Aperçu du questionnaire - Entrée 18+ 3-6
Introduction 3-6
Nombre de multiples (MU) 3-6
MU_N01 3-6
Logements multiples 3-6
Contact (CN) 3-7
Aperçu du questionnaire - Entrée 12-17 3-19
Aperçu du questionnaire - Modules sur la santé 3-28
Introduction 3-28
Modules des questions sur la santé et socio-démographique (C2) 3-28
Guide des modules 3-28
Format des questions 3-28
Numérotage des questions 3-29
Refus / Ne sait pas 3-29
Introduction 3-29
Modules thématiques pour 2016 3-30
Modules communs pour 2016 3-31
Modules optionnels pour 2016 3-32
Aperçu 3-38
Nouveaux modules pour 2016 3-38
Réponse rapide 3-38
Modules avec des instructions particulières 3-39
Glossaire 3-40
Blessures (INJ) 3-46
Introduction 3-46
Aperçu du questionnaire - Sortie 3-91
Aperçu 3-91
Introduction 3-91

Aperçu du questionnaire

Introduction

Ce chapitre vous servira de guide en ce qui concerne le contenu du questionnaire de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC). Il est conçu pour être utilisé comme outil de référence pendant les entrevues. Ce chapitre présente de nouveaux concepts, donne des définitions de termes et explique comment recueillir l'information requise. Il contient aussi de nouveaux modules et des questions qui sont assortis de directives particulières aux fins d'examen.

Le questionnaire est automatisé et comprend tous les outils requis pour la prise de contact avec les répondants et le bon déroulement des interviews, l'établissement d'une liste des membres du ménage et la sélection de répondants, l'attribution de codes de résultat final et en cours des cas.

Les attributs et la conception de l'écran sont semblables à ceux d'autres enquêtes informatisées Blaise de Statistique Canada telles que l'Enquête sur la population active (EPA) et l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).

Veuillez vous référer au glossaire (Annexe A) pour les définitions de terminologie et concepts.

Disposition

Le questionnaire de l'ESCC comporte trois sections principales :

1. Entrée (contact/démographie)
2. Modules des questions sur la santé et sociodémographiques
3. Sortie

Chacune de ces sections est expliquée dans les pages suivantes.

ITAO du module Entrée

Une seule application de collecte sera installée pour les ITAO. Elle comprendra un échantillon de la base aréolaire et de la base de la PFCE (les répondants de 12 ans et plus), de toutes les provinces et tous les territoires. Une entrée différente est utilisée pour chaque unité d'échantillonnage (logement et personne). Le numéro d'échantillon peut être utilisé pour identifier l'unité d'échantillonnage.

Unité d'échantillonnage	N° d'échantillon
Logement (base aréolaire)	00131050070020_8001N
Personne (base de la PFCE)	C2016010000001_8001N

*Veuillez noter que le numéro de l'échantillon des unités provenant de la PFCE commencera avec un 'C'.

Cheminement de l'Entrée du questionnaire par base :

PFCE : 12-17 (ITAO seulement)	ARÉOLAIRE 18+ (ITAO et IPAO)
Communiquer avec le parent/tuteur désigné ou un membre adulte du ménage	Communiquer avec un membre adulte du ménage
- confirmer que vous avez joint le répondant présélectionné (nom, adresse, âge)	- confirmer que vous avez joint la bonne adresse
- remplir les données démographiques avec un membre adulte du ménage	- déterminer si le logement est admissible au moyen des modules AIS, INST, COLL et DW
- déterminer si le répondant présélectionné est admissible à l'enquête	- remplir les données démographiques avec un membre adulte du ménage
- demander la permission parentale d'interviewer les enfants de 12 à 15 ans	- demander à parler au répondant sélectionné au hasard
- remplir le(s) module(s) sur les relations avec le répondant	- remplir le(s) module(s) sur les relations avec le répondant
- mener l'interview avec le répondant présélectionné	- mener l'interview avec un répondant sélectionné au hasard
- ou prendre rendez-vous pour rappeler plus tard	- ou prendre rendez-vous pour rappeler plus tard

Coordonnées

Afin d'optimiser la probabilité de joindre une personne ou un ménage sélectionnés, les intervieweurs reçoivent plusieurs formes de coordonnées.

- Une adresse de listage pour chaque logement sélectionné
- Le nom et l'adresse du parent/tuteur du répondant présélectionné dans la base de la PFCE
- Plusieurs numéros de téléphone, y compris les téléphones cellulaires
- Le dépistage des répondants sélectionnés à partir de la base de la PFCE, mais seulement après avoir essayé tous les numéros de téléphone donnés.

Les coordonnées fournies pour chaque cas sont basées sur l'unité d'échantillonnage ou le type de base.

Logement (Base aréolaire)	(Personne) Base de la PFCE
Maximum de deux numéros de téléphone, y compris les téléphones cellulaires (ITAO 18+)	Maximum de quatre numéros de téléphone, y compris les téléphones cellulaires (ITAO 12-17)
Adresse de listage du logement (ITAO 18+, IPAO)	Nom et adresse du répondant présélectionné et du parent/tuteur
Pas de dépistage	Dépister le parent/tuteur du répondant présélectionné

Nota : Les téléphones cellulaires sont maintenant admissibles pour l'ESCC. Consultez votre manuel des OES, chapitre 2-15, section I et section II, pour les politiques et lignes directrices de Statistique Canada sur les téléphones cellulaires – ce sont les mêmes pour les IPAO et les ITAO.

Plusieurs numéros de téléphone (ITAO seulement)

L'échantillon ITAO de la base aréolaire (qui englobe la population de 18 ans et plus) comportera un maximum de deux numéros de téléphone.

L'échantillon ITAO de la base de la PFCE (qui englobe la population de 12 à 17 ans) comportera un maximum de quatre numéros de téléphone.

On estime que 65 % de l'échantillon aura seulement un numéro de téléphone.

Les numéros de téléphone seront programmés dans l'application, et l'intervieweur utilisera celui qui apparaît à l'écran. Le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran dépend du nombre de numéros de téléphone disponibles pour une unité et du nombre maximum de tentatives permises par numéro de téléphone.

Ce tableau indique le nombre maximum de tentatives cumulatives en fonction du nombre de numéros de téléphone disponibles et du nombre d'unités prévu.

Nombre de numéros de téléphone	Tel 1	Tel 1 & 2	Tel 1, 2 & 3	Tel 1, 2, 3 & 4	Nombre d'unités prévu de 18+	Nombre d'unités prévu de 12 à 17 ans	Nombre total d'unités prévu
1	40				49,600	7,700	57,300
2	15	40			30,400	900	31,300
3*	20	30	40			<100	<100
4*	20	30	35	40		<100	<100

* s'applique seulement aux cas de la base de la PFCE lorsqu'il y a lieu

IPAO par téléphone

Nota : Les IPAO peuvent être effectuées par téléphone uniquement après le contact initial en personne.

Introduction

Cette section traite de la composante Contact / démographie ou Entrée pour les cas IPAO et ITAO de la base de sondage aréolaire (pour les 18 ans et plus). Certains modules / questions seront demandés pour les deux environnements IPAO et ITAO. D'autres seront demandés soit pour IPAO ou ITAO. Les doubles astérisques sont utilisés pour indiquer qu'un module s'applique à **uniquement à IPAO** ou **uniquement à ITAO**.

Un aperçu et la première question pour chaque module d'Entrée sont fournis ci-dessous à l'exception des nouveaux / importants modules où toutes les questions sont fournies.

L'intervieweur sera exposé à l'ensemble des modules / questions en remplissant les simulations d'entretiens complets en cours de formation.

Nombre de multiples (MU)

MU_N01

Dans ce module, l'application IPAO demandera aux intervieweurs s'ils aimeraient créer des multiples.

INTERVIEWEUR : Voulez-vous créer des multiples?

1. Oui
2. Non

Dans l'affirmative, on vous demandera d'entrer le nombre de multiples à produire.

IPAO seulement

Logements multiples

Les logements multiples sont ceux qui ne sont pas indiqués sur votre liste de tâches, mais qui font partie d'une structure indiquée sur votre la liste d'assignation.

À chaque fois qu'un logement multiple non-listé est découvert sous un logement qui figure sur la liste, on devrait y **compléter une interview comme un logement séparé**. Pour ce faire, on doit générer un nouveau cas par l'entremise de l'application.

Il existe deux façons d'identifier les logements multiples dans l'application. Le logement multiple peut être :

- Identifié visuellement par l'intervieweur lorsqu'il entre dans le logement ou par l'extérieur (par exemple, un compteur d'électricité supplémentaire à l'extérieur du logement ; adresse est soit A ou B ; il est évident que la nouvelle adresse ne figure pas sur le listage et la maison est divisée en deux appartements) Ceci est rapporté par une question à l'intervieweur dans la composante Entrée (MU_N01).
- Identifié par le répondant dans le logement principal pendant l'interview. Ceci est rapporté par l'entremise d'une question (LQ_Q01) au répondant à la composante Sortie.

  Nota : **Les multiples sont en IPAO seulement**

Contact (CN)

Le bloc Contact contient les questions qui sont utilisées chaque fois qu'un cas est sélectionné comme contact. Un en-tête contenant les coordonnées du ménage sera affiché en haut de l'écran. Par exemple :

Répondant sélectionné	
Numéro de téléphone	**(613) 321-1234**
Adresse:	**12 MINSK AVENUE, APT. 310**
	KINGSTON, ON
	K1A 1A1

CN_N01

Les intervieweurs consigneront la méthode d'interview et indiqueront s'ils ont établi le contact.

INTERVIEWEUR : Enregistrez la méthode de l'interview

1. Par téléphone
2. En personne

CN_N01 pour CAPI seulement.

CN_N02

INTERVIEWEUR : Avez-vous établi le contact?

1. Oui
2. Non

Introduction de l'intervieweur (II)

Les intervieweurs doivent se présenter en utilisant leur prénom et leur nom.

II_R01

Bonjour, je travaille à Statistique Canada. Mon nom est...

Répondant adulte (AR)

Ce module sert à déterminer si un adulte membre du ménage est disponible actuellement.

AR_Q01

Puis-je parler à un membre adulte du ménage?

Membre adulte : toute personne responsable qui demeure dans le logement sélectionné et qui est âgée d'au moins 15 ans - il est important que cette personne ait une assez bonne connaissance des caractéristiques et des activités des autres membres du ménage pour pouvoir fournir les renseignements demandés.

Rendez-vous répondant adulte (ARA)

Le bloc Répondant adulte - Rendez-vous contient les questions à poser lorsqu'il est impossible d'entrer en contact avec un répondant adulte.

ARA_Q01	**À quel moment un membre adulte du ménage serait-il disponible?** **Nota :** le bloc Rendez-vous (APP) est appelé à ARA_N02.
Répondant ciblé (TR)	Le bloc Répondant ciblé contient une question qui doit être posée lorsqu'il faut établir un contact avec un répondant en particulier. Ce bloc n'est appelé que lors des interviews téléphoniques, lorsque le nom du répondant à contacter est connu.
TR_Q01	**Puis-je parler à ^NOMREPONDANT?** 1. Oui, le répondant nous parle 2. Oui, le répondant est disponible 3. Non, le répondant n'est pas disponible 4. Non, le répondant n'est plus un membre du ménage 5. Numéro de téléphone inexact NSP, RF **ITAO seulement**
Répondant spécifique - Rendez-vous (SRA)	Le bloc Répondant spécifique - Rendez-vous contient les questions à poser lorsqu'il est impossible d'entrer en contact avec un répondant en particulier. Ce bloc n'est appelé que lorsque le nom d'un répondant à contacter est connu. Si le répondant est disponible au cours de la période de collecte, un rendez-vous sera pris. **Nota** : le bloc Rendez-vous (APP) est appelé à SRA_N02.
SRA_Q01	**J'aimerais parler à REPONDANT. À quel moment serait-REPONDANT disponible?**
Langue préférée (LP)	Le bloc Langue préférée contient des questions visant à déterminer la langue dans laquelle le répondant préfère être interviewé. Ce bloc propose un choix entre les deux langues officielles, ainsi qu'entre diverses langues non officielles.
LP_Q01	**Préférez-vous que je parle en français ou en anglais?**
Reprise de contact pour un rendez-vous (ARC)	Le bloc de Reprise de contact pour un rendez-vous contient des questions utilisées lorsque l'on rétablit un contact avec un répondant qui était incapable de compléter l'enquête.

ARC_R01	**Un de nos intervieweurs a contacté votre ménage récemment à propos de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. J'aimerais continuer là où nous nous étions laissés. [Comme vous le savez déjà, toutes les réponses que vous donnerez lors de cette enquête demeureront strictement confidentielles.]**
Reprise de contact avec un refus (REF)	Le bloc Reprise de contact avec un cas de refus contient les questions à poser lorsqu'on tente à nouveau d'établir un contact auprès d'un ménage qui a refusé de participer à l'enquête.
REF_R01	**Un de nos intervieweurs a contacté votre ménage récemment à propos de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.**
REF_R02	**Votre participation est essentielle afin que les résultats soient précis. Tous les renseignements recueillis pour cette enquête resteront strictement confidentiels.**
Contact initial (IC)	Ce module présente une introduction à l'enquête à l'intention des répondants et explique les objectifs de l'enquête, ainsi que les dispositions confidentielles.
IC_R01	**Je vous appelle au sujet de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Cette enquête permet de recueillir des renseignements reliés à la santé et au bien-être des Canadiens. Les résultats aideront les communautés ainsi que les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé à mieux comprendre et aborder des enjeux tels que :** • **l'accès aux services locaux de soins de santé et de soins à domicile;** • **les habitudes de vie ayant une incidence sur la santé; et** • **les problèmes de santé chroniques.**
Note:	Pour les cas ITAO ayant une adresse postale <u>incomplète</u> l'énoncé d'introduction sera différent. L'application générera automatiquement l'introduction appropriée.
IC_R01	**Je vous appelle au sujet de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Cette enquête porte sur la santé des Canadiens de toutes les provinces et territoires, sur les facteurs qui peuvent influencer leur santé et sur l'utilisation des services de soins de santé.** **Un des buts de l'enquête est d'obtenir des renseignements qui aideront à améliorer les programmes et les services de santé offerts dans votre région.**

IC_R01 (suite)	**Tous les renseignements recueillis pour cette enquête resteront strictement confidentiels. Votre information pourrait être utilisée par Statistique Canada à d'autres fins statistiques et de recherche.** INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.
Vérification en ITAO (MON)	Le module MON contient une seule question qui est appelée uniquement pour les interviews ITAO. L'unique question que contient ce bloc explique les raisons de cette surveillance durant l'interview.
MON_R01	**Il est possible que mon superviseur écoute cet appel aux fins de contrôle de qualité.** Cette personne peut être un intervieweur principal, un chargé de programme, un représentant du bureau central ou toute autre personne autorisée. S'assurer que les questions de l'enquête sont posées correctement, pour que la qualité des renseignements recueillis soit constante pour toutes les interviews. **Nota** : Cette information doit être répétée (ainsi que l'introduction à l'enquête) pour chaque nouveau répondant. **ITAO seulement**
Confirmation d'adresse de listage (Téléphone) (CLA)	Ce module est utilisé pour confirmer l'adresse de listage.
CLA_Q01:	**J'aimerais confirmer votre adresse. Est-ce :** **Nota :** Les intervieweurs IPAO confirment l'adresse par observation.
Vérification d'adresse postale (CHM)	Le module Vérification d'adresse postale est utilisé lors des interviews subséquentes quand l'adresse postale dans le fichier-échantillon de l'enquête est la même que l'adresse de listage confirmée/corrigée.
CHM_Q01:	**Est-ce que c'est aussi votre adresse postale?** **ITAO seulement**
Confirmez l'adresse de listage (personnel) (LA)	Confirmer l'adresse pour des entrevues personnelles. **IPAO seulement**
Adresse postale (MA)	Ce module confirme l'adresse postale pour les entrevues personnelles. Il permet de faire des corrections si l'adresse n'est pas la même que l'adresse de listage. **IPAO seulement**

Vérification du contact par téléphone (TC)

Le bloc Vérification du contact par téléphone sert à confirmer que l'intervieweur a contacté le bon ménage.

TC_Q01

J'aimerais m'assurer que j'ai composé le bon numéro.
S'agit-il du (000) 000-0000)?
ITAO seulement

Nouvelle adresse (NAD)

On appelle le bloc de Nouvelle adresse de l'intérieur d'autres blocs quand une adresse doit être recueillie.

Adresse dans le champ de l'enquête (AIS)
(18+ seul.)

Ces questions servent à déterminer si l'adresse échantillonnée se trouve dans le champ ou hors du champ de l'enquête et elles s'appliquent uniquement aux cas des répondants adultes dans la base aréolaire.

Dans la deuxième question, on demande au répondant si une personne utilise cette adresse comme domicile privé. Si le répondant répond Oui, un logement commercial ou saisonnier/secondaire sera considéré comme étant dans le champ de l'enquête.

Autrement, le cas sera considéré comme étant hors du champ de l'enquête et recevra automatiquement le code approprié.

AIS_Q02

Is this address for a private home, a business, an institution or seasonal (or secondary) dwelling?

1. Maison privée (Passez à DW)
2. Entreprise (Passez à AIS_Q04)
3. Les deux, maison privée et entreprise (Passez à DW)
4. Logements collectifs institutionnels (Passez à INST)
5. Logements collectifs non institutionnels (Passez à COLL)
6. Logement saisonnier (ou secondaire) (Passez à AIS_Q04)

DK, RF

AIS_Q04

Quelqu'un utilise-t-il cette adresse comme une maison privée?

1. Oui
2. Non

NSP/RF

Établissement Collectif (INST)

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de recueillir des données sur les établissements. Ce bloc contient des questions pour obtenir le nom et l'adresse d'un établissement. Les hôpitaux, les établissements pénitentiaires/de détention, les prisons et tous autres établissements précisés seront toujours hors du champ de l'ESCC.

Établissement Collectif (INST) (suite)

Les établissements pour personnes ayant une incapacité, les établissements de soins infirmiers, les établissements de soins pour enfants et mineurs et les établissements pour délinquants et jeunes contrevenants peuvent faire partie du champ de l'enquête si des propriétaires, des employés ou des conjoints des patients ou des résidents vivent dans l'établissement et n'ont pas d'autre lieu de résidence habituel.

Les résidences pour personnes âgées et les établissements religieux peuvent faire partie du champ de l'enquête si l'établissement ne fournit que peu ou aucun soin à ses résidents.

Les directives à l'intervieweur s'afficheront à l'écran pour obtenir une confirmation du répondant dans ces scénarios.

INST_Q01 **Quel est le nom de l'établissement?**

INST_B02 **Quelle est l'adresse de l'établissement?**

Nota : Ceci appelle le bloc d'adresse (NAD) pour capturer des informations d'adresse de l'institution.

INST_Q03 **De quel genre d'établissement s'agit-il?**

01.	Hôpital	(Auto Code 45) OOS
02.	Établissement pour personnes ayant une incapacité	(Passez à INST_Q04)
03.	Établissement de soins infirmiers	(Auto Code 45) OOS
04.	Résidence pour personnes âgées	(Passez à INST_Q04)
05.	Établissement religieux (p.ex. : monastère, couvent)	(Passez à INST_Q04)
06.	Établissement de soins pour enfants et mineurs	(Auto Code 45) OOS
07.	Établissement pour délinquants et jeunes contrevenants	(Auto Code 45) OOS
08.	Établissement pénitentiaire / de détention	(Auto Code 45) OOS
09.	Prison	(Auto Code 45) OOS
10.	Autre - Précisez	(Passez à INST_S03)
	NSP, RF	(Passez à INST_END)

INST_S03	**(De quel genre d'établissement s'agit-il?** INTERVIEWEUR : Précisez.
Collectif non-institutionnel (COLL)	Les intervieweurs devront préciser le type de logement et le nombre total de personnes qui l'habitent. **Nota :** Tous les logements collectifs non institutionnels feront partie du champ de l'enquête et ne devraient pas comprendre les types de logement institutionnel associés à la catégorie INST. Pour être comptée, une personne doit considérer le logement comme son lieu de résidence habituel ou demeurer dans le logement et n'avoir aucun lieu de résidence habituel ailleurs.
BLEA_N100	INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom de logement non-institutionnel collectif. Si nécessaire, demandez : **(Quel est le nom de logement collectif?)**
COLL_N01	Précisez le type de logement non institutionnel collectif (p.ex., maison de chambre, hôtel, motel, maison de chambre pour touristes, maison de repos, hôpital, résidence de personnel, camp de chantier, etc.) Si nécessaire, demandez : **(Précisez le type de logement.)**
COLL_Q02	**Quel est le nombre total de personnes qui habitent ici?** (Min : 1) (Max : 995) **Nota :** si un chiffre supérieur à 25 est entré, un message de vérification s'affiche
Type de logement (DW)	Dans un environnement IPAO, les intervieweurs sélectionneront le type de logement. Pour l'ITAO, les intervieweurs demanderont au répondant dans quel type de logement il habite. Si un intervieweur ou un répondant sélectionne les options établissement ou hôtel, maison de chambres/pension ou camp, l'application les dirigera au module AIS pour qu'ils sélectionnent soit le logement collectif institutionnel ou le logement collectif non institutionnel.

DW_Q01

Dans quel type de logement demeurez-vous? Est-ce un(e)... ?

1. **Maison individuelle**
2. **Maison double**
3. **Maison en rangée**
4. **Duplex**
5. **Immeuble d'appartements de moins de 5 étages**
6. **Immeuble d'appartements de 5 étages ou plus**
7. **Institution**
8. **Hôtel; maison de chambres / pension; camp**
9. **Maison mobile**
10. Autre - Précisez

NSP, RF

ITAO seulement

DW_N02
(Personnel)

INTERVIEWEUR : Choisissez le type de logement.

1. Maison individuelle
2. Maison double
3. Maison en rangée
4. Duplex
5. Immeuble d'appartements de moins de 5 étages
6. Immeuble d'appartements de 5 étages ou plus
7. Institution
8. Hôtel; maison de chambres / pension; camp
9. Maison mobile
10. Autre - précisez

NSP, RF

ITAO seulement

Information sur le ménage

Les renseignements démographiques pour chaque membre du ménage seront maintenant recueillis.

Membres habituels (USU)

USU_Q01

Veuillez nommer toutes les personnes qui demeurent habituellement ici.

Inscrivez le prénom suivi du nom de famille de chaque membre habituel du ménage. Commencez par les adultes qui ont des responsabilités au niveau des soins ou du support familial.

Au moment de dresser la liste des résidents d'un logement collectif, inscrivez les membres qui considèrent que le logement est leur résidence permanente ou qui sont présents et n'ont aucune autre résidence permanente à l'heure actuelle.

La liste peut compter un maximum de 20 noms. S'il y a plus de 20 résidents permanents, inscrire les 20 premiers de façon aléatoire.

Nota - Noms fictifs utilisés

ESCC n'acceptera plus des noms fictifs de la part des répondants.

Obtenir des répondants leurs nom et prénom réels devrait être une priorité et vous devriez faire **tout ce que vous pouvez** pour les obtenir. Les intervieweurs ne devraient jamais offrir aux répondants la possibilité de ne pas donner leur prénom ou leur nom de famille. Les intervieweurs devraient demander aux répondants leurs nom et prénom en lisant le questionnaire **tel qu'il figure dans la demande**.

Si le répondant est hésitant ou qu'il dit « non », les intervieweurs devraient tenter de découvrir quelles sont les préoccupations précises du répondant et apaiser ces préoccupations.

Si le répondant refuse catégoriquement de donner son nom (prénom ou nom de famille) et si les intervieweurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'obtenir, ils ne devraient **ni** créer **ni** entrer de nom fictif, et ils ne devraient jamais offrir ce choix à un répondant. Les intervieweurs devraient plutôt inscrire un « x » dans les catégories du prénom et du nom de famille, poursuivre l'interview et écrire une note permanente accompagnée de trois astérisques (***) pour indiquer qu'un nom fictif a été utilisé. **Il ne faut pas saisir de noms fictifs originaux, car cela peut entraîner des problèmes encore plus graves avec les données.**

Par exemple, s'il advenait que le répondant souhaite confirmer sa participation ou modifier ses données, nous devons avoir le bon nom pour pouvoir retracer les données. Si le répondant ne peut pas fournir le même nom que celui qui a été donné pendant l'interview, nous ne pouvons même pas confirmer qu'il a participé, et encore moins annuler son consentement au partage des données ou supprimer les données. En outre, nous avons besoin du bon nom pour effectuer un couplage d'enregistrements exact.

Notre taux de réussite pour le couplage d'enregistrements dans l'ESCC ne cesse de baisser en raison de l'utilisation de noms fictifs, malgré l'évolution de la technologie.

RS_Q04

Y a-t-il d'autres personnes qui demeurent ici habituellement, mais qui sont présentement absentes parce qu'elles sont aux études, à l'hôpital, ou ailleurs?

Âge sans date de naissance (ANDB)

Ce bloc est utilisé pour collecter l'âge des membres de la liste ou des répondants sans demander la date de naissance.

L'âge est un élément obligatoire, car il détermine les questions auxquelles le répondant aura à répondre. « Ne sais pas » et « Refus » ne sont pas des réponses valides.

Âge sans date de naissance (ANDB) (suite)	Si le répondant ne peut ou ne veut pas dire son âge, estimez-le vous-même. S'il ne connaît pas l'âge d'un autre membre du ménage, demandez-lui une estimation. Indiquez dans les Notes qu'il s'agit d'une estimation et inscrivez l'âge approximatif. **NOTE IMPORTANTE AUX INTERVIEWEURS** : Lorsque vous énumérez des jeunes âges de 17 ou 18 ans à la liste des membres du ménage, assurez-vous de **confirmer l'âge exact**. Il faut porter attention à cette question. Si le 18e anniversaire a déjà eu lieu, le jeune est donc âgé de 18 ans et est alors éligible pour l'enquête. Si le 18e anniversaire n'a pas encore eu lieu, le jeune **n'est pas** éligible si le cas provient de la base aréolaire. Il est possible qu'un enfant de 18 ans soit identifié par erreur comme ayant 17 ans ce qui le rendrait inéligible pour l'enquête. Si vous ajoutez un répondant âgé de 18 ans, un message de vérification s'affichera à l'écran pour vous demander de confirmer que sa date de naissance indique qu'il a 18 ans ou plus.
Sex (SEX)	Le bloc Sexe sert à recueillir de l'information sur le sexe du répondant.
État matrimonial sans confirmation (De-facto) (MSNC)	Ce bloc sert à recueillir de l'information sur l'état matrimonial social du répondant, lorsqu'il ne doit pas y avoir confirmation de tout état matrimonial recueilli précédemment. **Nota** : Cette question est posée aux répondants âgés de 16 ans et plus. Il est important que le répondant écoute la liste au complet avant de donner une réponse. Pour les partenaires du même sexe, vérifiez s'ils sont mariés ou vivent en « en union libre ».
MSNC_Q01	**Quel est votre état matrimonial? Êtes-vous…?** INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 1. **Marié (e)** 2. **En union libre** 3. **Veuf (ve)** 4. **Séparé (e)** 5. **Divorcé (e)** 6. **Célibataire, jamais marié (e)** NSP, RF
Plus haut niveau de scolarité (EHG2)	Ce bloc demande des détails relatifs au plus haut niveau de scolarité pour les membres du ménage âges de 14 ans et plus.
EHG2_Q01	**Quel est le plus haut niveau d'études primaires ou secondaires qu'il/elle a achevées?**

Forces armées canadiennes (CAF)	La question des Forces armées canadiennes est utilisée pour déterminer si le répondant est un membre à temps plein des Forces armées canadiennes régulières. Cette question sera posée aux personnes de 16 à 65 ans.
CAF_Q01	Est-ce que vous êtes est un membre à temps plein des Forces canadiennes régulières 1. Oui 2. Non **Nota :** Les membres à temps plein des forces armées régulières ne sont pas inclus dans cette enquête. Si tous les membres de la famille sont des membres des forces armées, l'entrevue se termine. Si certains membres du ménage sont FAC, tout le monde dans le ménage doit être indiqué, mais seulement ceux qui ne sont pas dans les forces seront éligibles pour la sélection.
Sign off Block (SO)	Ce module signale la fin de la composante ménage une fois que vous appuyez sur la touche < 1 >, vous ne serez pas en mesure de modifier les données de la matrice. **NOTE IMPORTANTE POUR LES INTERVIEWEURS** : Vous pouvez apporter des corrections en utilisant la flèche du haut avant d'appuyer sur < 1 >. Une fois que vous appuyez sur < 1 >, vous ne pouvez plus modifier la liste et les caractéristiques de la composition du ménage (par exemple, âge, sexe, relations, etc.) Si une erreur a été faite, vous devez entrer une note critique dans les notes permanentes. **Nota :** Voir page 3-4 pour le protocole sur les notes critiques.
Sélection du répondant	Pour cette partie de l'interview, le système choisit un répondant à même la liste de membres admissibles du ménage.
Selected respondent introduction (SRI) **(18+ only)**	**L'application choisira maintenant au hasard un membre de votre ménage âgé de 18 ans ou plus pour répondre aux questions d'enquêtes restantes.** **L'intervieweur n'a pas de contrôle sur la sélection du membre du ménage. La sélection des membres est effectuée automatiquement afin de s'assurer que l'enquête soit la plus précise possible (assure que l'échantillon soit une représentation juste de la population)** **Nota :** Le module SRI n'apparaît pas pour des ménages composés d'une seule personne.

Introduction de l'enquête (INT)	Ce bloc contient l'introduction à l'enquête, qui doit être lue au répondant.
INT_R02	**Votre participation est primordiale et vos réponses demeureront strictement confidentielles.**
Enregistrement audio (AREC)	Cette question sera posée dans le cadre du programme du contrôle de la qualité IPAO. Cette question est incluse avant le module Activité principale (MAC) pour les répondants âgés de 16 ans et plus. Le bout de cette question et de s'assurer que les questions de l'enquête sont posées correctement, pour que la qualité des renseignements recueillis soit constante pour toutes les interviews.
AREC_Q01	**Une partie de l'interview pourrait être enregistrée aux fins de contrôle de la qualité. Acceptez-vous qu'on vous enregistre ?** **Nota :** La question devrait être posée à chaque fois le cas est entré, et si 'l y a un changement de répondant (par exemple après le dressage de la liste des membres du ménage si une autre personne est sélectionnée pour l'enquête autre que la personne qui répond actuellement aux questions figurant sur la liste). **IPAO seulement**
	Fin de l'Entrée 18 ans et plus

Aperçu du questionnaire - Entrée 12-17

Introduction

La section Contact / Démographie constitue la première partie du questionnaire, appelée aussi « Entrée ». L'Entrée pour 12-17 utilise un grand nombre de modules / questions vus dans l'Entrée des 18et plus, mais il y a plusieurs modules / blocs qui sont utilisés spécifiquement pour 12-17. Questions à l'entrée 18+ ne sont pas répétées.

Nota : Cette section s'applique uniquement aux ITAO.

Contact (CN)

Le bloc Contact contient les questions qui sont utilisées chaque fois qu'un cas est sélectionné comme contact.

Un en-tête comprenant le nom, le sexe, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne de contact, et le nom âge et le sexe, le nombre de ré- répondants sélectionnés sera affiché en haut de l'écran. Par exemple:

CN_R02

Tuteur parental :	Jane Smith, F, 42
Répondant sélectionné :	Jeremy Smith, M, 13
Numéro de téléphone :	(613) 321-1234
Adresse:	12 MINSK AVENUE, APT. 310 KINGSTON, ON K1A1A1

INTERVIEWEUR : Avez-vous établi le contact?

II_R01

Bonjour, je travaille à Statistique Canada. Mon nom est...

Répondant ciblé ESCC (CTR

Pour déterminer si le parent ou le tuteur du répondant sélectionné est disponible. .

CTR_Q01

Puis-je parler à ……?

1. Oui, ^NOM_PARENT nous parle
2. Oui, ^ NOM _PARENT est disponible
3. Non, ^ NOM _PARENT n'est pas disponible
4. Non, ^ NOM _PARENT n'est plus un membre du ménage
5. Numéro de téléphone inexact

CTR_Q01 (suite)	**Nota :** Dans les cas où les répondants enfants sont tirés de la base de la PFCE, il y aura **toujours** un répondant ciblé comme premier contact puisqu'ils sont présélectionnés. Toutefois, avant de parler à l'enfant, l'intervieweur doit d'abord parler au parent ou au tuteur (aussi fourni dans la base de la PFCE). Dans ce bloc, on demande à parler avec le parent ou le tuteur. **ITAO 12-17 seulement**
Répondant ciblé (TR)	Le bloc Répondant ciblé contient une question utilisée lorsque le contact doit être établi avec un répondant ciblé. Le bloc de TR est appelé uniquement pour des entrevues téléphoniques lorsque le nom d'un répondant à contacter est disponible.
Répondant spécifique - Rendez-vous (SRA)	Le bloc Répondant spécifique - Rendez-vous (SRA) contient des questions utilisées lorsque le contact ne peut être établi avec un répondant spécifique. Ce bloc est appelé uniquement lorsque le nom d'un répondant à contacter est disponible. Si le répondant sera disponible à un moment donné au cours de la période de collecte de l'enquête, un rendez-vous sera fait. **Nota** : que le bloc commun de rendez-vous est appelé à SRA_N02.
Vérification du contact par téléphone (TC)	Le téléphone bloc de contrôle est utilisé pour confirmer que le bon foyer est contacté. **Nota** : Si le numéro de téléphone est erroné, l'enquête se termine et l'application demande à l'intervieweur de choisir un code de résultat approprié. Cependant, les cas de 12-17 ans peuvent avoir jusqu'à 4 numéros de téléphone que pour les intervieweurs puissent essayer de prendre contact avec l'enfant sélectionné. Si un autre numéro de téléphone est disponible, l'application en informe l'intervieweur et demande s'il veut relancer l'entrevue avec les nouvelles informations de contact.
Langue de préférence (LP)	Le module de langue de préférence contient des questions qui suscitent la langue préférée du répondant. Cela comprend la collecte de langues non officielles préférées ainsi que les deux langues officielles.

Répondant adulte (AR)	Ce module est utilisé pour déterminer si un membre adulte de la famille est actuellement disponible. Membre adulte : une personne responsable vivant dans le logement sélectionné qui est âgé d'au moins de 15 ans - il est important que ces personnes soient suffisamment informées sur les caractéristiques et les activités des autres membres de la famille pour qu'ils soient capables de fournir les informations demandées.
Rendez-vous répondant adulte (ARA)	Le bloc de Rendez-vous - répondant adulte contient des questions utilisées lorsque le contact ne peut être établi avec un répondant adulte. **Nota** : le bloc commun de rendez-vous est appelé à ARA_N02.
Reprise de contact avec un cas de refus (REF)	Le bloc Reprise de contact avec un cas de refus contient les questions utilisées lorsque le contact est rétabli avec un ménage qui a refusé de participer à l'enquête.
Reprise de contact pour un rendez-vous (ARC)	Le bloc Reprise de contact pour un rendez-vous contient les questions utilisées lorsque le contact est rétabli avec un répondant qui n'a pas pu terminer l'enquête.
Contact initial (IC)	Ce module fournit une introduction à l'enquête pour les répondants et explique les objectifs de l'enquête ainsi que des dispositions en matière de confidentialité. Ce bloc sera généré pour les répondants de tous les âges.
Vérification en ITAO (MON)	Le module MON contient une seule question et est appelé uniquement pour des interviews ITAO. Il fournit une raison pour le suivi de l'entrevue est menée.

Confirmation de répondant spécifique (SRC)

Avant de pouvoir commencer l'enquête à l'aide de la liste du ménage, ce bloc permet de déterminer si nous avons établi le contact avec la bonne personne. Les questions de ce bloc permettent de confirmer ce qui suit :

1. Si l'enfant sélectionné vit ou habite dans le logement
2. Si le logement se trouve dans une réserve indienne
3. L'âge de l'enfant
4. L'occasion de mettre à jour le nom ou le sexe de l'enfant, au besoin

ITAO 12-17 seulement

SRC_R01

CHILD_NAME a été sélectionné pour participer à notre enquête et dans le but de vérifier si nous avons trouvé le bon ménage, je dois vous poser quelques questions.

SRC_Q01

Est-ce que ^CHILD_NAME vit ou séjourne dans ce logement?

1. Oui
2. Non

NSP/RF

Nota : Si le parent ou le tuteur répond Oui, l'interview se poursuivra à la question IR_Q01, autrement elle se poursuivra à la question SRC_Q02.

IR_Q01

Ce logement est-il situé dans une réserve Première Nation?

1. Oui
2. Non

NSP/RF

Nota : Si le parent ou le tuteur répond Oui, l'interview se terminera puisque les réserves des Premières Nations sont hors du champ de l'ESCC; le code approprié sera automatiquement attribué au cas. Autrement, l'interview se poursuivra à la question SRC_Q03.

SRC_Q02

L'adresse de ^CHILDNAME a-t-elle déjà été :

^ADDRESS

1. Oui
2. Non

NSP/RF

Nota : Si le parent ou le tuteur répond Oui, l'application passera au module de raison du départ (RL). Autrement, l'interview se terminera et l'application utilisera le prochain numéro de téléphone pour établir un contact. S'il n'y a pas d'autre numéro de téléphone, le cas devrait passer au dépistage.

SRC_Q03

Nos dossiers démontrent que ^CHILDNAME est âgé(e) de XX ans, pouvez-vous le confirmer?

1. Oui
2. Non

NSP/RF

Intervieweurs ITAO : Vérification des enfants de 12 à 17 ans

Lorsque vous vérifiez l'âge des enfants de 12 à 17 ans, veillez à confirmer leur âge exact.

Il faut faire attention parce qu'il est possible qu'un enfant de 17 ans soit déclaré par erreur comme ayant 18 ans et, par conséquent, il **ne serait pas admissible** à l'enquête puisque seuls les enfants de 12 à 17 ans sont admissibles. Il est aussi possible qu'un enfant qui a « presque » 12 ans soit déclaré comme ayant 12 ans, alors qu'il n'a en fait que 11 ans et qu'il **ne serait pas admissible** à l'enquête, puisque ces cas sont hors du champ de l'enquête.

Nota : Si le parent ou le tuteur répond Oui, l'application passera aux modules de la mise à jour du nom (UN) et du sexe (SEX). Autrement, l'application passera à la question SRC_Q06A, à laquelle on demande si un autre adulte du ménage peut confirmer l'âge de l'enfant.

Intervieweurs ITAO : Enfants âgés de 11 ans

Il faut prêter attention à l'échantillon lorsque l'enfant présélectionné a 11 ans. Dans ce cas, l'intervieweur devrait consulter la date de naissance de l'enfant et attendre qu'il ait 12 ans avant de contacter le ménage. Puisque l'échantillon sera divisé par âge, la date de naissance de l'enfant correspondra probablement à la période de collecte si elle a été envoyée au secteur.

SRC_Q06A

Y a-t-il un autre adulte dans votre ménage qui pourrait fournir l'âge de ^CHILDNAME?

Si un autre adulte peut confirmer l'âge de l'enfant et qu'il est disponible, l'intervieweur doit demander à lui parler, et l'interview reprendra au début. S'il n'y a pas d'autre adulte disponible à ce moment là, il faut prendre rendez-vous pour rappeler plus tard. Pour toutes les autres réponses, il faut attribuer au cas un code de refus (code 80).

UN_N01 & UN_N02

Ce bloc donne aux intervieweurs la possibilité de mettre à jour les noms et prénoms du répondant, si nécessaire.

Le prénom et le nom d'origine de l'enfant sélectionné sera affiché sur l'écran.

SEX_Q01

INTERVIEWEUR : Inscrivez le sexe de ^ CHILD_NAME.

Si nécessaire, demandez : **(Est-ce que ^ CHILD_NAME est de sexe masculin ou féminin?) :**

1. Masculin
2. Féminin

Nota : Si le sexe entré dans cette question est différent de celui qui se retrouve dans l'échantillon, un message de vérification apparaît pour informer l'intervieweur que le sexe a été modifié.

ITAO 12-17 seulement

Raison du départ (RL)

Ce bloc sert à déterminer la raison pour laquelle une personne a quitté le ménage. Si l'enfant sélectionné ne vit pas actuellement au logement, mais qu'il y vivait à un moment donné, il faut demander au parent ou au tuteur la raison pour laquelle l'enfant a déménagé.

RL_Q01

Pourquoi ^CHILDNAME ne fait-il/elle plus partie de ce ménage?

1. Changement d'état matrimonial (s'est marié / séparé)
2. Pour suivre un conjoint ou un parent
3. Pour des raisons liées à l'emploi
4. En établissement pour moins de 6 mois
5. En établissement pour 6 mois ou plus
6. Décédé
7. Déménagé dans une nouvelle résidence
8. Garde partagée avec l'autre parent
9. Pour des raisons personnelles liées aux études
10. En famille d'accueil
11. Autre

RF/NSP

Situations dans lesquelles le cas sera automatiquement codé comme étant hors du champ de l'enquête :

- L'enfant est placé en établissement.
- L'enfant est décédé.
- L'enfant est en foyer d'accueil.

Pour toutes les autres réponses, le cas passera au dépistage après la vérification de tous les numéros de téléphone donnés du cas.

ITAO 12 -17 ans seulement

Information de dépistage (TRA)	Pour certaines enquêtes, il est nécessaire d'obtenir de l'information qui servira à retracer les personnes ayant déménagé. Ce bloc contient les questions servant à recueillir les données requises à cette fin **ITAO 12-17 seulement **
Options dépistage (TO)	Ce bloc est appelé en ITAO si un code En-cours 30 (dépistage requis) est assigné au cas. Ce bloc contient une question qui demande à l'intervieweur s'il veut continuer à travailler sur le cas dans la composante dépistage. Si "Oui" est sélectionné, le cas va s'ouvrir dans la composante dépistage. Si "Non" est sélectionné, l'intervieweur va sortir du cas et celui-ci sera codé 30 En cours. **ITAO 12-17 seulement**
Langue préférée de dépistage (TRLP)	Le bloc Langue préférée de dépistage contient une question visant à déterminer la langue dans laquelle la source du dépistage préfère être interviewée. Ce bloc propose un choix entre les deux langues officielles ou une langue non officielle. **Nota :** Si la langue sélectionne est “Autre”, le cas sera codé En cours – 22. **ITAO 12-17 seulement**
Dépistage du répondant spécifique (TSR)	Le bloc Dépistage du répondant spécifique est utilisé pour savoir si la source du dépistage a une connaissance quelconque du répondant spécifique. **ITAO 12-17 seulement**
Information sur les membres du ménage	Vous allez maintenant recueillir des renseignements démographiques pour chaque membre du ménage.

Liste de personnes « Habituelle » (USU)	USU_Q01 : **Veuillez nommer toutes les personnes qui demeurent habituellement ici.** Inscrivez ou mettez à jour le prénom suivi du nom de famille de chaque membre habituel du ménage. Commencez par les adultes qui ont des responsabilités au niveau des soins ou du support familial. **Nota :** La première position sur la liste sera automatiquement pré-remplie avec le nom et le prénom du répondant enfant sélectionné pour 12-17 cas. Ces champs ne peuvent pas être modifiés par l'intervieweur. Au moment de dresser la liste des résidents d'un logement collectif, inscrire les membres qui considèrent que le logement est leur résidence habituelle ou qui sont présents et n'ont aucune autre résidence habituelle à l'heure actuelle. La liste peut compter un maximum de 20 noms. S'il y a plus de 20 résidents permanents, inscrire aléatoirement les 20 premiers.
Noms fictifs utilisés	**ESCC n'acceptera plus des noms fictifs de la part des répondants.** Veuillez vous reporter à la page 3-15 du présent Manuel de l'intervieweur pour obtenir des explications détaillées sur les noms fictifs.
État matrimonial sans confirmation (MSNC)	Ce bloc sert à recueillir de l'information sur l'état matrimonial social du répondant, lorsqu'il ne doit pas y avoir confirmation de tout état matrimonial recueilli précédemment. **Nota :** Cette question ne sera posée que pour les membres de ménage âgé de 16 ans et plus. Il est important que le répondant entende toutes les catégories de réponses avant de répondre. Pour les couples du même sexe, demander s'ils sont mariés ou vivant en union libre.
Plus haut niveau de scolarité (EHG2)	Ce bloc demande des détails relatifs au plus haut niveau de scolarité pour les membres du ménage âges de 14 ans et plus.
Forces armées canadiennes (CAF)	La question des Forces armées canadiennes est utilisée pour déterminer si le répondant est un membre à temps plein des Forces armées canadiennes régulières. Cette question sera posée aux personnes de 16 à 65 ans.

Répondant ciblé (TR)

Le bloc Répondant ciblé contient une question utilisée lorsque le contact doit être établi avec un répondant ciblé. Le bloc de TR est appelé uniquement pour des entrevues téléphoniques lorsque le nom d'un répondant à contacter est disponible.

TR_Q01

Puis-je parler à ^CHILD_RESPONDENT?

1. Oui, le répondant nous parle
2. Oui, le répondant est disponible
3. Non, le répondant n'est pas disponible
4. Non, le répondant n'est plus un membre
5. Numéro de téléphone inexact

RF, NSP

Le consentement d'un parent (PGC)

(Répondants de 12 à 15 ans)

Répondant sélectionné : NOM DE RÉPONDANT Age : XX

INTERVIEWEUR : Parce que le répondant sélectionné est âgé de moins de 16 ans, un consentement verbal doit être obtenu d'un parent ou tuteur. Si un parent ou un tuteur réside dans le ménage, mais qu'il n'est pas disponible actuellement, veuillez appuyer sur <F10> pour sortir de l'application et attribuer le code de résultat de cas débuté approprié.

INTERVIEWEUR : Avez-vous obtenu le consentement verbal d'un parent ou tuteur du répondant sélectionné pour compléter l'interview?

1. Oui
2. Non
3. Sans objet (Pas de parent ou tuteur dans le ménage)

Il y a deux options pour les codes de résultat si la réponse est " Non "

1. Le parent ne donne pas la permission pour le répondant âgé entre 12 et 15 ans à remplir le questionnaire. Ceci doit avoir un code de résultat de refus.
2. Le parent ou tuteur n'est pas disponible pour accorder la permission. Suspendre le cas et prendre rendez-vous lorsque le parent ou tuteur est disponible. Ce cas doit être codé 23, 24 ou 25.

Fin de l'entrée pour les enfants de 12 à 17 ans.

Aperçu du questionnaire - Modules sur la santé

Introduction

Cette section explique comment les modules et leurs questions sont présentés. L'information vous guidera à travers chaque module.

Modules des questions sur la santé et socio-démographique (C2)

Ces modules sont au cœur du questionnaire; ils contiennent les questions que nous posons sur la santé. Seules les réponses du répondant sélectionné doivent être inscrites, et non celles de tous les membres du ménage.

Avant de sortir de l'application, nous devons recueillir l'information sur les caractéristiques sociodémographiques des répondants, par exemple leur appartenance ethnique, leur emploi, leur niveau de revenu, la scolarité de tous les membres âgés de 14 ans et plus, ainsi que des questions sur leur logement. Nous demandons aussi aux répondants la permission de partager leurs informations avec celles des chercheurs et de coupler ces informations avec des données administratives déjà existantes provenant des provinces et territoires.

Nota : nous n'avons jamais accès au dossier personnel du répondant qui est gardé par son médecin. Les données ne peuvent être couplées qu'avec les informations recueillies à chaque fois que le répondant se sert de sa carte santé.

Guide des modules

Le contenu est présenté sous forme de modules, respectant l'ordre de parution lors d'une interview.

Plusieurs modules ne s'appliquent qu'à un certain groupe d'âge ou de sexe et/ou ne seront pas utilisés pour les interviews par personne interposée.

Certains modules sont optionnels (indiqués entre parenthèses suivant le nom du module). Ces questions seront posées selon les régions sociosanitaires qui auront choisi ces modules.

Veuillez noter que la liste alphabétique de l'ordre des modules se trouve à la page 3-34 du présent manuel.

Format des questions

La plupart de ces questions sont clairement énoncées et ne nécessitent aucune précision. Ces questions ne sont pas incluses dans le manuel de l'intervieweur et peuvent être passées en revue en faisant les cas de pratique dans l'application de l'IPAO ou ITAO. Par ailleurs, vous retrouverez dans ce manuel les questions nécessitant des explications ou des précisions supplémentaires.

Le questionnaire comprend plusieurs genres de questions : questions à une seule réponse et à réponses multiples, oui/non, nombres ou fréquences, activités ou endroits. Dans chaque cas, le type de réponse requise est indiqué.

Pour accéder à la question suivante, il faut toujours appuyer sur « Enter ».

Numérotage des questions

Le « **numéro de la question** » est indiqué dans la marge de gauche et comprend un code alphanumérique formé des trois lettres du module et du numéro précis de chaque question. Ces numéros correspondent à ceux utilisés par l'application informatique. Les intervieweurs devraient apprendre à connaître ce système de numérotage.

Refus / Ne sait pas

Prière de noter que NSP et RF sont inscrits dans les manuels seulement quand ils sont permis dans l'application.

Introduction

Le contenu de l'ESCC est divisé en quatre modules :

- **Le contenu commun** : Les questions des modules du contenu commun seront posées à tous les répondants et devraient demeurer inchangées pendant plusieurs années.
- **Le contenu thématique** : Les modules sont regroupés sous des thèmes particuliers. Les questions des modules thématiques seront posées à tous les répondants. Certains modules thématiques seront en vigueur pendant un an tandis que d'autres le seront pendant deux ans.
- **Le contenu optionnel** : Les modules du contenu optionnel peuvent varier de province en province et de région sanitaire à une autre. Au courant des cycles les plus récents, le contenu optionnel était le même pour toutes les régions sociaux sanitaires dans chacune des provinces. Notez que les modules à contenu optionnel peuvent changer chaque année.
- **Le module de réponse rapide** : Ce module permet d'étudier un nouveau dossier de santé en introduisant un bref module durant les cycles, et ce sans devoir modifier le contenu principal. Deux minutes de contenu ont été réservées aux questions à réponse rapide afin d'offrir la possibilité d'adapter l'enquête aux nouvelles priorités durant les cycles, et ce sans devoir modifier le contenu principal. L'option est offerte sur la base du recouvrement des coûts et représente un moyen rapide d'introduire du contenu dans l'enquête et de fournir les données aux clients pour leur analyse. Les modules à réponse rapide seront annoncés au fur et à mesure qu'ils seront disponibles et seront présentés sous forme d'encadrés dans le Manuel de l'intervieweur.

Modules thématiques pour 2016

Acronyme	Nom du module
ALW	Alcool – dernière semaine
DRM	Méthodes de consommation de drogues
FGU	Utilisation du guide alimentaire
HMC	Services de soins de santé à domicile
INS	Couverture d'assurance
PEX	Expériences comme patient
SPS	Provisions sociales
STS	Sources de stress
SXB	Comportements sexuels
SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide

Modules communs pour 2016

Acronyme	Nom du module
ADM	Renseignements administratifs
ANC1	Âge du répondant
ALC	Consommation d'alcool
CCC	Problèmes de santé chroniques
CHP	Contacts avec des professionnels de la santé - Partie 1
SDC	Renseignements sociodémographiques
ETS	Exposition à la fumée secondaire
FGU	Utilisation du guide alimentaire
FLU	Vaccins contre la grippe
FVC	Consommation de fruits et de légumes
GEN	État de santé général
HWT	Taille et poids - Autodéclarés
INC	Revenu
LBF	Population active
MAC	Activité principale
MEX	Expériences maternelles
PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
PAA	Activités physiques - Adultes 18 ans et plus
PAY	Activités physiques pour les jeunes
PHC	Soins de santé primaires
GR	Interview par personne interposée
REL	Matrice des relations
SMK	Usage du tabac
SPS	Provisions sociales
STS	Sources de stress

Modules optionnels pour 2016

Acronyme	Nom du module
ACC	Accès aux services de soins de santé
ADL	Activités de la vie quotidienne
BPC	Tension artérielle - Vérification
CCS	Dépistage du cancer du côlon et du rectum
CIH	Changements faits pour améliorer la santé
CP2	Contacts avec des professionnels de la santé - Bloc rallongé
CPG	Jeu excessif
DEN	Soins dentaires
DEP	Dépression
DIA	Soins pour le diabète
DIS	Détresse
DRG	Usage de substances
DRV	Conduite et sécurité
EYX	Examens de la vue
FDC	Choix alimentaires
FSC	Sécurité alimentaire
HUI	Indice de l'état de santé
INJ	Blessures
INW	*Blessures au travail
LOP	Perte de productivité
MAM	Mammographie
MDA	Attachement au médecin
MED	Utilisation de médicaments
MXA	Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse
MXS	Expériences maternelles - Usage du tabac
NDE	Dépendance à la nicotine

Modules optionnels pour 2016 (suite)

Acronyme	Nom du module
OHT	Santé buccodentaire
OST	*Ostéoporose
PAP	Test Pap
PCU	Examen général
PSA	Dépistage du cancer de la prostate
PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires
SAC	Activités sédentaires
SCA	Méthodes pour cesser de fumer
SCH	Usage du tabac - Les étapes du changement
SFE	Estime de soi
SLP	Sommeil
SPC	Consultations avec un professionnel de la santé au sujet du tabagisme
SPI	Spirométrie
SSB	Protection contre le soleil
STG	Stigmatisation à l’égard de la dépression
STS	Sources de stress
SWL	Satisfaction à l'égard de la vie
TAL	Produits alternatifs du tabac
UCN	Besoins de santé non comblés
UPE	Utilisation de l'équipement protecteur
WST	Stress au travail
WTM	Temps d'attente
YAC	*Accès aux cigarettes chez les jeunes

*Nota : Tous les modules n’ont pas été sélectionnés pour la période de collecte de 2016. Veuillez consulter la liste alphabétique à la page suivante pour savoir quels modules n’ont pas été retenus pour 2016.

Dans les tableaux ci-dessous, vous trouverez les modules par ordre alphabétique avec le numéro d'apparition dans l'application comme référence.

Liste de tous les modules de l'ESCC 2016 en ordre alphabétique

Ordre	Acronyme	Nom du module	Type
71	ACC	Accès aux services de soins de santé	Optionnel
9	ADL	Activités de la vie quotidienne	Optionnel
82	ADM	Renseignements administratifs	Commun
27	ALC	Consommation d'alcool	Commun
28	ALW	Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine	Thématique
2	ANC1	Âge du répondant	Commun
45	BPC	Tension artérielle - Vérification	Optionnel
7	CCC	Problèmes de santé chroniques	Commun
49	CCS	Dépistage du cancer du côlon et du rectum	Optionnel
66	CHP	Contacts avec certains professionnels de la santé - Partie 1	Commun
15	CIH	Changements faits pour améliorer la santé	Optionnel
55	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale	Thématique
67	CP2	*Contacts avec des professionnels de la santé - Bloc rallongé	Optionnel
32	CPG	Jeu excessif	Optionnel
14	DEN	Soins dentaires	Optionnel
59	DEP	*Dépression	Optionnel
51	DIA	Soins pour le diabète	Optionnel
58	DIS	*Détresse	Optionnel
31	DRG	Usage de substances	Optionnel
30	DRM	Méthodes de consommation de drogues	Thématique
42	DRV	Conduite et sécurité	Optionnel
26	ETS	Exposition à la fumée secondaire	Commun
52	EYX	Examens de la vue	Optionnel
18	FDC	Choix alimentaires	Optionnel
19	FGU	Utilisation du guide alimentaire canadien	Thématique
43	FLU	Vaccins contre la grippe	Commun

Liste de tous les modules de l'ESCC 2016 en ordre alphabétique (suite)

Ordre	Acronyme	Nom du module	Type
80	FSC	Sécurité alimentaire	Optionnel
17	FVC	Consommation de fruits et de légumes	Commun
5	GEN	État de santé général	Commun
1	GR	Interview par personne interposée	Commun
73	HMC	Services de soins de santé à domicile	Thématique
8	HUI	Indice de l'état de santé	Optionnel
6	HWT	Taille et poids - Autodéclarés	Commun
81	INC	Revenu	Commun
10	INJ	Blessures	Optionnel
79	INS	Couverture d'assurance	Thématique
11	INW	*Blessures au travail	Optionnel
75	LBF	Population active	Commun
76	LOP	Perte de productivité	Optionnel
4	MAC	Activité principale	Commun
48	MAM	Mammographie	Optionnel
65	MDA	Attachement au médecin	Optionnel − C.-B. seulement
29	MED	Utilisation de médicaments	Optionnel
39	MEX	Expériences maternelles	Commun
41	MXA	Expériences maternelles - Consommation d'alcool au cours de la grossesse	Optionnel
40	MXS	Expériences maternelles - Usage du tabac	Optionnel
33	NBE	Environnement du quartier	Optionnel
24	NDE	Dépendance à la nicotine	Optionnel
13	OHT	Santé buccodentaire	Optionnel

*Modules pas choisis pour 2016

Liste de tous les modules de l'ESCC 2016 en ordre alphabétique (suite)

Ordre	Acronyme	Nom du module	Type
12	OST	*Ostéoporose	Optionnel
33	PAA	Activités physiques - Adultes 18 ans et plus	Commun
46	PAP	Test Pap	Optionnel
34	PAY	Activités physiques pour les jeunes	Commun
44	PCU	Examen général	Optionnel
70	PEX	Expériences comme patient	Thématique
64	PHC	Soins de santé primaires	Commun
54	PMH	*Santé mentale positive	Optionnel
78	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage	Commun
48	PSA	Dépistage du cancer de la prostate	Optionnel
68	PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires	Optionnel
3	REL	Matrice des relations	Commun
37	SAC	Activités sédentaires	Optionnel
22	SCA	Méthodes pour cesser de fumer	Optionnel
21	SCH	Usage du tabac - Les étapes du changement	Optionnel
77	SDC	Renseignements sociodémographiques	Commun
57	SFE	Estime de soi	Optionnel
16	SLP	Sommeil	Optionnel
20	SMK	Usage du tabac	Commun
68	SPC	*Consultations avec un professionnel de la santé au sujet du tabagisme	Optionnel
50	SPI	Spirométrie	Optionnel
63	SPS	Provisions sociales	Thématique
36	SSB	Protection contre le soleil	Optionnel
53	STG	Stigmatisation à l'égard de la dépression	Optionnel
62	STS	Sources de stress	Thématique
60	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide	Thématique
56	SWL	Satisfaction à l'égard de la vie	Optionnel
38	SXB	Comportements sexuels	Thématique

*Modules pas choisis pour 2016

Liste de tous les modules de l'ESCC 2016 en ordre alphabétique (suite)

Ordre	Acronyme	Nom du module	Type
23	TAL	Produits alternatifs du tabac	Optionnel
74	UCN	Besoins de santé non comblés	Optionnel
35	UPE	Utilisation de l'équipement protecteur	Optionnel
61	WST	Stress au travail	Optionnel
72	WTM	Temps d'attente	Optionnel
25	YAC	*Accès aux cigarettes chez les jeunes	Optionnel

*Modules pas choisis pour 2016

Aperçu

La présente section est un aperçu de chaque module de l'ESCC et renferme des instructions aux intervieweurs et un échantillon des questions que vous trouverez dans chaque module. Pour les nouveaux modules ou ceux qui sont jugés complexes, toutes les questions sont fournies. Les modules complexes comprennent ceux qui portent sur des sujets délicats; ceux qui comportent des instructions spéciales et ceux qui se composent de sous-modules, comme sur le revenu (INC), la population active (LBF) et les caractéristiques sociodémographiques (SDC).

Les modules sur la santé sont présentés dans l'ordre où ils apparaissent dans l'application. **Notez** que tous les modules sont inclus, même ceux qui n'ont pas été choisis par une province ou un territoire.

Le nom et le type de module (commun, thématique ou optionnel) sont indiqués dans la colonne de gauche. À droite, on peut voir un aperçu de chaque module, les instructions aux intervieweurs et la première question du module. Dans certains cas, le module complet (toutes les questions) est indiqué lorsque c'est un nouveau module, quand il nécessite une attention particulière ou plus de précisions.

La liste de tous les modules de l'ESCC 201601 est présentée par type et en ordre alphabétique, en commençant à la page 3-34 du présent manuel.

Nota : Tous les modules de l'ESCC n'ont pas été retenus pour 201601.

Nouveaux modules pour 2016

Il y a un nouveau module pour 2016, le module Attachement au médecin (MDA). Ce module est **optionnel** et disponible uniquement pour la Colombie-Britannique.

Réponse rapide

Tous les modules à réponse rapide seront fournis séparément dans un encadré de votre Manuel de l'intervieweur. Quand vous recevrez un encadré d'un module à réponse rapide, veuillez vous assurer de le lire au complet et de l'inclure dans votre manuel à des fins de référence. Si vous avez des questions à propos des modules à réponse rapide, veuillez vous adresser à votre IP.

Modules avec des instructions particulières

Soins de santé primaires (PHC).

Soins de santé de routine – Terme relativement nouveau. C'est la personne que consulte le répondant le plus souvent pour ses soins de santé habituels. Dans certaines régions éloignées, il pourrait s'agir d'une infirmière autorisée (ou infirmière régulière). Ou encore, il pourrait s'agir d'un spécialiste pour les répondants ayant certains problèmes médicaux.

Problèmes de santé chroniques (CCC) : Si le répondant ne connaît pas un problème donné, vous pouvez utiliser le glossaire pour l'expliquer, mais ça veut probablement dire que le répondant n'a pas ce problème. Rappelez-lui dans ces cas que le problème doit avoir été diagnostiqué.

Revenu (INC)

Dans le module sur le revenu, le calendrier pour fournir les revenus du répondant est basé sur l'exercice précédent. Il devrait être plus facile pour le répondant de se souvenir de ses revenus personnels et des revenus du ménage de l'an dernier parce qu'ils correspondent à sa dernière déclaration de revenus. Si vous interviewez plus près de la fin de l'exercice (p. ex. de septembre à décembre 2015), il pourrait être bon de rappeler au répondant que nous l'interrogeons au sujet de ses revenus de l'année précédente (donc de janvier à décembre 2014).

Le module INC comporte deux sous-modules : le revenu personnel total (INC-TPI), qui est demandé lorsque plus d'une personne vit dans le ménage et que le répondant a 16 ans ou plus. L'autre sous-module est le revenu total du ménage (INC-THI).

Usage de substances (DRG) / Méthodes de consommation de drogues (DRM) :

Dans ces modules, nous examinons l'usage de drogues illicites. Il peut s'agir de médicaments sous ordonnance consommés à mauvais escient, soit par la modification du mode d'administration (p. ex. écraser une pilule afin de l'injecter au lieu de la prendre oralement), soit par la prise de médicaments prescrits à quelqu'un d'autre.

Renseignements administratifs (ADM)

Dans ce module, on dit maintenant aux répondants que leurs renseignements pourraient être utilisés pour le couplage de données (nous ne demandons plus la permission de coupler). Cependant, les répondants doivent encore donner leur permission pour partager leurs données avec les partenaires de la santé.

On demande également aux répondants de fournir leur numéro de carte santé provinciale ou territoriale. Si le répondant ne peut pas fournir son numéro de carte de santé au moment de l'interview, indiquez « non » et continuez le questionnaire. Ne codez pas le cas comme en cours; le cas devrait être clos qu'un numéro de carte santé ait été obtenu ou pas. Si un répondant offre de rappeler pour fournir son numéro de carte santé, prenez ses coordonnées dans la section des notes permanentes. Tout changement de l'information sur le numéro de carte de santé n'est pas considéré comme une note essentielle.

Modules avec des instructions particulières (suite)	**Sujets/modules délicats (SUI, SXB, CPG, DRG).** L'ESCC contient des questions sur plusieurs sujets délicats comme le suicide, l'orientation sexuelle, le jeu et la consommation de drogues. Assurez-vous de vous familiariser avec les sections sur les interviews délicates, la protection des renseignements personnels et les préoccupations des parents au chapitre 2 du manuel.
Glossaire	Le glossaire des termes fait maintenant partie de l'application. Vous pouvez accéder au glossaire en cliquant sur Glossaire sous la barre de titre, ou en appuyant sur la touche F7. Les sujets sont regroupés et classés par ordre alphabétique. Entrez la première lettre du sujet d'aide dans HLP_Q01 pour afficher le groupe. Le glossaire complet se trouve dans le présent manuel, à l'annexe A.
Interview par personne interposée (GR) Commun	Ce module sert à identifier la personne qui fournira les renseignements au nom du répondant choisi et à déterminer la raison pour laquelle l'interview sera menée par personne interposée. La liste de tous les membres du ménage s'affichera. Il est important de sélectionner la bonne personne, afin de déterminer si l'interview doit être menée par personne interposée. Si la personne qui donne l'information n'est pas le répondant sélectionné, il faut poser les questions suivantes : INTERVIEWEUR : Voulez-vous compléter la composante par personne interposée? Depuis 2013, il est possible de mener l'interview par personne interposée auprès d'un membre renseigné du ménage ou, dans de très rares circonstances, auprès d'une personne qui n'est pas membre du ménage. Si l'interview par personne interposée est menée avec un non-membre du ménage, l'intervieweur doit écrire une Remarque (F4) pour expliquer la relation entre le répondant et la « non-membre du ménage » ainsi que la raison pour laquelle l'interview est menée avec un non-membre du ménage. Un exemple de non-membre du ménage serait un enfant ou un membre de la famille qui s'occupe du répondant choisi, mais qui n'habite pas avec lui. INTERVIEWEUR : Inscrivez la raison pour laquelle la composante a été complétée par personne interposée. On ne doit avoir recours à une interview par personne interposée seulement si l'état physique ou mental du répondant fait en sorte qu'il lui est impossible de faire l'interview durant la période de collecte. Si la raison pour avoir recours à une interview par personne interposée n'est aucun de ces choix, veuillez appuyer sur <F10> pour sortir de l'application et assignez un code de sortie approprié.
Âge du répondant (ANC1) Commun	L'âge du répondant est important, car il détermine quelles questions seront posées et est essentiel à l'analyse des données. Il est très important de confirmer l'âge des jeunes âgés de 11 ou 12 ans, car 12 ans est l'âge minimal pour être admissible à l'enquête.

Âge du répondant (ANC1)
Commun - suite

De plus, parce que la base de sondage n'est pas la même pour les jeunes et les adultes, il est aussi important de confirmer l'âge des jeunes âgés de 17 ou 18 ans, car ce sont les limites d'âge pour déterminer si le répondant est compris dans la base de sondage, et par conséquent, s'il est admissible à l'enquête. Si vous constatez qu'un enfant âgé de 11 ans est indiqué dans votre échantillon, examinez sa date de naissance et vérifiez que vous prenez contact avec le ménage **après** que l'enfant a eu 12 ans, parce qu'il ne sera pas admissible tant qu'il n'aura pas effectivement 12 ans.

Lien de parenté (RNC)
Commun

Ce module Les relations sans confirmation (RNC) est utilisé pour collecter la relation d'un individu à un autre membre du ménage. Pour la majorité des cas, seule la relation de l'intimé aux autres membres de la famille sera demandée. Cependant, dans certains cas, la relation de chacun à tous sera nécessaire.
Ce module ne sera pas appelé s'il n'y a qu'une personne dans le ménage
Liste de liens de parenté

1. Époux/Épouse
2. Conjoint (e) de fait
3. Père/Mère
4. Fils/Fille
5. Frère/Sœur
6. Père/Mère de famille d'accueil
7. Fils/Fille en famille d'accueil
8. Grand-père/mère
9. Petit[e]-fils/fille
10. Parent par alliance
11. Autre personne apparentée
12. Personne non apparentée

Nota : Cette question nous permet de recueillir des renseignements plus détaillés sur les liens entre les membres du ménage (par exemple, un enfant qui fait partie du ménage peut être un enfant naturel, un enfant issu d'une autre union, un enfant adopté ou un enfant en famille d'accueil) de façon à classer les personnes dans leur famille. Pour les partenaires du même sexe, choisissez « en union libre ».

Activité principale (MAC)
Commun

Ce module sert à recueillir des renseignements sur l'activité principale du répondant au cours de la dernière semaine, pour les répondants de 15 ans et plus. Si la principale activité du répondant n'est pas « Travailler à un emploi » ou « vacances d'un travail » et qu'il est âgé de 15 à 75 ans, on lui demande s'il a travaillé à un moment quelconque au cours des douze derniers mois.
Si la principale activité du répondant n'est pas « être aux études », on lui demande s'il fréquente actuellement une école, un collège, un cégep ou une université.
Dans ce module, on demande aux femmes âgées de 15 à 55 ans si elles sont enceintes.

MAC_Q005

Au cours de la semaine dernière, est-ce que votre activité principale était de travailler à un emploi rémunéré ou à votre propre compte, de chercher un emploi rémunéré, d'étudier, de vous occuper des enfants, d'effectuer des travaux ménagers, d'être à la retraite ou autre chose?

INTERVIEWEUR : L'activité principale signifie l'activité à laquelle le répondant passe le plus de temps : travail, recherche d'emploi, études, s'occuper des enfants, etc.

Si le répondant mentionne une maladie de courte durée ou une formation reliée au travail de courte durée, demandez-lui quelle est son activité principale habituelle.

1. Travailler à un emploi rémunéré ou à son propre compte
2. Vacances (d'un travail rémunéré)
3. Chercher un emploi rémunéré
4. Être aux études (y compris les vacances scolaires)
5. S'occuper des enfants
6. Travaux ménagers
7. À la retraite
8. Congé de maternité ou de paternité
9. Maladie de longue durée
10. Bénévolat
11. Donner des soins à des personnes autres que des enfants
12. Autre

NSP, RF

MAC_Q010

À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

MAC_Q020

Êtes-vous inscrit(e) comme un(e) ...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant

1. **Étudiant (e) à temps plein**
2. **Étudiant (e) à temps partiel**
3. **Étudiant (e) à la fois à temps plein et à temps partiel**

NSP, RF

MAC_Q025

Afin de mieux comprendre les renseignements sur votre santé que vous allez fournir, il est important que nous sachions si vous êtes enceinte. Êtes-vous enceinte?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

ESC1_Q01

Fréquentez-vous actuellement une école, un collège, un cégep ou une université?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant d'inclure seulement les cours qui peuvent être utilisés comme crédits en vue de l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un grade.

1. Oui
2. Non

NSP, RF

État de santé général (GEN)
Commun

Le module sur l'état de santé générale sert à recueillir des données sur la perception qu'a le répondant de sa santé, de sa santé mentale, de son stress au travail et dans la vie en général, de son sentiment d'appartenance à la communauté et sur sa satisfaction envers sa vie.
Les chercheurs s'intéressent à ces questions parce qu'elles donnent une bonne idée de la santé du répondant. Elles peuvent également être utilisées pour prédire d'autres aspects de la santé du répondant. Par exemple, des recherches ont démontré qu'un répondant qui décrit sa santé comme passable ou mauvaise est plus à risque d'avoir des problèmes de santé à long terme, de souffrir de dépression et d'être un grand utilisateur du système de santé.

GEN_Q015

En général, diriez-vous que votre santé mentale est...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1. Excellente
2. Très bonne
3. Bonne
4. Passable
5. Mauvaise

NSP, RF

Taille et poids – Auto déclarés (HWT)
Commun

Dans ce module, on demande aux répondants de déclarer leur taille et leur poids et d'indiquer s'ils considèrent qu'ils font de l'embonpoint, qu'ils sont trop maigres ou que leur poids est à peu près normal.
Les réponses à ces questions serviront de plusieurs façons, entre autres, le calcul du nombre de personnes qui font de l'embonpoint ou qui sont obèses.
L'obésité, particulièrement chez les jeunes personnes, représente un sérieux problème de santé. On peut l'associer à un nombre de problèmes médicaux majeurs, dont l'hypertension artérielle, les maladies du cœur et le diabète.

HWT_R001	**Les prochaines questions portent sur la taille et le poids.**
HWT_Q005	**Combien mesurez-vous sans chaussures?**
Problèmes de santé chroniques (CCC) Commun	Les premières questions de ce module portent sur la douleur dans les articulations au cours des trente derniers jours. Les autres questions portent sur les problèmes de santé de longue durée qui durent depuis six mois ou qui vont probablement durer au moins six mois. Les problèmes de santé chroniques rapportés par les répondants doivent avoir été diagnostiqués par un professionnel de la santé. Les réponses à ces questions peuvent servir à estimer le nombre de personnes qui souffrent de problèmes de santé chroniques au Canada, comme le diabète, une maladie cardiaque et l'asthme. En combinant les réponses aux questions de ce module aux informations provenant des autres modules, les chercheurs peuvent examiner le lien entre les problèmes de santé chroniques et d'autres caractéristiques, comme le recours aux soins de santé ou la consommation de médicaments.
CCC_R001	**La question qui suit porte sur vos articulations. S'il vous plaît ne pas inclure le dos ou le cou.**
CCC_Q005	**Au cours des 30 derniers jours, avez-vous éprouvé des symptômes de douleur, de douleur continue ou de raideur dans une articulation ou autour de celle-ci?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Indice de l'état de santé (HUI) Thématique	Ce module est composé de neuf ensembles de questions, chacun portant sur un aspect de la santé tel que : vision, ouïe, élocution, mobilité (capacité de se déplacer) usage des mains et des doigts, sentiments, mémoire, pensée, et douleurs. Les réponses du répondant à ces neuf ensembles de questions seront combinées et resteront en un total. Un total élevé signifie un bon état de santé du répondant. Les chercheurs utiliseront les résultants de ces questions et les compareront au niveau de santé général de différents groupes tels que les hommes et les femmes, les jeunes et les âgées, etc.

HUI_R001

Les questions suivantes concernent votre état de santé au quotidien.

Il se peut que vous pensiez que certaines questions ne s'appliquent pas à vous, mais il est important que nous posions les mêmes questions à tout le monde.

HUI_Q005

<u>Habituellement</u>, voyez-vous assez bien pour lire le journal <u>sans</u> lunettes ou verres de contact?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Activités de la vie quotidienne (ADL)
Commun

Ce module examine l'impact d'un trouble physique ou mental ou d'un problème de santé sur les activités ordinaires de la vie quotidienne, comme préparer les repas, faire des courses et accomplir les tâches ménagères.
Il est primordial de poser les questions à tous les répondants afin de faire des comparaisons entre ceux qui sont limités dans leurs activités et ceux qui ne le sont pas.

ADL_R001

Les prochaines questions portent sur les activités communes de tous les jours. Il est possible que les questions ne s'appliquent pas à vous, mais il est nécessaire de poser les mêmes questions à tout le monde.

ADL_Q005

À cause d'un état physique, un état mental ou un problème de santé, avez-vous de la difficulté :
pour préparer les repas?

1. **Non, vous n'avez pas de difficulté**
2. **Oui, vous avez de la difficulté, mais vous n'avez pas besoin de l'aide d'une autre personne**
3. **Oui, vous avez de la difficulté, mais vous pouvez le faire avec l'aide d'une autre personne**
4. **Vous êtes absolument incapable de le faire**

NSP, RF

Blessures (INJ)
Optionnel

Les premières questions de ce module portent sur les lésions attribuables aux mouvements répétitifs. Il s'agit de blessures causées par le surmenage articulaire ou la répétition fréquente du même mouvement pendant une longue période.
Les autres questions du module portent sur les causes, la nature, la fréquence et le traitement des autres genres de blessures, comme une fracture, une coupure profonde, une brûlure grave ou un empoisonnement. Cette partie du module traite des blessures qui sont suffisamment graves pour limiter les activités normales; toutes les questions se rapportent à la plus grave blessure subie au cours des douze derniers mois.
Pour pouvoir mettre en place des programmes efficaces de prévention des blessures, les planificateurs des services de santé ont besoin de savoir quels genres de blessures sont les plus fréquentes, quelles en sont les causes et quels groupes de personnes sont les plus susceptibles d'être blessées.

INJ_Q005

Au cours des 12 derniers mois, vous êtes-vous blessé(e) à cause de mouvements répétitifs?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Il est à **noter** que le module INJ doit être sélectionné pour que INW soit demandé.

Introduction

Dans cette section, les modules santé sont présentés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans l'application. **A noter** que tous les modules sont inclus même ceux qui n'ont pas été choisis par certaines provinces ou territoires.
Le nom et le type de module (commun, thématique ou optionnel) sont indiqués dans la colonne de gauche. À droite se trouvent un aperçu de chaque module, les instructions pour les intervieweurs et la première question du module. Dans certains cas où les modules sont nouveaux ou s'ils nécessitent une attention particulière ou plus de précisions.

Blessures au travail (INW)
Optionnel

Ce module porte sur les blessures qui se sont produites à <u>un emploi autre que l'emploi principal actuel</u>. Il sert à recueillir des renseignements sur l'industrie, la profession et les plus importantes fonctions de l'emploi exercé lorsque la blessure s'est produite.
Ces renseignements permettront d'approfondir l'étude des blessures au travail en général, y compris celles qui se produisent à un emploi autre que l'emploi principal, car les renseignements concernant l'emploi actuel sont déjà recueillis dans le module LBF.
Nota : ce module n'est pas sélectionné pour 2015

Ostéoporose (OST)
Optionnel

Les questions de ce module portent sur les fractures ou les fêlures de la hanche, du bras, du poignet, de l'épaule ou de la colonne vertébrale, la cause de ces fractures ou fêlures, et à quel âge elles se sont produites.

Il y a aussi un certain nombre de questions à propos du diagnostic et du traitement de l'ostéoporose, comme les tests de densité osseuse ainsi que les suppléments et les médicaments pour traiter l'ostéoporose.

Ces questions ont pour but de mesure l'incidence de l'ostéoporose chez les personnes âgées de 40 ans et plus.

Nota : ce module n'est pas sélectionné pour 2016

Santé buccodentaire (OHT)
Optionnel

Dans ce module, on demande aux répondants de décrire l'état de santé de leur bouche et de leurs dents (ou dentiers) et d'indiquer dans quelle mesure ils sont satisfaits de l'apparence de leurs dents. On demande aussi aux répondants s'ils ont de la difficulté à manger à cause de problèmes de bouche, à quelle fréquence ils ont des douleurs dans la bouche, s'ils évitent de manger certains aliments et à quelle fréquence ils éprouvent toute autre douleur persistante ou continuelle dans la bouche.

La santé bucco-dentaire est liée à plusieurs autres aspects de la santé en général. Par exemple, une mauvaise santé dentaire peut être liée à une mauvaise nutrition.

Les données obtenues dans ce module peuvent être utilisées pour identifier les groupes ayant besoin d'un meilleur système de santé dentaire.

OHT_R001

Maintenant, quelques questions au sujet de la santé de votre bouche, y compris vos dents ou dentiers, votre langue, vos gencives, vos lèvres et vos articulations de la mâchoire.

OHT_R005

En général, diriez-vous que la santé de votre bouche est...?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 Excellente
2 Très bonne
3 Bonne
4 Passable
5 Mauvaise
NSP, RF

Soins dentaires (DEN)
Optionnel

Les questions de ce module portent sur les soins personnels des dents ou des dentiers et sur la fréquence de ces soins, y compris le brossage des dents, l'usage de soie dentaire et le nettoyage des dentiers. On demande aussi aux répondants à quelle fréquence ils voient un professionnel des soins dentaires et s'ils évitent de se rendre chez un professionnel des soins dentaires à cause du coût de ces soins.

Soins dentaires (DEN) Optionnel **- suite**	La santé des dents et des gencives est un aspect important de la santé générale. Les réponses à ces questions peuvent permettre d'identifier quels groupes sont les moins susceptibles de visiter un dentiste et d'obtenir des informations sur les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas recevoir de soins dentaires.
DEN_R001	**Les prochaines questions portent sur les soins dentaires.**
DEN_R005	**Vous reste-t-il au moins une dent naturelle?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Changements faits pour améliorer la santé (CIH) Optionnel	On pose aux répondants un certain nombre de questions à propos de changements de comportement qu'ils ont fait au cours de la dernière année (et de leurs intentions futures) pour améliorer leur santé, y compris perdre du poids, cesser de fumer et faire plus d'exercice. Le module cherche également à connaître les facteurs qui ont empêché les répondants de changer leurs comportements, comme le manque de temps et le manque de volonté. Les résultats de ce module sont précieux pour l'élaboration de programmes visant à promouvoir une bonne qualité de vie. À titre d'exemple, les planificateurs de régions socio-sanitaires peuvent découvrir qu'un grand nombre de personnes veulent faire plus d'exercice physique, mais le manque de temps les en empêche. Des programmes peuvent être mis en place pour rappeler aux gens d'inclure quelques exercices physiques à leurs activités quotidiennes.
CIH_R001	**Maintenant, quelques questions au sujet de changements faits pour améliorer votre santé.**
CIH_Q005	**Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait quelque chose pour améliorer votre santé? (Par exemple, perdre du poids, cesser de fumer, faire plus d'exercices).** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Sommeil (SLP) Optionnel	Dans ce module, les questions portent sur le sommeil, le nombre d'heures passées à dormir, la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, le nombre de fois où le sommeil est réparateur et la difficulté à rester éveillé. Ces questions serviront à examiner les liens entre le sommeil et d'autres facteurs, comme la mauvaise santé et le stress.

SLP_R001	**Maintenant, quelques questions au sujet du sommeil.**
SLP_Q005	**Habituellement, combien d'heures dormez-vous chaque nuit?**
Consommation de fruits et de légumes (FVC) Commun	Les programmes et recherches sur la promotion de la santé font de plus en plus ressortir les bienfaits pour la santé résultant de la consommation de fruits et de légumes. Certaines recherches établissent notamment un lien étroit entre une consommation accrue de fruits et de légumes et une réduction du risque de nombreux cancers. Pour ces questions, vous devrez demander au répondant de se rappeler combien de fois qu'il mange les aliments. Soyez patient et encouragez le répondant à vous fournir une bonne estimation.
FVC_R001	**Les questions qui suivent se rapportent aux fruits et aux légumes que vous avez mangés ou bus au cours du mois dernier. Veuillez indiquer votre consommation soit par jour, par semaine, ou par mois. Pensez à tout ce que vous avez mangé comme repas ou collation, tant à la maison qu'à l'extérieur.**
FVC_Q005	**Au cours du mois dernier, combien de fois par jour, par semaine ou par mois avez-vous bu des jus de fruit PURS à 100 %, comme du jus d'orange pure, de pomme, ou des mélanges de jus purs à 100 %? Ne pas inclure les boissons à saveur de fruits additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou les punchs aux fruits.** INTERVIEWEUR : N'inscrivez que le chiffre. NE PAS inclure les boissons aux fruits, comme les boissons en poudre reconstituées, la limonade, le cocktail de canneberges ou les boissons au yogourt.
FVC_N005	INTERVIEWEUR : Sélectionnez la période déclarée qui correspond à FVC_Q005. 1. Par jour 2. Par semaine 3. Par mois
Choix alimentaires (FDC) Optionnel	Ce module étudie une série de raisons que pourraient avoir les personnes de choisir ou d'éviter telle alimentation. Les raisons comprennent les préoccupations concernant le poids corporel ou les maladies du cœur et les préoccupations concernant la teneur en matières grasses ou en sel dans les aliments. Les informations qui découleront de ce module peuvent servir à élaborer des programmes d'encouragement pour une alimentation saine. Cela peut aider à améliorer l'état de santé général et pourra, à la longue, aider à contrôler le coût du système de soins de santé.

FDC_R001	**Maintenant, quelques questions au sujet des aliments que vous mangez.**
FDC_Q005	**Choisissez-vous certains aliments ou en évitez-vous d'autres : parce que vous vous préoccupez de votre poids corporel?** 1. Oui (ou parfois) 2. Non NSP, RF
Utilisation du guide alimentaire canadien (FGU) Optionnel	Ce module sert à recueillir des renseignements sur la connaissance et l'usage du Guide alimentaire canadien parmi la population. Plus particulièrement, on demande aux répondants s'ils connaissent le Guide alimentaire canadien et s'ils ont déjà utilisé l'information qui s'y trouve. Ces renseignements peuvent servir à mieux comprendre le rapport entre l'usage du Guide alimentaire canadien, les habitudes alimentaires et les comportements liés à la santé.
FGU_Q005	**Avez-vous déjà vu ou entendu parler du Guide alimentaire canadien?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
FGU_Q010	**Avez-vous déjà utilisé l'information du Guide alimentaire canadien?**
FGU_Q015	**Pour quelles raisons avez-vous déjà utilisé cette information?** 1. Pour choisir des aliments pour les membres du ménage 2. Pour déterminer la quantité de nourriture dont les membres du ménage ont besoin chaque jour 3. Pour planifier les repas ou les achats à l'épicerie 4. Pour évaluer si les membres du ménage mangent bien 5. Autre 6. Aucun des choix ci-dessus NSP, RF Vous ne pouvez pas choisir « Aucun des choix ci-dessus » en même temps qu'une autre catégorie. S.V.P., retournez et corrigez.
Usage du tabac (SMK) Commun	L'usage du tabac est une cause importante de maladies cardiaques et du cancer du poumon. Le coût économique des maladies et des décès causés par l'usage du tabac est une importante préoccupation des planificateurs et des administrateurs du domaine de la santé.

Usage du tabac (SMK)

Commun - suite

Le nombre de personnes qui fument varie selon les régions, entre les hommes et les femmes et parmi les différents groupes d'âges.

Ce module comprend une série de questions sur l'usage courant et antérieur du tabac.

Les résultats de ce module peuvent servir à élaborer des programmes de prévention de l'usage du tabac ciblant les groupes qui en ont le plus besoin.

SMK_R001

Les questions suivantes portent sur l'usage de la cigarette.

SMK_Q005

Actuellement, fumez-vous des cigarettes tous les jours, à l'occasion ou jamais?

1. Tous les jours
2. À l'occasion
3. Jamais

NSP, RF

Usage du tabac – Les étapes du changement (SCH)

Optionnel

Dans ce module, on demande aux fumeurs s'ils ont l'intention d'arrêter de fumer dans les 30 prochains jours ou dans les 6 prochains mois. On demande aussi aux répondants si, au cours des douze derniers mois, ils ont arrêté de fumer pendant au moins vingt-quatre heures, et combien de fois, dans le but de tenter de réduire leur consommation de cigarettes ou de cesser de fumer.

Lorsque les planificateurs des soins de santé élaborent des programmes pour encourager les gens à cesser de fumer, il est très utile pour eux de savoir quels groupes sont plus prêts à arrêter et ne pourront nécessiter de l'encouragement et quels groupes ont besoin de différents types de programmes.

SCH_Q005

Envisagez-vous sérieusement de cesser de fumer au cours des 6 prochains mois?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Usage du tabac – Méthodes pour cesser de fumer (SCA)

Optionnel

Dans ce module, on demande aux personnes qui fument et aux personnes qui ont cessé de fumer durant la dernière année des questions sur l'utilisation des différentes méthodes d'aide au sevrage, comme les timbres, la gomme ou les bonbons à la nicotine et les médicaments comme le Zyban.

Usage du tabac – Méthodes pour cesser de fumer (SCA)

Optionnel - suite

Les renseignements sur l'usage de méthodes pour cesser de fumer sont utiles pour comprendre dans quelle mesure ces différentes méthodes aident à réduire la consommation de cigarettes ou à cesser de fumer. Ces renseignements peuvent aussi servir à créer des programmes efficaces pour encourager les gens à cesser de fumer.

SCA_Q005

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé un timbre à la nicotine pour réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

SCA_Q010

Quelle a été son utilité pour vous aider à réduire votre consommation de cigarettes ou cesser de fumer?

INTERVIEWEUR : La réponse doit refléter le véritable objectif du répondant (réduire ou cesser).

1. Très utile
2. Un peu utile
3. Pas très utile
4. Aucune utilité

NSP, RF

Usage du tabac – Produits alternatifs du tabac (TAL)

Optionnel

Ce module traite de la consommation de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de pipes, de tabac sans fumée, de tabac à mâcher, de tabac à priser et de pipes à eau, qu'on n'aborde pas dans le module traitant de la consommation de tabac.

Les variantes des cigarettes ont de différentes répercussions sur la santé. Ce module servira à connaître les groupes les plus susceptibles à consommer ces produits.

TAL_R001

Maintenant, j'aimerais vous poser quelques questions sur les produits du tabac, autres que les cigarettes.

TAL_Q005

Au cours des 30 derniers jours, avez-vous fumé des petits cigares ou des cigarillos?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Dépendance à la nicotine (NDE)

Optionnel

Dans ce module, on pose aux fumeurs une série de questions sur leur dépendance au tabac.

Le fait de connaître le niveau de dépendance au tabac peut aider les planificateurs à élaborer des programmes anti-tabac efficaces.

NDE_Q005

Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

1. Dans les 5 premières minutes
2. 6 à 30 minutes après le réveil
3. 31 à 60 minutes après le réveil
4. Plus de 60 minutes après le réveil

NSP, RF

NDE_Q010

Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits interdits?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Accès aux cigarettes chez les jeunes (YAC)

Optionnel

L'usage du tabac par les jeunes est un problème important de santé publique.

On demande d'abord à tous les fumeurs actuels à quel endroit ils se procurent habituellement des cigarettes. Les autres questions sont posées seulement aux répondants âgés de 12 à 17 ans et portent sur les endroits où les jeunes obtiennent des cigarettes et sur la façon dont ils se les procurent.

Les résultats de ce module pourront être utilisés pour développer la réglementation face à l'achat des cigarettes par les jeunes.

Nota : ce module n'est pas sélectionné pour 2016.

Exposition à la fumée secondaire (ETS)

Commun

L'exposition à la fumée secondaire a différentes répercussions négatives sur la santé, y compris les troubles pulmonaires et l'asthme infantile.

Ce module comprend des questions sur le nombre de personnes qui fument régulièrement à l'intérieur de la maison (y compris les membres du ménage et les visiteurs réguliers), et sur les restrictions en matière d'usage de tabac dans les maisons. Ces questions sont posées à tous les répondants.

On demande aux répondants qui ne fument pas combien de fois ils ont été exposés à de la fumée dans un véhicule, au travail, à l'école et dans un endroit public au cours du dernier mois.

ETS_R001

Les questions suivantes portent sur l'exposition à la fumée secondaire.

ETS_Q005

En comptant les membres du ménage et les visiteurs réguliers, y a-t-il quelqu'un qui fume à <u>l'intérieur</u> de votre maison, chaque jour ou presque chaque jour?

<u>INTERVIEWEUR</u> : Incluez les cigarettes, les cigares et les pipes. Fumer dans la maison exclut fumer dans le garage, qu'il soit attenant ou non.

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Consommation d'alcool (ALC)

Commun

La consommation d'alcool a un certain nombre de répercussions sur la santé. Une consommation excessive est liée à un certain nombre de maladies, de problèmes sociaux et de problèmes de santé mentale. La consommation d'alcool est aussi l'une des principales causes d'accidents et de blessures.

Dans ce module, on demande aux répondants s'ils ont déjà pris un verre durant leur vie; on leur demande aussi à quelle fréquence ils ont consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois et combien d'alcool ils ont consommé.

Les informations obtenues grâce à ce module aideront les chercheurs et les planificateurs des soins de santé à comprendre les modèles de consommation d'alcool. Par exemple, quels groupes sont plus susceptibles de boire avec excès, c'est-à-dire boire quatre verres (cinq verres, dans le cas des hommes) ou plus à une même occasion.

ALC_R001

J'aimerais maintenant poser des questions sur votre consommation d'alcool.
Lorsqu'on parle d'un « verre », on entend par là :

- **une bouteille ou une petite canette de bière, de cidre ou de « cooler » à 5% d'alcool, ou un petit verre de bière en fût ;**
- **un verre de vin à 12% d'alcool ;**
- **un verre ou un cocktail contenant 1½ oz de spiritueux à 40% d'alcool.**

ALC_Q005

Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris un verre d'alcool?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine (ALW)

Thématique

Les questions de ce module questionnent les gens qui ont consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois sur leur consommation à chaque jour de la semaine précédente.

Ce module servira à déterminer si la population respecte les directives de consommation d'alcool à faible risque.

AWL_Q005	**Au cours de la semaine dernière, c'est-à-dire entre la semaine dernière et hier, est-ce que vous avez bu de la bière, du vin, un spiritueux ou toute autre boisson alcoolisée?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Utilisation de médicaments (MED) Optionnel	Ce module porte sur l'usage de médicaments prescrits ou de médicaments sans ordonnance au cours des douze derniers mois, y compris différents analgésiques, stimulants et sédatifs. Les résultats de ce module serviront à peindre une image des types de médicaments consommés par divers groupes de personnes. Les chercheurs se serviront de ces résultats pour examiner le rapport entre les problèmes de santé, la consommation de médicaments et l'utilisation d'autres services de soins de santé.
MED_R001	**La prochaine série de questions est au sujet de différents produits pharmaceutiques.** **La première série de questions porte sur votre usage d'<u>analgésiques</u> opioïdes. Nous entendons par analgésiques les produits renfermant des opioïdes tels que la codéine ou la morphine, ou d'autres médicaments opioïdes. La plupart de ces produits doivent être prescrits, mais certains produits contenant de la codéine sont vendus sans ordonnance, par exemple Tylenol no 1 ou 222.** **Nous <u>ne</u> sommes <u>pas</u> intéressés à l'usage d'antidouleurs comme Aspirin, Advil, Tylenol régulier, Celebrex, etc.** <u>INTERVIEWEUR</u> : Tylenol régulier et Tylenol Extra-fort ne contiennent pas de codéine et ne sont pas comptés. Tylenol 1, 2, 3 et 4 contiennent de la codéine et sont comptés.
MED_Q005	**Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé des produits contenant de la <u>codéine</u> comme du Tylenol no 3, Tylenol no 1, comprimés de 292 ou de 222?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Méthodes de consommation de drogues (DRM) Thématique	Aux répondants qui ont déjà utilisé des drogues illicites, on pose des questions sur les diverses méthodes employées pour consommer de telles drogues, par exemple se les injecter, les fumer, les renifler ou les prendre par voie orale. Ce module servira à analyser les comportements à risque concernant les méthodes de consommation de drogues.
DRM_R001	**Les prochaines questions portent sur différentes méthodes utilisées lorsque les gens consomment des drogues illicites.**

DRM_Q005

Avez-vous déjà fumé des drogues illicites?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Usage de substances (DRG)

Optionnel

Ce module porte sur l'usage d'un certain nombre de drogues et la consommation de ces drogues au cours des douze derniers mois, y compris la marijuana (que ce soit à des fins médicales ou illicites), la cocaïne, les amphétamines, l'ecstasy, les hallucinogènes, les solvants et les drogues non prescrites prises par injection.

Les réponses à ces questions serviront à déterminer à quels groupes les programmes de traitement pourraient être utiles.

DRG_R001

Je vais maintenant vous poser des questions sur votre usage de certaines drogues.

DRG_Q005

Avez-vous déjà pris ou essayé de la marijuana ou du haschich?

1. **Oui, juste une fois**
2. **Oui, plus d'une fois**
3. **Non**

NSP, RF

Jeu excessif (CPG)

Optionnel

Ces renseignements aideront à mieux comprendre l'ampleur du problème de jeu et à quel point les différents types de jeu sont répandus.

On demande aux répondants à quelle fréquence ils ont fait des paris ou dépensé de l'argent pour quatorze différents genres de jeu et combien ils ont dépensé en tout pour des activités de jeu au Canada au cours des douze derniers mois.

On pose ensuite une série de questions liées aux tendances au jeu et à ses expériences. Ces réponses servent à évaluer la probabilité selon laquelle le répondant a un problème lié au jeu.

Une dernière série de questions sont posées aux répondants qui peuvent avoir un problème lié au jeu afin d'évaluer jusqu'à quel point l'obsession du jeu se répercute sur la vie du répondant.

CPG_R001

Les prochaines questions portent sur différents types d'activités et d'expériences en matière de jeux de hasard que vous avez eus au Canada. Prenez <u>note</u> que les gens ont différentes définitions de ce que sont les jeux de hasard.

CPG_Q005

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous parié ou dépensé de l'argent sur un des jeux de hasard suivants :

Sur des billets de loteries hebdomadaires comme Lotto 6/49 ou Lotto Max?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Activités physiques – Adultes 18 ans et plus (PAA)

Commun

Les réponses aux questions de ce module servent à déterminer dans quelle mesure les répondants âgés de 18 ans et plus ont été actifs au cours des sept derniers jours.

On demande aux répondants s'ils ont passé au moins dix minutes à faire des activités physiques, comme de la marche ou de la bicyclette pour se rendre à un endroit, du sport ou des activités récréatives qui les ont fait transpirer ou respirer plus fort, et à quels jours de la semaine ils ont fait ces activités. On demande aussi aux répondants combien de temps ils ont passé en tout à faire des activités d'intensité élevée.

On pense généralement qu'un niveau d'activité élevé est lié à une meilleure santé. Ce module sera utilisé pour savoir dans quelle mesure la population suit les Directives canadiennes en matière d'activité physique pour les adultes.

PAA_R001

Les prochaines questions concernent divers types d'activités physiques que vous avez faites au cours des 7 derniers jours. Pensez aux activités que vous avez faites pendant <u>au moins 10 minutes en continu</u>.

PAA_Q005

Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de la semaine dernière à hier, avez-vous utilisé des moyens actifs tels que la marche ou la bicyclette <u>pour vous déplacer vers un endroit</u>, comme le travail, l'école, l'arrêt d'autobus, le centre d'achat ou chez des amis?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Activités physiques pour les jeunes (PAY)

Commun

Les réponses aux questions de ce module servent à déterminer dans quelle mesure les répondants âgés de 12 à 17 ans ont été actifs au cours des sept derniers jours.

On demande aux répondants à quels jours de la semaine ils ont été actifs et combien de temps ils ont passé à faire des activités comme de la marche ou de la bicyclette (pour se rendre à l'école, au travail, à un centre commercial ou chez des amis), ou à faire du sport, des loisirs ou d'autres activités qui les ont fait transpirer ou respirer plus fort. On demande aussi aux répondants combien de temps ils ont passé en tout à faire des activités d'*intensité* élevée.

On estime généralement que les niveaux plus élevés d'activité sont associés à une meilleure santé. Ce module sera utilisé pour savoir dans quelle mesure la population suit les Directives canadiennes en matière d'activité physique pour les jeunes.

PAY_R001

Les prochaines questions portent sur divers types d'activités physiques que vous avez faites chaque jour de la dernière semaine.

PAY_Q005

Au cours des 7 derniers jours, c'est-à-dire de la semaine dernière à hier, avez-vous...?

1. **Fréquenté l'école**
2. **Fréquenté un camp de jour**
3. **Occupé un emploi rémunéré ou non rémunéré**
4. Aucun des choix ci-dessus

NSP, RF

Utilisation de l'équipement protecteur (UPE)

Optionnel

Les blessures subies pendant les loisirs imposent un lourd fardeau à la fois aux personnes blessées et au système de soins de santé.

Ce module porte sur le port de casques, de protecteurs de poignets et de coudes, et de protège-dents afin de se protéger pendant des activités comme la bicyclette, le patin à roues alignées, le ski, la planche à neige, la planche à roulettes et le hockey.

Les résultats de ce module sont très utiles aux planificateurs en matière de santé afin de concevoir des programmes de promotion du port d'équipement de protection.

UPE_R001

Maintenant, quelques questions à propos des précautions que vous prenez lorsque vous participez à certaines activités physiques.

UPE_Q005

Au cours des derniers 12 mois, avez-vous fait de la bicyclette?

Protection contre le soleil (SSB)

Optionnel

Les questions de ce module portent sur les coups de soleil au cours des douze derniers mois, l'exposition typique au soleil durant les mois d'été et les mesures que les gens peuvent prendre pour réduire les risques d'exposition au soleil, comme porter un chapeau, rester à l'ombre et utiliser des écrans solaires. On demande aussi aux répondants s'ils ont utilisé des lits de bronzage et, dans l'affirmative, d'indiquer pourquoi.

Les résultats de ce module peuvent servir à mesurer l'efficacité des programmes de santé publique mettant la population en garde contre les dangers de l'exposition au soleil.

SSB_R001

Les questions qui suivent portent sur l'exposition au soleil et divers comportements reliés au soleil.

SSB_Q005

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un coup de soleil sur une partie ou une autre de votre corps?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Activités sédentaires (SAC)

Contenu optionnel

On entend par activité sédentaire le temps qu'on passe assis à faire peu d'activité physique ou pas du tout. Dans ce module, on demande aux répondants combien d'heures, au cours des sept derniers jours, ils ont passées à jouer à des jeux vidéo ou sur ordinateur (que ces jeux exigent de l'activité physique ou non), à regarder la télévision, à lire, ou à utiliser un ordinateur ou un téléphone, seulement pendant leur temps libre (cela ne comprend pas les activités que les répondants font en classe, lorsqu'ils se déplacent ou lorsqu'ils qu'ils font de l'exercice).

Les résultats sont importants pour comprendre l'état de santé général, puisque trop de temps passé à faire des activités sédentaires pourrait être lié à un manque d'activité physique, une pauvre alimentation et autres problèmes de santé.

SAC_R001

Maintenant, voici quelques questions supplémentaires sur vos loisirs, c'est-à-dire des activités que vous n'effectuez pas au travail, ni en classe, ni durant le déplacement.

Certaines activités pourraient vous semblez similaires, mais veuillez déclarer vos activités une seule fois.

SAC_Q005

Au cours des 7 derniers jours, combien d'heures de vos temps libres avez-vous passé :

à lire des livres, des magazines ou des journaux, incluant ceux en format électronique? Inclure le temps passé à lire dans le cadre des devoirs, mais ne pas inclure le temps passé à lire au travail, en classe, durant le déplacement ou pendant que vous faites de l'exercice.

INTERVIEWEUR : Inclure les livres, les lecteurs de livres électroniques, les revues, les journaux et les devoirs. N'incluez pas le temps passé à lire à l'ordinateur, sur une tablette ou Internet. Inscrivez le temps en heures, à la demi-heure près.

Comportements sexuels (SXB)

Thématique

La compréhension des comportements sexuels est un élément important de la compréhension de la santé en général. Par exemple, des relations sexuelles non protégées peuvent causer la propagation de maladies transmises sexuellement pouvant avoir des répercussions graves à long terme. Certaines femmes qui deviennent enceintes sans l'avoir prévu ou sans être dans une relation stable risquent de ne pas avoir les soins prénataux adéquats et peuvent ne pas pouvoir donner à leur enfant un bon départ dans la vie.

Ce module comprend une introduction où sont données les raisons pour lesquelles on pose ces questions et dans laquelle on rappelle au répondant que toutes les réponses sont confidentielles. Certains répondants risquent néanmoins de trouver certaines questions très personnelles et peuvent ne pas se sentir suffisamment à l'aise pour y répondre. Ne sait pas et refus sont des réponses acceptables pour toutes les questions de ce module. **Veuillez vous référer au chapitre 2 pour le matériel portant sur les interviews de nature délicate.**

Les questions de ce module sont posées aux répondants âgés de 15 à 64 ans. Elles portent sur ce qui suit (relations sexuelles vaginales et anales seulement) : l'âge du répondant et du partenaire au moment de la première relation sexuelle et de la plus récente; l'orientation sexuelle du partenaire; le nombre de partenaires sexuels au cours des douze derniers mois; l'usage de condoms et les raisons pour lesquelles un condom a été utilisé ou non.

On pose ensuite quelques questions à propos d'autres méthodes de contraception (à part le condom), y compris un contraceptif oral d'urgence, et combien de fois celui-ci a été utilisé au cours des douze derniers mois (dans le cas des femmes âgées de 15 à 48 ans).

Comportements sexuels (SXB) (suite) Thématique	Les dernières questions du module portent sur les tests de dépistage d'infections transmissibles sexuellement (le VIH et autres infections).
SXB_R001	**Les prochaines questions portent sur les comportements sexuels. Certaines questions peuvent vous sembler délicates, mais elles sont incluses dans cette enquête parce qu'elles permettront de surveiller des enjeux importants en matière de santé publique, tels que le risque d'infections transmissibles sexuellement et les grossesses non désirées.**
SXB_Q005	**Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Veuillez inclure les relations sexuelles vaginales et anales.** 1. Oui 2. Non NSP, RF Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P., confirmez.
Expériences maternelles – Allaitement (MEX) Optionne	De plus en plus, les programmes de promotion de la santé ciblent les très jeunes enfants. Les chercheurs estiment que les enfants ayant un bon départ dans la vie deviennent des adolescents et des adultes en santé. Les trois prochains modules visent principalement le comportement des nouvelles mères (âgées de 15 à 55 ans) d'enfants ayant moins de six ans. Les questions du premier module portent sur des sujets tels que les suppléments d'acide folique et de fer, la prise de poids, l'allaitement, l'endroit où dort l'enfant et l'alimentation de l'enfant. Les résultats de ce module pourront servir à identifier les groupes de femmes qui pourraient bénéficier de programmes visant à promouvoir la santé des bébés.
MEX_R001	**Les questions qui suivent sont propres à la santé des femmes.**
MEX_Q005	**Prenez-vous un supplément vitaminique contenant de l'acide folique?** <u>INTERVIEWEUR</u> : Si la répondante déclare qu'elle prend une vitamine prénatale, mais qu'elle n'est pas certaine de ce que la vitamine contient, veuillez sélectionner « oui ». 1. Oui 2. Non NSP, RF

Expériences maternelles – Usage du tabac au cours de la grossesse (MXS)
Commun

Ce module sert à déterminer si les femmes ont fumé des cigarettes avant ou durant leur grossesse et si elles ont été exposées à la fumée de tabac secondaire de façon régulière durant leur grossesse.

Les résultats de ce module pourront servir à identifier les groupes de femmes qui pourraient bénéficier de programmes visant à promouvoir la santé des bébés.

MXS_Q005

Au cours des trois mois ayant précédé votre grossesse de ^NOMDUBEBE, ou <u>avant</u> de savoir que vous étiez enceinte, avez-vous fumé des cigarettes?

<u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant.

1. Tous les jours
2. Presque tous les jours
3. Environ 2 ou 3 fois par semaine
4. Environ une fois par semaine
5. Une fois ou deux
6. Jamais

NSP, RF

Expériences maternelles – Consommation d'alcool (MXA)
Optionnel

Ce module sert à déterminer si les femmes ont consommé de l'alcool avant ou durant leur grossesse ou pendant qu'elles allaitaient.
Les résultats de ce module pourront servir à identifier les groupes de femmes qui pourraient bénéficier de programmes visant à promouvoir la santé des bébés.

MXA_Q005

Au cours des trois mois ayant précédé votre grossesse de ^NOMDUBEBE, ou <u>avant</u> de savoir que vous étiez enceinte, avez-vous bu de l'alcool?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Conduite et sécurité (DRV)
Optionnel

La compréhension des comportements en matière de sécurité des conducteurs et des passagers est essentielle afin de réduire les décès et les blessures causés par les accidents routiers et les collisions.
Dans ce module, les répondants qui ont conduit au cours des douze derniers mois sont interrogés à propos d'un certain nombre de sujets, y compris l'usage d'un téléphone cellulaire (avec ou sans un appareil mains libres) pendant qu'ils conduisaient un véhicule à moteur autre qu'une motocyclette.
Les répondants sont aussi interrogés sur la fatigue au volant, le nombre de fois qu'ils ont conduit après avoir consommé une substance illicite, ainsi que le nombre de fois qu'ils ont conduit un véhicule après avoir consommé de l'alcool ou qu'ils ont voyagé à bord d'un véhicule dont le conducteur avait consommé de l'alcool. Ces questions se rapportent à n'importe quel genre de véhicule.

Conduite et sécurité (DRV)
Optionnel (suite)

Ce module comprend aussi des questions sur le port d'un casque protecteur par les passagers ou les conducteurs d'un VTT ou d'une motoneige. Les répondants sont aussi interrogés sur le nombre de fois qu'ils ont conduit un VTT ou une motoneige après avoir consommé une substance illicite, ainsi que le nombre de fois qu'ils ont conduit un VTT ou une motoneige après avoir consommé de l'alcool ou qu'ils ont voyagé à bord d'un VTT ou d'une motoneige dont le conducteur avait consommé de l'alcool.

DRV_R001

Les questions suivantes portent sur la conduite d'un véhicule moteur.

DRV_Q005

Au cours des 12 derniers mois, en excluant les motocyclettes et les véhicules tout-terrains, avez-vous conduit un véhicule moteur tel qu'une automobile, un camion ou une fourgonnette?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Vaccins contre la grippe (FLU)
Commun

On demande aux répondants de donner la date de leur dernier vaccin contre la grippe, sauf le vaccin contre la grippe H1N1. Les répondants qui n'ont pas reçu de vaccin au cours de l'année dernière doivent en donner les raisons.

La grippe est une maladie grave pour certains groupes de personnes, en autres les personnes âgées. Pour tous les groupes, la grippe constitue une cause principale de perte de journées de travail, d'école et d'autres activités.

Les résultats de ce module serviront à identifier les groupes de personnes qui sont moins aptes à être vaccinées contre la grippe. Cette information servira lors de la planification et l'élaboration de nouveaux programmes de promotion du vaccin.

FLU_R001

Maintenant, quelques questions au sujet de votre utilisation de divers soins de santé.

FLU_Q005

Avez-vous déjà reçu un vaccin contre la grippe saisonnière, excluant le vaccin pour la grippe H1N1?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Examen général (PCU) Optionnel	Dans ce module, on demande aux répondants à quand remonte leur dernier examen médical général qui n'était pas relié à une grossesse ou à un problème particulier. Aux répondants qui n'ont pas subi un examen général au cours des trois dernières années, on demande de dire pourquoi. On demande aussi aux répondants d'indiquer s'ils ont été pesés, si on a mesuré leur taille, si on a pris leur tension artérielle, si on a vérifié leur taux de cholestérol et si un médecin a discuté avec eux des risques liés au poids. Les résultats de ce module seront précieux pour connaître quels sont les groupes de personnes qui sont les moins susceptibles de subir un bilan de santé et pourquoi.
PCU_R001	**J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos des examens généraux. Veuillez ne pas tenir compte des examens que vous avez eus pendant une visite pour un problème de santé ^GROSSESSE.**
PCU_Q005	**Avez-vous déjà passé un examen général?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Tension artérielle – Vérification (BPC) Contenu optionnel	Les maladies du cœur sont l'une des principales causes de décès au Canada. Une vérification régulière de la tension artérielle est un moyen efficace de diagnostic de l'hypertension, qui est liée de près aux maladies du cœur. Dans ce module, on demande aux répondants s'ils ont fait vérifier leur tension artérielle au cours des deux dernières années et, dans l'affirmative, à quel moment; dans la négative, on demande aux répondants de dire pourquoi. De plus, on demande aux femmes âgées de 15 à 55 ans si elles étaient enceintes au moment où leur tension artérielle a été vérifiée la dernière fois. En examinant les raisons pour lesquelles certains groupes ne font pas vérifier leur tension artérielle tel qu'il est recommandé, les planificateurs des soins de santé et d'autres peuvent élaborer des campagnes visant à sensibiliser le public à l'importance de la vérification de la tension artérielle.
BPC_R001	**Voici maintenant quelques questions sur la prise de la tension artérielle.**
BPC_Q005	**Avez-vous déjà fait prendre votre tension artérielle par un professionnel de la santé?** 1. Oui 2. Non NSP, RF Une réponse incompatible avec une réponse à une autre question a été inscrite. S.V.P. confirmez.

Test PAP (PAP)
Optionnel

Le cancer du col de l'utérus est le type de cancer le plus fréquent chez les Canadiennes. Un test PAP régulier est un moyen efficace de détecter ce type de cancer suffisamment tôt pour permettre un traitement efficace. Dans ce module, on demande aux répondantes âgées de 18 à 70 ans si elles ont subi un test PAP, et si elles n'ont pas subi l'examen au cours des 3 dernières années, pourquoi elles ne l'ont pas fait.

PAP_Q005

Avez-vous déjà passé un test PAP?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Mammographie (MAM)
Optionnel

La mammographie ou, une radiographie des seins, est un important outil de dépistage précoce du cancer du sein.
Dans ce module, on demande aux femmes âgées de 40 à 74 ans si elles ont déjà subi une mammographie et, dans l'affirmative, à quel moment. Aux femmes qui n'ont pas subi une mammographie au cours des trois dernières années, on demande d'indiquer pourquoi.

MAM_Q005

Avez-vous déjà passé une mammographie, c'est-à-dire une radiographie du sein?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Dépistage du cancer de la prostate (PSA)
Optionnel

Ce module porte des questions sur les deux méthodes de diagnostic commun pour identifier du cancer de la prostate :

1. Test de dépistage sanguin, consiste à prendre un échantillon de sang et à mesurer le niveau d'un élément précis, l'antigène spécifique prostatique. Un niveau élevé peut signifier qu'un patient court un risque plus élevé que la normale de souffrir d'un cancer de la prostate et d'autres tests sont généralement recommandés.
2. Toucher rectal, qui consiste pour le médecin à insérer un doigt ganté dans le rectum afin de vérifier si la prostate est hypertrophiée.

Les résultats de ce module peuvent être utilisés pour étudier le nombre de fois que l'examen est effectué et pour planifier les programmes de dépistage du cancer de la prostate et pour identifier quels groupes d'hommes bénéficieraient le plus de campagnes de sensibilisation à l'importance de la détection précoce du cancer de la prostate.
Les questions sont posées aux répondants masculins de 35 ans et plus.

PSA_R001

Maintenant, quelques questions sur les tests de la prostate.

PSA_Q005

Avez-vous déjà subi le test de l'antigène prostatique spécifique pour le dépistage du cancer de la prostate, c'est-à-dire une prise de sang pour le test « PSA »?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Dépistage du cancer du côlon et du rectum (CCS)

Optionnel

Le cancer colorectal est l'un des cancers les plus fréquents et les plus graves au Canada.

Dans ce module, on pose aux répondants des questions sur les deux méthodes les plus courantes de dépistage du cancer colorectal :

1. Le RSOS, consiste à détecter la présence de sang dans les selles.
2. La coloscopie ou une sigmoïdoscopie, consiste à insérer un tube dans le rectum afin de détecter différents problèmes de santé, notamment le cancer.

Les résultats de ce module peuvent servir pour étudier le nombre de fois que l'examen est effectué, et à planifier les programmes de dépistage du cancer colorectal et à identifier les groupes qui bénéficieraient le plus de campagnes de sensibilisation à l'importance de la détection précoce du cancer colorectal.

Les questions sont posées à tous les répondants âgés de 40 à 74 ans.

CCS_R001

Maintenant quelques questions au sujet de divers examens du côlon et du rectum.

CCS_Q005

Un « RSOS » est un test qui consiste à détecter la présence de sang dans les selles. Au moyen d'un bâtonnet, vous prélevez un petit échantillon de votre selle que vous étalez sur une carte spéciale.

Avez-vous déjà passé ce test?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Spirométrie (SPI)

Optionnel

Dans ce module, on demande aux répondants s'ils ont déjà passé ce test courant de la fonction respiratoire. Si oui, on leur demande à quand remonte la dernière fois.

Ces questions seront employées pour examiner la proportion de la population qui a déjà passé le test de spirométrie et les caractéristiques de cette population. Un diagnostique précoce des maladies pulmonaires communes aide à contrôler la progression et les conséquences de ces maladies.

SPI_Q005	**Le test de spirométrie est un test courant de la fonction respiratoire qui consiste à souffler dans un petit tube relié à une machine. Avez-vous déjà passé ce test?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Soins pour le diabète (DIA) Optionnel	Dans ce module, on interroge les répondants diabétiques (Non gestationnels) sur les soins qu'ils reçoivent à cet égard. On interroge les répondants sur : • les tests ou les examens que leur ont fait subir des professionnels de la santé, comme le test d'hémoglobine « A1C », un examen des pieds, un test d'urine, un examen de la vue et une thérapie nutritionnelle; • les tests ou les examens qu'ils ont fait eux-mêmes ou qui ont été faits par d'autres personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé, comme une vérification du taux de glucose ou un examen des pieds; • les médicaments qu'ils pourraient prendre. Le diabète est un problème de santé en croissance au Canada. On peut utiliser les réponses à ces questions pour étudier les soins que les personnes au Canada reçoivent pour les aider à contrôler leur diabète.
DIA_R001	**Vous avez rapporté plus tôt, que vous êtes atteint(e) du diabète. Les questions suivantes portent sur les soins pour le diabète.**
DIA_Q005	**Au cours des 12 derniers mois, un professionnel de la santé vous a-t-il fait subir le test d'hémoglobine « A1C »? (Le test d'hémoglobine « A1C » consiste à mesurer la concentration moyenne de sucre dans le sang sur une période de trois mois.)** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Examens de la vue (EYX) Optionnel	Dans ce module, les répondants sont interrogés à propos de la santé et des soins de leurs yeux; on leur pose notamment des questions à propos d'une assurance couvrant le coût des lunettes ou des verres de contact. On demande aussi aux répondants s'ils ont vu un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des douze derniers mois et, dans la négative, à quand remonte leur dernier examen de la vue. Aux répondants âgés de moins de 19 ans ou de plus de 65 ans qui n'ont pas subi un examen de la vue au cours des deux dernières années, on demande de dire pourquoi. De plus, on demande aux répondants âgés de 40 ans et plus s'ils sont atteints de cataracte ou de glaucome. Les résultats de ce module serviront à mieux comprendre quels groupes sont les plus susceptibles de ne pas faire d'examen de la vue et pourquoi.

EYX_R001

Maintenant, quelques questions sur la santé et les soins de vos yeux.

EYX_Q005

Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie le coût des lunettes ou des verres de contact?

Stigmatisation à l'égard de la dépression (STG)

Optionnel

Dans ce module, on interroge les répondants à propos de la façon dont ils perçoivent les attitudes d'autrui envers les personnes souffrant de dépression, notamment si ces personnes sont dignes de confiance, si d'autres seraient réticents à se lier d'amitié ou à sortir avec de telles personnes, et si les employeurs hésiteraient à les embaucher.

Les chercheurs s'intéressent aux attitudes négatives que les Canadiens pourraient avoir envers les personnes souffrant de dépression. Il est important de comprendre la stigmatisation de la dépression, car cela peut souvent être un obstacle au traitement.

Les résultats de l'enquête fourniront des renseignements de base à propos des attitudes envers les personnes souffrant de dépression et ils serviront ensuite à suivre l'évolution des attitudes au fil du temps.

STG_R001

Les questions suivantes portent sur ce qu'éprouvent les gens à l'égard des personnes qui ont souffert de dépression. Par dépression, nous entendons une période prolongée de tristesse ou de perte d'intérêt pour les activités habituelles qui interfère avec la vie quotidienne.

Je vais vous lire une série d'énoncés. Pour chacun d'entre eux, dites-moi ce qu'éprouvent, selon vous, la plupart des gens que vous connaissez, même si vous ne partagez pas leur opinion. Je vous demanderai votre opinion plus tard.

STG_Q005

La plupart des gens que vous connaissez n'accepteraient pas volontiers d'avoir une personne qui a souffert de dépression comme ami proche. Êtes-vous…?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. La plupart des gens que vous connaissez incluent par exemple la famille, les amis, les collègues de travail.

1. **Tout à fait d'accord**
2. **D'accord**
3. **Ni d'accord ni en désaccord**
4. **En désaccord**
5. **Tout à fait en désaccord**

NSP, RF

Santé mentale positive (PMH)

Thématique

Les réponses à ce module serviront à mesurer la santé mentale positive du répondant. On estime généralement qu'un niveau élevé de santé mentale positive est associé à une meilleure santé générale.

Les questions de ce module servent à déterminer à quelle fréquence, au cours du dernier mois, les répondants ont eu des sentiments positifs envers eux-mêmes, leur vie, leurs expériences, leur environnement et la société.

PMH_R001

Les questions suivantes portent sur comment vous vous êtes senti(e) au cours du dernier mois.

PMH_Q005

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes-vous senti(e) :

heureux(euse)?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1. **Tous les jours**
2. **Presque tous les jours**
3. **Environ 2 ou 3 fois par semaine**
4. **Environ 1 fois par semaine**
5. **Une fois ou deux**
6. **Jamais**

NSP, RF

Consultations au sujet de la santé mentale (CMH)

Thématique

Ce module cherche à savoir combien de fois, au cours des 12 derniers mois, le répondant a fait appel aux services de professionnels de la santé mentale pour discuter de sa santé émotionnelle et mentale, et quels professionnels de la santé il a vus ou consultés.

Les résultats aideront les planificateurs à comprendre la façon avec laquelle les services de santé mentale en place sont utilisés et de cibler de nouveaux services aux groupes de personnes qui en ont le plus besoin.

CHM_R001

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions concernant le bien-être mental et émotif.

CHM_Q005

Au cours des 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant ^DV_DATEONEYEARAGO et se terminant hier, avez-vous vu ou consulté un professionnel de la santé au sujet de votre santé émotionnelle ou mentale?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Satisfaction à l'égard de la vie (SWL) **Contenu optionnel**	Ce module comprend des questions sur le niveau de satisfaction du répondant face à différents aspects de sa vie, y compris son travail, ses expériences, sa situation financière, lui-même, ses relations, son logement et son quartier. Les chercheurs s'intéressent au lien entre la satisfaction de la vie et le bien-être physique et mental.
SWL_R001	**Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur votre satisfaction face à divers aspects de votre vie. Pour chaque question, veuillez me dire si vous êtes <u>très</u> satisfait(e), satisfait(e), ni satisfait(e) ni insatisfait(e), insatisfait(e) ou <u>très</u> insatisfait(e).**
SWL_Q005	**Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre emploi ou votre activité principale?** <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1. **Très satisfait(e)** 2. **Satisfait(e)** 3. **Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)** 4. **Insatisfait(e)** 5. **Très insatisfait(e)** NSP, RF
Estime de soi (SFE) **Contenu optionnel**	L'estime de soi, ou les sentiments positifs et la confiance en soi sont considérés comme très importants pour aider les personnes à confronter des problèmes d'ordre physique et mental. Ce module consiste en six questions qui serviront à calculer une cote globale relative à l'estime de soi de chaque répondant.
SFE_R001	**Voici une série d'énoncés que les gens peuvent utiliser pour se décrire.** **Veuillez me dire si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni d'accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord avec les énoncés qui suivent.**
SFE_Q005	**Vous estimez que vous avez un certain nombre de qualités. Êtes-vous...?** <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1. **Tout à fait** 2. **D'accord** 3. **Ni d'accord ni en désaccord** 4. **En désaccord** 5. **Tout à fait en désaccord** NSP, RF

Détresse (DIS) Optionnel

Ce module examine à quelle fréquence le répondant a ressenti différents sentiments au cours du dernier mois, y compris la fatigue, la nervosité, le désespoir, la dévalorisation, l'agitation ou l'impatience, la tristesse ou la dépression, et le sentiment que tout est un effort.

On demande aussi aux répondants de comparer leurs sentiments de détresse avec leurs sentiments habituels et d'évaluer dans quelle mesure leurs sentiments de détresse ont dérangé leur vie au cours du dernier mois.

Les réponses à toutes ces questions sont combinées afin de mesurer le niveau de détresse global du répondant.

La détresse est un facteur important qui influe sur le bien-être mental. Un sentiment de détresse peut nuire à différents aspects de la vie, y compris à la santé physique et émotionnelle.

Nota : ce module n'est pas sélectionné pour 2015

DIS_R001

Les questions suivantes portent sur des sentiments que vous auriez pu vivre au cours du dernier mois.

Dépression (DEP) Optionnel

Bien des gens peuvent se sentir déprimés à un moment ou un autre, et ce à différents degrés. Cependant, la dépression de longue durée peut constituer un grave problème de santé, à la fois sur le plan physique et mental.

Ce module consiste en une série de questions détaillées qui touchent à la dépression. Les réponses seront regroupées pour déterminer jusqu'à quel point le répondant est déprimé.

Ce module recueille de l'information sur la durée des épisodes de dépression, le moment auquel ils se sont produits et leurs conséquences.

DEP_R001

Les questions suivantes portent sur certains problèmes que vous auriez pu avoir au cours des deux dernières semaines.

DEP_Q005

Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous :

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

eu peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses?

1. **Pas du tout**
2. **Plusieurs jours**
3. **Plus de la moitié des jours**
4. **Presque tous les jours**

NSP, RF

Pensées suicidaires et tentatives de suicide (SUI) Thématique	Le suicide est une préoccupation importante pour la société d'aujourd'hui. Ce module sert à recueillir des renseignements sur les pensées suicidaires et les tentatives de suicide des répondants. On leur demande, entre autres choses, s'ils ont fait un plan pour tenter de se suicider au cours des douze derniers mois, quel âge ils avaient la dernière fois qu'ils ont songé à se suicider ou qu'ils ont projeté ou tenté de le faire, le nombre de fois qu'ils ont tenté de se suicider durant leur vie, et s'ils ont eu besoin de soins médicaux à la suite de la plus récente tentative. Ces questions sont posées qu'aux répondants de 15 ans et plus.
SUI_R001	**Les questions suivantes pourraient être délicates pour certaines personnes, mais nous devons poser les mêmes questions à tout le monde.**
SUI_Q005	**Avez-vous déjà <u>sérieusement</u> songé à vous suicider?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Stress au travail (WST) Optionnel	Ce module comprend une série de questions qui traitent d'aspects liés au travail ou à l'entreprise du répondant qui peuvent être stressants. Cela entend des situations où le répondant doit éventuellement apprendre de nouvelles choses, avoir une charge de travail intense et être exposé à des conflits avec des collègues ou des surveillants. Ce module ne s'adresse qu'aux répondants âgés entre 15 et 75 ans qui ont eu un emploi ou qui ont travaillé dans une entreprise à un moment donné au cours des 12 derniers mois. Les résultats de ce module serviront à étudier le rapport entre le stress lié au travail, les problèmes de santé et l'utilisation de services de soins de santé.
WST_R001	**Je vais vous lire une série d'énoncés qui peuvent décrire votre situation d'emploi principal au cours des 12 derniers mois. Dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord, d'accord, ni en accord ni en désaccord, en désaccord ou entièrement en désaccord.**
WST_Q005	**Votre travail exigeait l'acquisition de nouvelles connaissances.** <u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. 1. **Tout à fait d'accord** 2. **D'accord** 3. **Ni d'accord ni en désaccord** 4. **En désaccord** 5. **Entièrement en désaccord** NSP, RF

Sources de stress (STS) Optionnel

Le rapport entre le stress et la santé est complexe. À titre d'exemple, le stress peut être la cause de certains problèmes de santé et la conséquence d'autres problèmes de santé.
Les résultats de ce module aideront les planificateurs des services de santé à déterminer quelles sont les sources de stress les plus courantes et à créer des programmes pour promouvoir de saines façons de lutter contre le stress.
Ce module couvre une série de questions liées au stress, dont la capacité de traiter de problèmes inattendus et difficiles, les exigences quotidiennes, et la source principale de stress dans la vie de tous les jours.

STS_R001

Maintenant quelques questions sur le stress dans votre vie.

STS_Q005

En général, comment évaluez-vous votre capacité à faire face à des problèmes inattendus et difficiles, par exemple, une crise familiale ou personnelle? Diriez-vous que votre capacité est...?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1. **Excellente**
2. **Bonne**
3. **Passable**
4. **Faible**

NSP, RF

Provisions sociales (SPS) Optionnel

Les relations d'une personne avec ses amis, sa famille, ses collègues et d'autres personnes peuvent influer grandement sur sa santé mentale et physique.
Ce module comporte une série de questions sur le niveau d'attachement, d'intégration sociale, de confiance en soi, d'alliances fiables et d'encadrement du répondant.

SPS_R001

Les questions qui suivent portent sur vos relations habituelles avec vos amis, les membres de votre famille, vos collègues de travail, les membres de votre communauté ou toute autre personne. Indiquez dans quelle mesure chaque énoncé décrit vos relations avec les autres.

SPS_Q005

Il y a des personnes sur qui je peux compter pour m'aider en cas de réel besoin.
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1. **Tout à fait d'accord**
2. **D'accord**
3. **En désaccord**
4. **Tout à fait en désaccord**

NSP, RF

Survol du module Attachement au médecin (MDA)

Le présent module fournit des renseignements sur le niveau d'attachement des Canadiens à leur médecin. S'ils ont un médecin de famille ou un omnipraticien, on leur demande depuis quand ils consultent ce médecin. S'ils n'ont pas de médecin, on leur demande s'ils en cherchent un.
S'ils vont dans un « endroit habituel pour recevoir des soins » où il y a plus d'un médecin, on leur demande quel est le nombre de médecins qu'ils peuvent consulter, et quelle est la fréquence à laquelle ils sont soignés par le même médecin.
Les données recueillies permettront aux chercheurs de voir à quel point les Canadiens sont suivis par un médecin habituel.

MDA_Q005

Depuis combien de temps avez vous^AVEZ-^VOUS_T ^VOTRE1 médecin de famille ou médecin généraliste?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si nécessaire, vous pouvez guider le répondant « Il s'agit du médecin consulté régulièrement. »

1. **Moins de 6 mois**
2. **6 mois à moins de 12 mois**
3. **1 an à moins de 2 ans**
4. **2 ans ou plus**

NSP, RF

Soins de santé primaires (PHC)

Commun

Les soins de santé primaires sont souvent le premier point d'entrée dans le système de soins de santé du Canada. Cela comprend le diagnostic, le traitement et la gestion des problèmes de santé.

Ce module porte sur un certain nombre de sujets concernant les soins de santé primaires. On demande au répondant, entre autres choses, s'il y a un endroit où il va habituellement lorsqu'il a besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur, s'il a un fournisseur habituel de soins de santé, quelle langue il parle lors de ses rendez-vous, ainsi que les genres de professionnels de la santé qu'il consulte.

Ce module est utile aux gouvernements, aux planificateurs de soins de santé et aux chercheurs. Par exemple, les résultats pourront servir à faire des comparaisons entre différents groupes – les hommes et les femmes, les jeunes et les aînés, les régions urbaines et rurales – concernant l'usage des services de santé. Ils permettront aussi de suivre les changements au fil du temps, en ce qui a trait aux endroits où vont les Canadiens lorsqu'ils ont besoin de soins de santé et quels professionnels de la santé ils choisissent de consulter.

PHC_R001

Maintenant, j'aimerais vous poser des questions au sujet de vos soins de santé primaires. Il s'agit souvent du premier point d'entrée dans le système de santé canadien. Ceci inclut les diagnostiques, les traitements et la gestion des problèmes de santé.

PHC_Q005

Y a-t-il un endroit où vous allez habituellement quand vous avez besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur?
INTERVIEWEUR : Si le répondant est allé à plusieurs endroits dans les 12 derniers mois, S.V.P., référez à l'endroit où il/elle est allée le plus souvent.

1. Oui
2. Non

NSP, RF

PHC_Q010

De quel genre d'endroit s'agit-il?
INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Exclure Internet comme « endroit » habituel pour recevoir des soins.

1. **Bureau du médecin**
2. **Clinique externe d'un hôpital**
3. **Centre de santé communautaire CLSC**
4. **Clinique sans rendez-vous**
5. **Salle d'urgence d'un hôpital**
6. **Un autre endroit**

NSP, RF

Contacts avec certains professionnels de la santé – Partie 1 (CHP) Commun

Ce module a pour but de recueillir des renseignements sur les consultations auprès de divers professionnels de la santé et sur l'usage des services de soins de santé. Cela comprend l'usage de services de soins à domicile au cours des douze derniers mois, les visites à la salle des urgences d'un hôpital, le nombre de nuits passées à l'hôpital, etc.
Les questions portent aussi sur la nature et la fréquence des consultations auprès d'un médecin de famille ou d'un omnipraticien, d'un spécialiste de la vue, d'un autre genre de médecin, d'une infirmière ou d'un professionnel de la santé dentaire pour des raisons de santé physique, mentale ou émotionnelle.
Ce module est utile pour les gouvernements, les planificateurs et les chercheurs. Il permet par exemple de comparer comment les différents groupes - p. ex. les hommes et les femmes, les jeunes et les personnes âgées, les gens des régions urbaines et rurales – utilisent les soins de santé. Ce type de recherche peut servir à cibler les groupes ayant besoin d'un meilleur accès aux soins de santé.

CHP_R001

J'aimerais vous poser quelques questions sur vos consultations avec divers professionnels de la santé et votre utilisation de certains services de soins de santé durant les 12 derniers mois, c'est-à-dire la période commençant il y a un an et se terminant hier.

CHP_R005

Les soins à domicile sont des services fournis à votre demeure en raison d'un problème de santé ou d'une limitation des activités quotidiennes; ils peuvent inclure, par exemple, des soins infirmiers, la préparation de repas, l'aide pour prendre un bain ou l'entretien ménager. Ne pas inclure l'aide reçue par la famille, les amis ou les voisins.

CHP_Q005	**Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des services de soins à domicile?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Contacts avec certains professionnels de la santé – Bloc rallongé (CP2) **Optionnel**	L'objectif de ce module est de recueillir de l'information sur la fréquence des consultations avec divers professionnels de la santé au cours des 12 derniers mois et l'endroit où les consultations ont eu lieu, pour des raisons de santé physique, émotionnelle ou mentale. Les questions portent sur les professionnels de la santé suivants : chiropraticien, physiothérapeute, psychologue, travailleur social ou conseiller, audiologiste, orthophoniste, ergothérapeute, diététicien ou nutritionniste, ou pharmacien. **Nota :** ce module n'est pas sélectionné pour 2016.
CP2_Q005	**Avez-vous vu ou consulté l'un ou l'autre des professionnels de la santé suivants à propos de votre santé physique, émotionnelle ou mentale :** **un chiropraticien?** INTERVIEWEUR : Inclure le contact en personne et par téléphone. 1. Oui 2. Non NSP, RF
CP2_Q010	**Combien de fois (au cours des 12 derniers mois)?**
Satisfaction des patients – Soins de santé communautaire (PSC) **Optionnel**	Ce module sert à déterminer si les répondants ont reçu des soins communautaires au cours des douze derniers mois (hors d'un hôpital ou d'un bureau de médecin). On leur demande aussi d'évaluer la qualité des soins qu'ils ont reçus et d'indiquer dans quelle mesure ils étaient satisfaits de ces soins. Les services de soins de santé communautaires comprennent notamment les soins infirmiers à domicile, les services de thérapie ou de counselling à domicile, les soins personnels et les cliniques communautaires sans rendez-vous.
PSC_R001	**Les prochaines questions portent sur les soins de santé communautaire, ce qui inclut les autres soins de santé reçus hors d'un hôpital ou d'un bureau de médecin.** **En voici des exemples : les soins infirmiers à domicile, les services de thérapie ou de counselling à domicile, les soins personnels et les cliniques de santé communautaires.**

PSC_Q005

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des soins de santé communautaire?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Consultations avec un professionnel de la santé sur le tabagisme (SPC)

Optionnel

Dans ce module, on demande aux répondants qui fument si leur fournisseur habituel de soins de santé ou leur dentiste sait qu'ils fument ou leur a conseillé de cesser de fumer ou de réduire leur consommation de cigarettes. Les fumeurs sont aussi interrogés à propos du genre d'aide qu'ils ont reçu de leur fournisseur habituel de soins de santé ou de leur dentiste, le cas échéant.

Les résultats de ce module aideront à comprendre le rôle que les fournisseurs habituels de soins de santé, les dentistes et les pharmaciens peuvent jouer pour aider les gens à réduire leur consommation de cigarettes.

Nota : ce module n'est pas sélectionné pour 2015

SPC_Q005

Votre physicien sait-il que vous fumez la cigarette?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Expériences comme patient (PEX)

Thématique

Les questions de ce module portent sur la dernière fois que le répondant a consulté un professionnel de la santé, que ce soit sur place ou par téléphone. Cela ne comprend pas les séjours à l'hôpital, les visites chez le dentiste, les soins d'urgence ou après un accident, les soins reçus à domicile, ni les soins de médecine parallèle. On demande aussi au répondant d'évaluer la qualité du temps qu'il a passé avec le professionnel de la santé et d'indiquer son degré de satisfaction générale à l'égard de la consultation.

Les renseignements recueillis dans ce module serviront à déterminer quels aspects du système de santé peuvent être améliorés en ce qui a trait à l'expérience des patients.

PEX_R001

Les prochaines questions portent sur votre dernière consultation auprès d'un professionnel de la santé.

PEX_Q005

À quand remonte la dernière fois que vous avez consulté un professionnel de la santé afin de recevoir des soins pour vous-même? Excluez les soins reçus lors d'un séjour à l'hôpital, les visites chez le dentiste, les soins d'urgence ou lors d'un accident, ou les soins reçus à domicile.

1. Au cours des 30 derniers jours
2. Entre 1 mois et 3 mois
3. Plus de 3 mois, mais moins de 6 mois
4. Entre 6 mois et 12 mois
5. Entre 1 an et 2 ans
6. Plus de 2 ans

NSP, RF

Accès aux services de soins de santé (ACC)

Optionnel

Ce module recueille des renseignements sur les impressions et les expériences des canadiens relativement à l'accès aux différents services de soins de santé. Ces questions seront posées aux répondants qui sont âgés de 15 ans et plus. Sont compris :

- soins de santé prodigués par un spécialiste
- interventions chirurgicales non urgentes
- tests de diagnostic tels que les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM), les examens de tomodensitométrie (CT-SCAN) et les angiographies
- obtenir des renseignements ou conseils relatifs à la santé
- services médicaux ou dentaires de routine ou de suivi
- soin immédiat pour un problème mineur de santé

On demande au répondant s'il a eu des difficultés à obtenir les soins de santé qu'il nécessitait.

Ce module servira à faire des comparaisons entre différents groupes de Canadiens en ce qui a trait à leur usage des services de soins de santé (y compris l'heure et le jour de la semaine) et aux difficultés qu'ils ont eues à obtenir de tels services.

ACC_R001

Les prochaines questions portent sur l'utilisation de divers soins de santé.

Je vais commencer par vous poser des questions sur vos expériences dans l'obtention de soins de santé d'un médecin spécialiste, comme un cardiologue, un endocrinologue, un allergologue, ou un psychiatre (excluant un optométriste).

ACC_Q005

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de visiter un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Temps d'attente (WTM) Optionnel

Ce module recueille des renseignements sur les perceptions et les expériences vécues par le répondant en ce qui concerne les temps d'attente pour certains services de santé, y compris les visites chez les spécialistes pour de nouvelles conditions de santé, les chirurgies non-urgentes et les tests diagnostics particuliers. Les questions de ce module sont posées aux répondants âgés de 15 ans et plus.

Ce module est composé de trois parties, une pour chacun des trois types de services de soins de santé.

Pour chacun des trois types de services, ce module recueille des informations sur :

- Le type de service reçu ou le type de condition qui a été traitée
- Les difficultés à obtenir les services
- La durée du temps passé à attendre pour les services de santé
- L'avis du répondant à savoir si le temps d'attente était acceptable

On demande aussi au répondant s'il croit que l'attente a eu des conséquences sur sa santé ou d'autres aspects de sa vie.

WTM_R001

Maintenant quelques questions supplémentaires qui portent sur votre expérience en vue de l'obtention de services de santé.

WTM_Q005

Vous avez dit que vous avez eu besoin de visiter un médecin spécialiste, comme un cardiologue, un endocrinologue, un allergologue une gynécologue, un psychiatre.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu besoin de visiter un médecin spécialiste pour un diagnostic ou une consultation se rapportant à un nouveau problème de santé?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Services de soins de santé à domicile (HMC) Contenu thématique

Dans ce module, on demande au répondant de 18 ans ou plus s'il a reçu des services de soins à domicile, comme des soins infirmiers, la préparation des repas, l'aide pour se laver ou faire les travaux ménagers, que ces services aient été fournis au répondant ou à un autre membre du ménage.

On interroge aussi les répondants à propos de la durée des services, du coût et du paiement, du degré de satisfaction à l'égard des soins, des soins nécessaires qui n'ont pu être obtenus, des raisons pour lesquelles ces soins n'ont pu être obtenus et des endroits où les répondants ont tenté d'obtenir ces services.

Les services à domicile sont un élément important de la réforme des soins de santé. Le système de soins de santé et le patient peuvent bénéficier de la prestation de certains services à domicile plutôt que dans un hôpital ou dans un établissement de santé.

Les réponses à ce module peuvent être utilisées pour déterminer qui reçoit des services à domicile et qui n'en reçoit pas. On peut ensuite comparer l'état de santé de ces groupes et la façon dont ils utilisent les autres soins de santé. Ces données peuvent aider les chercheurs à comprendre si les services à domicile répondent aux besoins prévus.

HMC_R001

Voici maintenant quelques questions sur les services de soins à domicile que vous ou un membre de votre ménage pourriez avoir reçus en raison d'un problème de santé ou d'une limitation des activités quotidiennes. Ces services comprennent les services reçus à domicile, comme les soins infirmiers, la préparation de repas, l'aide pour se laver ou pour les travaux ménagers, etc. <u>Ne comptez pas l'aide reçue de membres de la famille, d'amis ou de voisins</u>.

HMC_Q005

Au cours des 12 derniers mois, quel type de services de soins à domicile vous ou un membre de votre ménage avez reçu?

<u>INTERVIEWEUR</u> : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées. Ne comptez pas les soins postnataux.

1. **Soins infirmiers (p. ex. changement de pansements, préparation des médicaments, visites I.O.V.)**
2. **Autres services ou soins de santé (p. ex. physiothérapie, ergothérapie ou orthophonie, conseils en nutrition)**
3. **Équipements médicaux ou fournitures médicales (p. ex. fauteuil roulant, serviettes pour incontinence, aide pour l'utilisation d'un ventilateur ou d'un équipement à oxygène)**
4. **Soins personnels ou aide ménagère (p. ex. bain, ménage, préparation des repas)**
5. **Autres services (p. ex. transport, Popote Roulante)**
6. **Aucun membre du ménage n'a reçu de services de soins à domicile**

   NSP, RF

Besoins de santé non comblés (UCN)

Optionnel

Le but de ce module est d'identifier les répondants qui ont eu besoin de services de soins de santé (sauf des services de soins à domicile) au cours des 12 derniers mois pour lesquels ils n'ont pas réussi à obtenir les soins. Le module comprend des questions sur le type de soins qui était jugé nécessaire, les tentatives pour obtenir les soins, le lieu où les répondants se sont adressés et la raison pourquoi le service n'a pas été reçu.

Les données seront utilisées afin d'évaluer l'ampleur et la nature des besoins de soins de santé non rencontrés, de cibler des régions géographiques où des améliorations peuvent être apportées et de déterminer pourquoi les besoins n'ont pas été comblés.

UCN_Q005

Au cours des 12 derniers mois, y a-t-il eu un moment où vous avez cru que vous aviez besoin de soins de santé autres que des services de soins de santé à domicile, mais vous ne les avez pas obtenus?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Population active (LBF)

Commun

Il y a plusieurs liens entre le travail et la santé. Par exemple, être sans emploi peut causer différentes maladies reliées au stress tandis que certaines occupations peuvent provoquer des blessures causées par des mouvements répétitifs.

Ce module inclut des questions sur les activités de travail du répondant au cours de la dernière semaine, y compris la situation d'emploi et l'absentéisme, la catégorie de travailleur (employé ou travailleur autonome), l'industrie, la profession et les activités principales, le nombre d'emplois et le nombre habituel d'heures de travail par semaine.

Les concepts et définitions sont, pour la plupart, les mêmes que ceux utilisés pour l'enquête sur la population active.

Ce module s'applique aux répondants âgés entre 15 et 75 ans. Toutes les questions ne seront pas posées à tous les répondants – veuillez noter les sauts du questionnaire.

LBF_R010

Les questions suivantes portent sur votre emploi actuel ou entreprise.

INTERVIEWEUR : Si le répondant occupe actuellement plus d'un emploi, recueillez des renseignements sur l'emploi pour lequel le nombre d'heures de travail par semaine est le plus élevé.

LBF_Q030	**Aviez-vous plus d'un emploi ou plus d'une entreprise la semaine dernière?** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Activité sur le marché du travail (LMAM)	Ceci est la version des ITAO-IPAO du bloc minimal Activité sur le marché du travail. Elle contient les questions nécessaires pour déterminer si le répondant occupe un emploi ou non.
LMAM_Q01	**La majorité des questions suivantes ont trait à vos activités au travail la semaine dernière.** **La semaine dernière, vous avez travaillé à un emploi ou à une entreprise?** **(peu importe le nombre d'heures)** 1. Oui 2. Non NSP, RF
Catégorie de travailleurs (LMA3)	Ce bloc fait partie du contenu détaillé du bloc à contenu harmonisé des activités sur le marché du travail. Il contient la question nécessaire pour identifier la catégorie de travailleurs pour un répondant qui occupe un emploi.
LMA3_Q10	**Étiez-vous un employé ou un travailleur autonome ?** 1. Employé (e) 2. Travaill(eur) autonome 3. Travaill(eur) non rémunéré(e) dans une entreprise familiale NSP, RF
Industrie (LMA4)	Ce bloc fait partie du contenu détaillé du bloc à contenu harmonisé des activités sur le marché du travail. Il contient la question nécessaire pour identifier l'industrie pour un répondant qui occupe un emploi.
LMA4_Q11	**Quel était le nom de l'entreprise?** INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom complet de l'entreprise. S'il n'y a pas de nom d'entreprise, inscrivez le nom complet du répondant. ---------- (50 espaces)

Profession (LMA5)

Ce bloc fait partie du contenu détaillé du bloc à contenu harmonisé des activités sur le marché du travail. Il contient la question nécessaire pour identifier l'occupation pour un répondant qui occupe un emploi.

LMA5_Q14

Quel était le travail ou l'occupation de?
INTERVIEWEUR : Inscrivez une description détaillée.
Par exemple :

1. secrétaire juridique
2. plombier
3. guide d'expéditions de pêche
4. assembleur de meubles en bois
5. enseignant au secondaire
6. programmeur informatique

(50 espaces)

Nombre habituel d'heures travaillées (LMA6)

Nombre habituel d'heures travaillées (LMA6) est un autre sous module du module LBF sur la population active.

Ce bloc contient des questions requérant l'identification du nombre d'heures habituellement travaillé par un répondant qui est employé.

Perte de productivité (LOP)

optionnel

Dans ce module, on demande aux répondants s'ils se sont absentés du travail au cours des trois derniers mois pour des raisons de santé (problème de santé physique ou mentale chronique, blessure, maladie infectieuse, etc.) ou pour d'autres raisons comme prendre soin de leurs propres enfants, une mise à pied temporaire, le départ à la retraite, ou autre chose.

Les questions suivantes servent à obtenir plus de détails sur les problèmes de santé des répondants qui ont entraîné la perte de productivité.

Cette série de questions est demandée aux répondants de plus de 15 ans qui ont travaillé dans les 12 derniers mois.

Les données seront analysées afin d'estimer le fardeau économique associé aux problèmes de santé des Canadiens.

LOP_Q005

À un moment quelconque au cours des trois derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une entreprise?

INTERVIEWEUR : Inclure seulement un emploi ou entreprise rémunéré.

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Renseignements socio-démographiques (SDC)

Commun

La comparaison de la santé de différents groupes permet de recueillir des renseignements très importants pour comprendre la santé des Canadiens. Par exemple, les nouveaux immigrants au Canada utilisent-ils plus les services de santé que les gens nés au Canada ou moins? Les membres des groupes ethniques européens risquent-ils plus que d'autres groupes de souffrir de certains troubles chroniques?

Dans ce module, on recueille d'importants renseignements sociodémographiques, y compris le statut d'immigrant, le pays et la province de naissance, l'origine ethnique, l'appartenance à la population autochtone, le groupe racial ou culturel, la langue, le type de logement et l'orientation sexuelle.

SDC_R001

Maintenant, quelques questions générales qui nous aideront à comparer la santé des personnes qui vivent au Canada.

SDC_Q010

À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)

INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Habituellement, un ancêtre est plus éloigné qu'un grand-parent. Si « Canadien » est la seule réponse, demandez des précisions. Si le répondant hésite, ne lui proposez pas de répondre Canadien. Si le répondant répond « Esquimau », inscrivez « 20 ».

01 Canadien
02 Français
03 Anglais
04 Allemand
05 Écossais
06 Irlandais
07 Italien
08 Ukrainien
09 Hollandais (Néerlandais)
10 Chinois
11 Juif
12 Polonais
13 Portugais
14 Sud-Asiatique (p. ex. Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais)
15 Norvégien
16 Gallois
17 Suédois
18 Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord)
19 Métis
20 Inuit
21 Autre - Précisez

NSP, RF

SDC_S010

À quels groupes ethniques ou culturels vos ancêtres appartenaient-ils? (Par exemple : français, écossais, chinois, indien de l'Inde)

INTERVIEWEUR : Précisez.

_____

(80 espaces)

NSP, RF

Bloc minimal immigration (IMM)

Voici le bloc ITAO- IPAO pour lieu de naissance, le statut d'immigrant reçu et l'année d'immigration au Canada.

IMM_Q01

Dans quel pays êtes-vous né(e)?

INTERVIEWEUR : Demandez au répondant de préciser le lieu de naissance selon les frontières actuelles.

Commencez à taper le nom du pays de naissance pour activer la fonction de recherche.

Entrez « CAN » pour sélectionner le Canada.

Entrez « Autre - Précisez » pour saisir un nom de pays qui ne fait pas partie de la liste.

1. Recherche
2. Autre - Précisez

NSP, RF

Personne la mieux renseignée au sujet du ménage (PMK)

Commun

L'objectif de ce module est d'identifier quelqu'un dans le ménage, autre que le répondant âgé entre 12 et 17 ans, qui pourrait être mieux renseigné ou mieux préparé à répondre à des questions qui portent sur l'ensemble du ménage sur des sujets tels que le revenu, l'assurance et l'éducation.

Ce module sera généré seulement si le répondant choisi est âgé de 12 à 17 ans, s'il ne vit PAS seul et si aucun autre membre du ménage n'est âgé de plus de 17 ans. Si le répondant n'est pas âgé de moins de 14 ans, on lui demande s'il accepte de partager les renseignements qu'il fournit. L'interview se poursuivra seulement s'il est possible de trouver la personne la mieux renseignée (PMR) et que cette personne accepte de continuer l'interview. S'il n'est pas possible de trouver cette personne, l'intervieweur doit quitter l'application et choisir le code de résultat approprié.

Couverture d'assurance (INS)

Thématique

Dans ce module, on demande aux répondants s'ils ont une assurance qui couvre en tout ou en partie le coût des médicaments sur ordonnance, des soins à domicile ou des soins de longue durée.

Les répondants doivent inclure les régimes d'assurance privés ou gouvernementaux, ainsi que les régimes payés par une association ou par l'employeur.

Les résultats de ce module permettront de déterminer de façon générale quels groupes possèdent différents types d'assurance. Les chercheurs pourront étudier ces données par rapport aux niveaux de santé et à l'usage des services de soins de santé.

INS_R001

Passons maintenant à votre couverture en matière d'assurance santé. Veuillez inclure tout régime d'assurance privé, gouvernemental ou payé par l'employeur.

INS_Q005

Avez-vous une assurance qui couvre en totalité ou en partie les frais de vos médicaments sur ordonnance?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Sécurité alimentaire (FSC)

Contenu optionnel

Cette section comporte des questions qui interrogent les répondants afin de savoir si quelqu'un dans le ménage a fait face aux problèmes associés à la sécurité alimentaire au cours des 12 derniers mois (l'habileté d'acheter suffisamment d'aliments nutritifs). On pose aussi aux répondants des questions précises à propos des actions et des besoins des adultes qui sont responsables des enfants.

Même les ménages qui semblent avoir des revenus élevés peuvent avoir des contraintes budgétaires qui peuvent rendre l'achat d'aliments nutritifs difficile. Ces questions seront posées à tous les répondants, sans égard au revenu.

Nota : Ce module devrait être posé à un membre responsable du ménage. Les personnes âgées de 18 ans et plus sont considérées comme étant adultes. Les adolescents âgés de 16 et 17 ans vivant avec de la parenté sont considérés comme enfant; tous les autres sont considérés comme adultes.

FSC_R010

Les questions qui suivent concernent la situation alimentaire de votre ménage au cours des 12 derniers mois. Je vais vous lire plusieurs énoncés qui pourraient décrire une situation alimentaire pour un ménage. Dites-moi si les énoncés ont souvent, parfois ou jamais été vrais pour vous au cours des 12 derniers

FSC_Q010

Le premier énoncé est : vous avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent. Cet énoncé a-t-il souvent, parfois ou jamais été vrai au cours des 12 derniers mois?

1. Souvent vrai
2. Parfois vrai
3. Jamais vrai

NSP, FR

Renseignements administratifs (ADM)

Commun

Ce module est pour informer les répondants que les renseignements qu'ils ont fournis pourraient être combinés avec d'autres données. On leur demande de nous donner leur numéro provincial ou territorial d'assurance-maladie. On demande également aux répondants de donner leur permission pour partager les données.

L'intervieweur doit ensuite fournir d'autres renseignements. S'il s'agit d'une IPAO, il faut indiquer si l'interview a eu lieu sur place ou par téléphone. Dans le cas de tous les répondants, il faut indiquer dans quelle langue l'interview a eu lieu, si le répondant a fourni les renseignements tout seul et, dans la négative, si cela a eu un effet sur ses réponses.

ADM_Q005 Données fiscales du répondant NON couplables

Si un répondant est signalé comme n'ayant **pas** de données fiscales couplables (identifiées par le fichier de l'échantillon et prédéterminées par le BC), il sera dirigé vers le module INC pour répondre aux questions sur le revenu. À ce moment, il faut lui lire l'énoncé sur le couplage.

Afin d'améliorer l'information que vous avez fournie, Statistique Canada combinera vos réponses avec l'information provenant de vos données fiscales. Statistique Canada pourrait également combiner vos réponses avec les renseignements provenant d'autres enquêtes ou de sources administratives, ce qui pourrait inclure des renseignements sur l'utilisation passée et courante des services de santé, par exemple, les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de médecins.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer, à moins que le répondant ne veuille pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources de données.

ADM_Q005

Données fiscales du répondant couplables

Si le répondant refuse le couplage et qu'il est signalé comme ayant des données fiscales couplables, il sera dirigé vers l'énoncé suivant :

Afin de réduire le nombre de questions posées, Statistique Canada combinera vos réponses avec l'information provenant des données fiscales de tous les membres de votre ménage. Statistique Canada pourrait également combiner vos réponses avec les renseignements provenant d'autres enquêtes ou de sources administratives, ce qui pourrait inclure des renseignements portant sur l'utilisation passée et courante des services de santé, par exemple, les consultations dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets de médecins.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer, à moins que le répondant ne veuille pas que ses réponses soient combinées à d'autres sources de données.

ADM_Q010

En ayant un numéro provincial ou territorial d'assurance maladie, nous pourrons plus facilement jumeler nos données à ces autres renseignements.

Avez-vous un numéro d'assurance-maladie?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

ADM_Q015

De quelle province ou territoire est votre numéro d'assurance-maladie?

Remarque IMPORTANTE sur les numéros de santé

Si le répondant ne peut pas fournir son numéro de carte de santé au moment de l'interview, indiquez « non » et continuez le questionnaire. Ne codez pas le cas comme en cours; le cas devrait être finalisé qu'un numéro de carte santé ait été obtenu ou pas. Si un répondant offre de rappeler pour fournir son numéro de carte santé, prenez ses coordonnées dans la section des notes permanentes. Tout changement de l'information sur le numéro de carte de santé n'est pas considéré comme une note essentielle.

ADM_R025

Afin d'éviter la répétition des enquêtes, Statistique Canada a conclu des ententes avec les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada pour partager les renseignements que vous avez fournis dans le cadre de cette enquête.

Les ministères provinciaux de la santé peuvent transmettre cette information aux autorités locales de la santé, mais aucun renseignement permettant d'identifier les répondants, comme …

INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de la santé publique du Canada. « Les ministères provinciaux de la santé » incluent les ministères territoriaux de la santé.

ADM_R035

Ces organisations ont convenu d'assurer la confidentialité de vos renseignements et de les utiliser uniquement à des fins statistiques.

Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

Nouvel ordre du module :

Revenu (INC) est maintenant un sous-bloc du module ADM

Le revenu est maintenant un sous-bloc du module Renseignements administratifs (ce qui signifie qu'il suivra le module ADM). Tel que susmentionné, l'application de 2016 a été modifiée pour qu'on ne pose plus la question sur le revenu aux répondants dont les enregistrements contiennent des données fiscales couplables (à moins qu'ils ne refusent l'énoncé sur le couplage dans le module ADM). La question INC sera posée aux personnes dont les enregistrements ne peuvent pas être couplés avec les données fiscales. Ce changement a été apporté dans l'application et se fera automatiquement.

Revenu (INC)

Commun

Dans ce module, on demande aux répondants de déclarer le montant de leur revenu personnel et du revenu du ménage, *toutes* les sources de revenu, ainsi que les *principales sources* de leur revenu personnel et du revenu du ménage au cours de la dernière année civile. Les questions sur le revenu personnel sont posées seulement si le ménage compte plus d'un membre et si le répondant est âgé de 16 ans et plus. On demande aussi aux répondants si leur revenu personnel total ou le revenu total du ménage comprend des prestations pour personnes handicapées.

Le revenu est un sujet délicat, mais les renseignements à ce sujet sont très importants pour étudier le rapport entre le revenu et la santé.

Bien que de nombreux coûts liés aux soins de santé sont couverts par l'assurance au Canada, le revenu joue encore un rôle important dans l'état de santé des personnes. Les personnes ayant des revenus moindres sont plus sujets à un état de santé moins bon. Les personnes ayant différents niveaux de revenu ont également tendance à utiliser le système de soins de santé de manière différente.

INC_R001

Même si la plupart des dépenses liées aux services de santé sont couvertes par l'assurance-maladie, il existe un lien important entre la santé et le revenu. Soyez assuré(e) que, comme tous les autres renseignements que vous avez fournis, ces réponses demeureront strictement confidentielles.

INC_Q005

Si l'on pense au revenu total pour tous les membres de votre ménage, quelles en ont été les sources au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2014?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.
Choisissez toutes les réponses appropriées.

01	**Salaires et traitements**	09	**Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti**
02	**Revenu d'un travail autonome**	10	**Allocations municipales ou provinciales d'aide sociale ou de bien-être**
03	**Dividendes et intérêts (p. ex. sur obligations, épargnes)**	11	**Prestations fiscales pour enfants ou allocations familiales**
04	**Prestations d'assurance-emploi**	12	**Pension alimentaire aux enfants**
05	**Indemnités d'accident du travail**	13	**Pension alimentaire au conjoint(e)**
06	**Prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec**	14	**Autre (p. ex. revenu de location, bourse d'études)**
07	**Pensions de retraite d'un employeur et rentes**	15	**Aucune**
08	**REER/FERR (régime enregistré d'épargne-retraite/fonds enregistrés de revenu de retraite)**	NSP, RF	

INC_Q010

Est-ce que ce montant comprend une prestation pour personnes avec incapacité?

1. Oui
2. Non

NSP, RF

INC_Q015

Quelle était la principale source de revenu du ménage?

Revenu total du ménage (THI)

THI_Q01

Maintenant une question sur le revenu total de votre ménage.
Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu total de tous les membres de votre ménage, provenant de toutes les sources, avant impôts et autres déductions, au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2014?
Le revenu peut provenir de diverses sources comme le travail, les investissements, les pensions ou le gouvernement. Les exemples incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et d'autres revenus tels que les pensions alimentaires et le revenu locatif.

INTERVIEWEUR : Les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu du ménage.

THI_Q02

Pouvez-vous estimer dans lequel des groupes suivants se situe le revenu de votre ménage? Le revenu total du ménage au cours de l'année se terminant le 31 décembre 2014 était-il... ?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1. **Inférieur à 50 000 $ incluant les pertes de revenu**
2. **Égal ou supérieur à 50 000 $**

NSP, RF

Aperçu

La section « Sortie » est activée lorsqu'on quitte un cas.

On peut quitter un cas d'une des méthodes suivantes :

- En sélectionnant « Non » à la question contact dans le module « Entrée »
- En quittant le cas à l'écran des composantes ou en tout temps lorsqu'on se sert de la clé <F10>.
- En terminant l'interview.

Introduction

La dernière section de l'application est la partie Sortie dans laquelle on attribue un code de résultat final avant de transmettre le cas.

La composante Sortie comprend :

- la sélection des codes de résultat pour les sorties de cas par la clé F10
- la permission du partage des données
- la collecte de renseignements pour le contact futur possible
- la vérification du nom du répondant et
- le remerciement

SO_N01

INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la composante. Retournez et faites les changements appropriés ou sélectionnez <Sortie >.

1. Sortie

(NSP et RF ne sont pas permis.)

Afficher le code de résultat automatique (DAO)

Le bloc Afficher le code de résultat automatique est utilisé pour afficher le code de résultat attribué automatiquement par l'application.

INTERVIEWEUR : Le cas a été codé entièrement rempli.

Appuyez sur <1> pour continuer, ou retournez et faites les changements appropriés.

Quand la Sortie est effectuée (utilisation de la clé F10)

Lorsque nous devons sortir d'un cas avec la clé F10, les écrans suivants apparaîtront. L'écran OC_N02 sera affiché après avoir sélectionné les codes de résultat « en cours » et l'écran OC_N03 sera affiché après avoir sélectionné les codes de résultat « final ».

Code de résultat (OC)

Le bloc Code de résultat est utilisé pour assigner un code de résultat à un cas. Notez que les enquêtes doivent spécifier les listes de codes de résultat en progrès ou finaux desquelles les intervieweurs devront choisir.

INTERVIEWEUR : Voulez-vous enregistrer un code de résultat en cours ou final?

1. En cours
2. Final

(NSP et RF ne sont pas permis)

Quand un code en cours sera attribué à un cas, le cas sera abandonné.

Veuillez à inscrire toute note et à fixer les rendez-vous auparavant.

Le code « en cours » choisi apparaît à côté du numéro de l'échantillon dans l'écran Sélectionner cas.

Pour la liste séparée de codes de résultat en cours et final par âge et le mode de collecte voir l'annexe C.

La liste distincte des codes de résultat en cours et final par groupe d'âge et mode de collecte est également présentée ci-dessous :

OC_N04
(Cas de refus)

Lorsque le code final 80 (refus) est attribué à un cas, OC_N04 servira à indiquer la raison du refus.

INTERVIEWEUR : Enregistrez la raison du refus.

1. Dangereux / attitude grossière
2. Ne répond pas à la porte
3. N'est pas intéressé (e) / ne veut pas participer
4. Ne veut pas être dérangé (e)
5. N'a pas le temps
6. Contre le gouvernement ou Statistique Canada
7. Ne croit pas aux statistiques ou ne veut pas entendre parler
8. Ne croit pas aux enquêtes ou ne veut pas entendre parler
9. A récemment participé à une enquête (ne veut pas participer à une autre enquête)
10. Ne croit pas que les renseignements sont protégés (confidentialité)
11. Ne veut pas donner de renseignements personnels
12. Dit qu'il/elle n'est pas obligé(e) / veut une preuve légale
13. On peut obtenir des renseignements d'autres sources (P.ex. Revenu Canada)
14. Refus catégorique (aucune raison précise, p.ex. ferme la porte au nez ou raccroche)
15. Ne veut pas continuer l'enquête (plus de suivis)
16. Même ménage, refus persistant (uniquement pour les suivis)
17. Pourquoi moi? Vous dit de choisir quelqu'un d'autre
18. Autre – Précisez

OC_S04	INTERVIEWEUR : Précisez _____
Sortie de cas se servant de la fonction F10	A ce point, l'interview se termine pour ceux se servant de la fonction F10 et qui n'ont pas franchis le seuil d'une interview partielle (voir ci-bas).
Interview partielle	L'interview est partielle lorsque celle-ci a été réalisée jusqu'à la première question du bloc Soins de santé primaires (PHC), mais n'a pas été menée jusqu'à la fin du bloc Administration. Voir la permission de partager module PS pour plus de détails.
Introduction Sortie (EI)	Le bloc Introduction de sortie contient l'introduction à la dernière section de l'interview. **Avant de terminer, j'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires.** INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer. **Nota :** <F5> « Refus» et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
Autorisation de partager (PS)	Ce bloc contient une demande d'autorisation visant à partager les données recueillies durant l'interview avec d'autres organismes et ministères. L'énoncé de l'explication et de la question est propre à chaque enquête. Des écrans multiples peuvent être programmés. Elle sert à présenter la demande de partage des renseignements recueillis durant l'interview avec un ou plusieurs autres ministères. Grâce au partage de données, il n'est pas nécessaire que chaque ministère recueille ses propres renseignements, par conséquent un moins grand nombre d'enquêtes sont nécessaires. Ces questions seront posées dans la composante Sortie seulement si la sortie du cas a été effectuée (à l'aide de la touche F10) après la limite pour l'interview partielle (la première question du module Soins de santé primaires (PHC) et avant la fin du module Administration, où ces questions s'affichent dans le cas d'une interview terminée.

PS_R01	Partage des données – Toutes les provinces (excluant le Québec) et les territoires) : **Statistique Canada aimerait que vous donniez votre permission de partager l'information recueillie lors de l'interview effectuée dans le cadre de cette enquête avec Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et les ministères provinciaux et territoriaux de la santé.**
PS_R01	**Le ministère de la santé de votre province pourrait permettre à votre région socio- sanitaire d'avoir accès à certains de ces renseignements, mais les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance-maladie ne seront pas fournis.** Québec : **Statistique Canada aimerait que vous donniez votre permission de partager l'information recueillie lors de l'interview effectuée dans le cadre de cette enquête avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, l'Institut de la statistique du Québec, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada**. **L'Institut de la statistique du Québec pourra permettre à votre région sociosanitaire d'avoir accès à certains de ces renseignements, mais les noms, adresses, numéros de téléphone et numéros d'assurance-maladie ne seront pas fournis.** INTERVIEWEUR : Les identificateurs personnels (les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros d'assurance-maladie) ne seront pas fournis à Santé Canada ou à l'Agence de santé publique du Canada. « Les ministères provinciaux de la santé » incluent les ministères territoriaux de santé. **Nota** : <F5> « Refus» et <F6> « Ne sait pas » ne sont pas permises pour cette question.
PS_Q02	Tous les renseignements demeureront strictement confidentiels et ne seront utilisés qu'à des fins statistiques. Acceptez-vous que les données que vous avez fournies soient partagées? 1. Oui 2. Non
Notes	À ce point, l'interview procédera dans les cas finalisés, code 70 – Entièrement rempli. Pour les cas, où la Sortie a eu lieu avec la clé F10, l'interview terminera avec l'écran TY_R01.
Pièces d'habitation (LQ)	Ce bloc sert à déterminer s'il existe d'autres logements dans cet immeuble, qui ne figurent peut-être pas sur la liste. La liste de la grappe F02 doit être vérifiée pour s'assurer qu'un multiple n'est pas déjà répertorié.

Pièces d'habitation (LQ) suite	Sélectionnez « Oui » seulement si d'autres logements ne figurent pas sur la liste de la grappe F02. **Nota :** Si « Oui » est sélectionné, il se peut qu'un ou plusieurs nouveaux logements (« multiples ») doivent être ajoutés à la liste de la grappe F02. **IPAO seulement**
Nombre de multiples (MU)	Le module MU est demandé seulement lorsque multiples ne sont pas créés dans l'entrée et la réponse donnée à la question LQ est oui. **Nota :** (NSP, RF ne sont pas permis) **IPAO seulement**
Contact 1 (CON1)	**Au cas où vous déménageriez ou changeriez de numéro de téléphone, il nous serait utile d'avoir le nom, le numéro de téléphone et l'adresse d'un parent ou d'un(e) ami(e) qui pourrait nous aider à vous rejoindre.** **Nota :** Les noms sur la liste des membres du ménage seront affichés à l'écran.
GCN_Q01	**Je veux souligner que Statistique Canada contactera cette personne seulement au cas où nous aurions des difficultés à vous joindre.** INTERVIEWEUR : Inscrivez le prénom. _____ (25 espaces) INTERVIEWEUR : Inscrivez le nom de famille _____ (25 espaces)
Merci 1 (TY1)	**Merci beaucoup pour votre aide.** **Nota :** < F5 > " Refus " et < F6 > " Ne sait pas " sont désactivés pour cette question.
Fin de l'IAO (SO)	La question Fin de l'IAO est un indicateur pour l'intervieweur, qui marque la fin d'une composante. La réponse entrée, la composante se ferme et demeure inaccessible. INTERVIEWEUR : Ceci est la fin de la composante. Retournez aux questions répondues précédemment pour effectuer les corrections nécessaires ou sélectionnez <Sortir > pour quitter la composante. **Nota :** NSP et RF ne sont pas permis.
	Fin de Sortie

4. Annexes

Dans ce chapitre Le présent chapitre comporte les annexes suivantes :

Page

Annexe A – Glossaire A-1
Annexe B – Guide de référence / fiche de consultation rapide B-1
Annexe C – Codes de résultat C-1
Annexe D – Modules par province / territoire D-1
Annexe E – Adresse dans le champ de l'enquête (18+).....E-1
Annexe F – Documents pour le répondant.....F-1
Annexe G – Questions et réponses G-1

Annexe A – Glossaire

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

Page

Aperçu A-1

Introduction A-1

Glossaire des termes A-2

Aperçu

Introduction

Le présent glossaire constitue un outil de référence pour l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC).

Il renferme la définition des expressions et concepts de l'enquête qui sont utilisés dans le Manuel de l'intervieweur et l'application de l'ESCC.

Les définitions de l'enquête visent à assurer une compréhension commune des concepts de l'ESCC. En comprenant et en appliquant ces définitions, vous et tous les intervieweurs du pays procéderez de la même façon à la collecte des données de l'ESCC.

Partie de l'application	Le glossaire des termes fait partie de l'application. Vous pouvez avoir accès à la touche d'aide en cliquant sur l'onglet HLP, sous la barre de titre, ou en utilisant la touche F7. Tapez la première lettre du mot que vous voulez chercher dans le glossaire. Appuyez sur < Entrée >. Appuyez à nouveau sur < Entrée > pour poursuivre votre interview ou utilisez la flèche vers le haut pour revenir à l'écran des instructions à l'INTERVIEWEUR : « Les sujets de l'aide sont regroupés et triés en ordre alphabétique ». Vous pouvez taper une seule autre lettre dans cet écran.
222s	Produit analgésique contenant de la codéine habituellement disponible sans ordonnance.
292s	Produit analgésique contenant de la codéine seulement disponible avec ordonnance.
Accident vasculaire cérébral (AVC)	Survient lorsqu'il y a interruption du flux de sang vers une partie du cerveau. L'interruption peut être due à un caillot qui obstrue une artère menant au cerveau (accident ischémique) ou à l'éclatement d'un vaisseau causant un saignement dans le cerveau (accident hémorragique).
Acide	Drogue hallucinogène; nom commun pour faire référence au LSD.
Acide folique	Vitamine du groupe B, utilisée avant et durant la grossesse pour prévenir certaines anomalies congénitales.
Acupuncture	Méthode qui consiste à traiter diverses affections en introduisant des aiguilles dans la peau ou dans les tissus.
Acupuncteur	Personne spécialisée dans la pratique de l'acupuncture (méthode qui consiste à traiter diverses affections en introduisant des aiguilles dans la peau ou dans les tissus).
Adderall	Produit stimulant prescrit par un médecin pour le traitement des problèmes d'attention ou de concentration, tel que le TDAH.
Allergie	Réaction immunitaire nuisible de l'organisme à une substance (p. ex. aliment particulier, poussière, pollen) à laquelle il est devenu hypersensible.

Allergie nasale	(Aussi rhinite allergique ou rhume des foins) Réaction corporelle à certaines substances extérieures, tels que les pollens d'arbres de printemps, d'herbes d'été, et des mauvaises herbes d'automnes, qui apparaissent régulièrement à la même période de l'année.
Allergologue	Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement des allergies.
Alprazolam	Produit sédatif obtenu auprès d'un médecin, souvent utilisé pour le traitement du trouble anxieux et du trouble panique, et pour le soulagement court-terme des symptômes d'anxiété.
Amphétamine	Drogue qui a un effet stimulant sur le système nerveux central et périphérique. Les amphétamines se présentent sous forme de poudre blanche, de capsule, de comprimé ou de liquide clair. (Autres noms Speed, Crystal, Crank, Meth, Go, Jet fuel, Rocket fuel, Junk.)
Analgésiques opioïdes	Produits renfermant des opioïdes, tels que la codéine ou la morphine, qui suppriment ou atténuent la sensibilité à la douleur.
Angel dust	Drogue hallucinogène; nom commun pour faire référence au PCP.
Angiographie	Examen diagnostic dans lequel un cathéter est utilisé pour injecter un colorant dans les vaisseaux sanguins. Un cliché radiographique est pris pour produire une image des vaisseaux sanguins. Elle est utilisée pour faciliter le diagnostic d'affections comme l'accident vasculaire cérébral et la crise cardiaque.
Anomalie congénitale	Toute malformation/imperfection structurelle ou corporelle présente à la naissance, telle qu'une anomalie cardiovasculaire ou l'hypothyroïdie.
Antibiotique	Médicament qui empêche la croissance des bactéries ou les détruit
Arthrite	Affection caractérisée par l'inflammation d'une ou de plusieurs articulations causant habituellement de la douleur, une rougeur et de la raideur.
Arthrite rhumatoïde	Une maladie chronique caractérisée par la raideur et l'inflammation de plusieurs articulations, causant une perte de mobilité, de la faiblesse et des difformités.

Arthrose	Maladie articulaire dégénérative courante, souvent décrite comme étant une arthrite d'« usure ». Les symptômes incluent de la douleur et la raideur de l'articulation, habituellement le genou ou la hanche.
Asthme	Maladie respiratoire chronique caractérisée par une respiration laborieuse et un sifflement résultant de l'obstruction et de la constriction des voies aériennes.
Ativan	Nom de marque déposée pour des préparations de lorazépam, un produit sédatif obtenu d'un médecin, souvent utilisé pour le traitement de trouble anxieux, le soulagement à court-terme des symptômes d'anxiété et comme un agent sédatif hypnotique.
Audiologiste **(Audio thérapeute)**	Thérapeute spécialisé dans le traitement des personnes qui ont des problèmes d'ouïe.
Bronchite chronique	Affection clinique caractérisée par une sécrétion excessive de mucus dans l'arbre bronchique et se manifestant par une toux chronique productive. Il s'agit d'une forme de longue durée de la bronchite, souvent caractérisée par une tendance plus ou moins prononcée à la récidive après une période d'accalmie.
Cancer	Maladie caractérisée par la prolifération anormale et incontrôlée de cellules qui peuvent envahir et détruire les tissus et les organes voisins ou se propager à d'autres parties de l'organisme.
Cancer colorectal	Une tumeur maligne qui se développe dans le côlon et/ou le rectum.
Cannabis	Drogue constituée de feuilles de chanvre séchées, fumées ou mastiquées pour leur effet euphorique (voir marijuana). Considéré par certains comme une drogue douce. Peut être utilisé à des fins médicinales, particulièrement pour contrôler la douleur.
Cardiologue	Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement des maladies du cœur.
Cartes de rabais sur les médicaments	Mesure utilisée par les fabricants de médicaments de marque déposée pour aider les patients à entreprendre une thérapie ou à acheter des médicaments de marque déposée, au coût des médicaments génériques. Ces cartes sont distribuées par les médecins ou dans les pharmacies.

Cataracte	Un trouble de la vision causé par la perte de transparence de la lentille de l'œil (le cristallin), causant une vision embrouillée et parfois, avec le vieillissement, la perte de la vue (cécité).
Celebrex	Produit analgésique contenant de la codéine seulement disponible avec ordonnance, souvent utilisé pour le traitement de l'arthrite.
Centre de santé communautaire	Organisme communautaire qui fournit une gamme de services médicaux et des programmes de promotion de la santé à la population, souvent doté d'une équipe interdisciplinaire de professionnels dans divers domaines (médecine, nutrition, santé mentale, counselling, travail communautaire, etc.).
CLSC (Centre local de services communautaires)	Au Québec, des organismes offrant des soins de base médicaux et sociaux, ainsi que des services de réhabilitation ou réintégration aux individus qui résident dans la zone géographique spécifiée.
Champignons magiques	Champignons possédant des propriétés hallucinogènes; aussi connus sous le nom de « magic mushroom » ou champis.
Champix	Nom de marque déposée pour la Varénicline, un médicament pour aider à réduire la consommation de cigarettes ou arrêter de fumer.
Chiropraticien	Praticien de la chiropraxie, science fondée sur la théorie selon laquelle la santé et la maladie sont reliées au fonctionnement du système nerveux. Les chiropraticiens se spécialisent dans le diagnostic et le traitement des irritants du système nerveux.
Chirurgie non urgente	Intervention chirurgicale planifiée, pratiquée à l'hôpital ou au service de consultations externes. N'inclut pas les interventions chirurgicales subies lors d'une admission au service d'urgence d'un hôpital à la suite, par exemple, d'un accident ou d'une situation mettant la vie en danger.
Cigarette électronique	Un vaporiseur à batterie qui simule le fumage de tabac en produisant un aérosol qui ressemble à la fumée. Une cigarette électronique relâche de la vapeur qui pourrait ou non contenir de la nicotine.

Clinique externe d'un hôpital	Clinique qui, dans certains hôpitaux, offre d'autres services que l'admission à l'hôpital ou le traitement au service d'urgence. Par exemple, une personne pourrait se rendre tous les deux jours au service de consultations externes pour faire changer un bandage. Les cliniques de soins ambulatoires, de radiographie et d'orthopédie, ainsi que les hôpitaux gériatriques de jour en sont d'autres exemples.
Clinique privée	Clinique, majoritairement pour des soins externes, offrant des services spécialisés. Typiquement, les cliniques privées offrent des services avec des temps d'attente réduits comparativement au système public.
Clinique sans rendez-vous	Clinique offrant le traitement d'épisodes isolés de maladie. Aucun rendez-vous n'est nécessaire. Elles sont souvent utilisées comme remplacement du service d'urgence d'un hôpital et offrent habituellement des heures d'ouverture plus longues que les cabinets de médecins.
Clonazépam	Produit sédatif obtenu d'un médecin, souvent utilisé comme anticonvulsivant et pour favoriser la relaxation musculaire dans le traitement de crises épileptiques.
Cocaïne (épurée / Free-base)	Drogue puissante qui stimule le système nerveux. La cocaïne est transformée en une poudre blanche que les utilisateurs inhalent ou font fondre pour la prendre par injection.
Codéine	Un analgésique opioïde qui supprime ou atténue la sensibilité à la douleur.
Colite	Inflammation du côlon.
Colonoscopie (Sigmoïdo-scopie)	Méthode diagnostique consistant à insérer un tube souple muni d'une lampe (endoscope) dans le rectum afin de voir la totalité du côlon. Du tissu ou des cellules peuvent aussi être prélevés pour un examen microscopique.
Commotion	Choc ou ébranlement brutal du cerveau provoquant une perturbation de la fonction cérébrale.
Concerta	Produit stimulant prescrit par un médecin pour le traitement des problèmes d'attention ou de concentration, tel que le TDAH.
Condom	Réservoir cylindrique souple et mince en latex, placé sur le pénis, ou dans le vagin, avant les rapports sexuels pour une raison contraceptive ou hygiénique.

Contraceptif oral d'urgence	Communément appelée pilule du lendemain, méthode de contraception utilisée par les femmes comme second recours pour prévenir une grossesse. Son utilisation est recommandée après une relation sexuelle à risque.
Crack	Obtenu par transformation de la cocaïne en une substance qui peut être fumée. (Noms de rue courants Coke, neige, blanche, sucre, nose candy, rock, crack, base.)
Cristal	Un dérivé en forme solide de la méthamphétamine qui agit comme stimulant sur le système nerveux central et périphérique.
Démence	Détérioration mentale due à des facteurs organiques ou psychologiques, caractérisée par une altération de la pensée abstraite, du jugement, du contrôle des pulsions et (ou) d'un changement de personnalité.
Demerol	Produit opioïde, marque déposée pour des préparations de mépéridine.
Depo-Provera™	Contraceptif par injection de longue durée d'action (3 mois) lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser d'autres méthodes de contraception.
Dépression	État mental correspondant à une humeur déprimée caractérisée par des sentiments de tristesse, de désespoir et de découragement. Elle affecte la façon dont une personne mange ou dort, la façon dont elle se perçoit et la façon dont elle perçoit les choses. Une humeur caractérisée par un état d'abattement, une hypoactivité psychomotrice, un sentiment de désespoir et de la culpabilité.
DEXA	Un test de densité osseuse qui utilise un appareil à rayons X spécial pour diagnostiquer l'ostéoporose.
Dexedrine	Produit stimulant prescrit par un médecin pour le traitement des problèmes d'attention ou de concentration, tel que le TDAH.

Diabète	Affection chronique caractérisée par une altération du métabolisme des glucides, des protéines et des graisses qui peut ou non faire intervenir l'insuline. Les symptômes incluent un taux élevé de sucre dans l'urine et dans le sang, une miction (émission d'urines) excessive, une sensation de soif, une sensation de faim, de la faiblesse, une perte de poids et des démangeaisons.
Diazépam	Produit sédatif obtenu d'un médecin, souvent utilisé pour le traitement de troubles anxieux, pour le soulagement à court-terme des symptômes d'anxiété, comme anticonvulsivant, agent anti-panique et pour favoriser la relaxation musculaire.
Dilaudid	Produit analgésique opioïde, marque déposée pour des préparations d'hydromorphone.
Dispositif intra-utérin (DIU, stérilet)	Contraceptif à long-terme (jusqu'à 5 à 10 ans) en forme de T inséré dans l'utérus par le vagin pour prévenir la fécondation et secondairement la nidation.
Drogues illicites	Drogues illégales, n'ayant pas de fonction médicale, telles l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy, les amphétamines et le cannabis (marijuana). *Marijuana - Pour notre enquête, l'usage de la marijuana pour des raisons médicales (même avec ordonnance) sera considéré comme consommation de drogues illicites.
Drogues illicites (usage)	Peut inclure l'usage de drogues licites (légales) pour des raisons autres que pour les bénéfices médicaux (p.ex. abus, surconsommation), ou l'usage de drogues licites n'ayant pas été prescrites par un médecin.
Dysthymie	Humeur déprimée éprouvée pendant la plupart de la journée, presque chaque jour, et durant au moins deux années. Les symptômes sont semblables à ceux de la dépression, mais sont plus faibles et plus chroniques (énergie réduite, insomnie, retrait social, pessimisme, etc.).
Ecstasy (MDMA)	Drogue synthétique psychotrope (capable de modifier l'activité mentale) ayant des propriétés hallucinogènes et comparables à celles des amphétamines (autres noms Adam, Air ball, Blue Jay, Californian Sunset, Clarity, Diamonds, Dove, E, Earth ball, Empathy, Euphoria, Fantasy, Hug-Drug, Love Doves, Love Drug, M&M, MDM, MDMA, Mitsubishi's, Paradise, Playboys, Venus, Wonder Drug, X, XTC, Yuppie Drug, Zen.)

Emphysème	Hypertrophie ou distension anormale des sacs alvéolaires des poumons, causant des difficultés respiratoires. Habituellement chronique et progressive, l'affection est associée à des traits héréditaires, l'usage du tabac et les maladies respiratoires de longue durée, comme la bronchite chronique.
Encéphalo-myélite myalgique	Syndrome de fatigue chronique qui se caractérise par une fatigue persistante et inexpliquée qui dure malgré les efforts de la personne atteinte.
Endocrinologue	Spécialiste de l'endocrinologie, qui étudie les glandes à sécrétion interne (et les hormones), leur fonctionnement et leurs maladies.
Entorse	Blessure d'une articulation dans laquelle les fibres d'un ligament de soutien sont déchirées, sans rupture complète du ligament.
Épilepsie	Un trouble cérébral qui fait que le cerveau transmet des signes anormaux qui provoquent des crises.
Ergothérapeute	Thérapeute spécialisé dans le traitement fondé sur des activités créatives (p. ex. tâches ménagères, passe-temps, liées à la profession) conçues pour promouvoir le rétablissement et l'autonomie (p. ex. traitement d'une personne handicapée à la suite d'un accident afin de lui permettre de retourner vivre chez elle et (ou) de reprendre son travail). Le répondant devrait compter les consultations téléphoniques ainsi que les discussions en personne.
État aigu	Problème de santé mental ou physique, diagnostiqué ou non, qui dure moins de 6 mois.
Examen de tomodensito-métrie (CT-SCAN)	Un examen qui utilise des rayons X et qui consiste à réaliser des images en coupes fines du corps afin de rechercher des anomalies qui ne sont pas visibles sur des radiographies standards et à l'écographie. Aussi appelé scanner.
Examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM)	Un examen qui utilise un gros aimant et étudie la réaction des différents tissus du corps à ces champs magnétiques, afin d'analyser à distance des organes et visualiser des détails invisibles sur les radiographies standards, l'écographie ou le scanner.

Fibromyalgie	Affection caractérisée par des douleurs musculaires chroniques, habituellement dans le dos et la nuque, souvent accompagnée de raideurs, particulièrement le matin.
Fournisseur de soins de santé primaires	Les professionnels de la santé qui servent de premier point d'entrée dans le système de santé canadien et qui fournissent des services tels que des diagnostiques, des traitements et la gestion des problèmes de santé.
Frais directs	Argent déboursé par les personnes elles-mêmes. Une autre façon de dire ceci est « payé de votre propre poche ». Exclut ce qui est remboursé par un régime d'assurance.
Glaucome	Maladie de l'œil caractérisée par une perte de la vue due à une augmentation de la pression du liquide à l'intérieur de l'œil. Cette augmentation de la pression, qui est provoquée par une accumulation d'humeur aqueuse, cause une lésion progressive du nerf optique qui transmet les signaux visuels au cerveau. Au cours du temps, le glaucome peut entraîner une perte progressive de la vision périphérique.
Goutte	Un type d'arthrite caractérisé par l'apparition de crises graves soudaines de douleurs articulaires, qui s'accompagnent de rougeurs, d'un réchauffement et d'un gonflement de la région touchée, et qui s'explique par l'accumulation de cristaux d'acide urique dans l'articulation touchée, souvent dans le gros orteil.
Gynécologue	Médecin qui se spécialise dans le traitement des maladies des organes reproducteurs de la femme.
Haschisch / Haschich / Hachisch / Hachich	Substance résineuse purifiée extraite du chanvre; utilisé comme hallucinogène. Autres noms utilisés cannabis, hasch, pot et marijuana
Hallucinogènes	Drogues qui affectent les sensations, la pensée, la conscience de soi et les émotions. Incluent le LSD (acide, microdot), la mescaline et la paillote (mexc, boutons, cactus), les substances voisines des amphétamines (PMA, STP, DOB), la phencyclidine (PCP, angel dust, hog), les analogues de la phencyclidine (PCE, PCPy, TCP) et d'autres (psilocybine, psilocyne).
Hémoglobine « A1C »	Test d'hémoglobine qui consiste à mesurer la concentration moyenne de sucre dans le sang sur une période de trois mois, utilisé pour diagnostiqué le diabète et surveiller comment bien il se contrôle.

Hépatite B/ C	Maladie caractérisée par l'inflammation du foie, d'origine toxique ou virale. L'hépatite B est virale et transmissible par voie parentérale; l'hépatite C est transmissible par voie parentérale et provoquée par un virus différent des deux virus connus de l'hépatite (non-A, non-B).
Héroïne	Opiacé dérivé de la morphine. L'héroïne se présente sous forme d'une poudre blanche ou brune. Il s'agit d'un analgésique opiacé H, smack, cheval, héro, schnouff, poudre blanche, came.)qui est extrait du pavot. L'héroïne peut être fumée mélangée à du tabac, chauffée dans un récipient en aluminium et inhalée, injectée par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse. (Noms de rue
Hydromorph contin (Hydromor-phone)	Produit analgésique opioïde, dérivé de la morphine, mis en marché sous les marques déposées de Dilaudid, Palladone et plusieurs autres.
Hygiéniste dentaire	Personne spécialisée dans les services de prévention des maladies des dents. Travaille sous la supervision d'un dentiste. Ses fonctions incluent le nettoyage et le polissage des dents, la prise des radiographies et l'enseignement de l'hygiène buccodentaire.
Hypertension	Pression artérielle supérieure à la normale de façon persistante.
Hystérectomie	Ablation de l'utérus, avec ou sans ablation des ovaires. L'ablation des ovaires uniquement n'est pas considérée comme une hystérectomie.
H1N1	Grippe ou maladie respiratoire aiguë et contagieuse de l'être humain apparue en 2009, causée par le virus de l'influenza H1N1 de type A.
Imagerie par résonance magnétique (IRM)	Technique diagnostique consistant à utiliser un champ magnétique pour produire l'image d'un organe interne sur un ordinateur. Dans de nombreux cas, elle fournit des renseignements que l'on ne peut obtenir au moyen d'un examen radiographique.
Incapacité	Une capacité mentale ou physique réduite, soit congénitale ou causée par une blessure ou maladie.

Incontinence des intestins	(Incontinence fécale) Une perte de contrôle des intestins, causant le passage involontaire de matières fécales.
Incontinence urinaire	Incapacité de contrôler la fonction urinaire causant une perte involontaire d'urine.
Infections transmissibles sexuellement (ITS) / Maladies transmissibles sexuellement (MTS)	Maladie acquise à la suite de rapports sexuels avec une personne infectée (p. ex. maladies vénériennes, Chlamydia, VIH, Sida, gonorrhée, syphilis).
Infirmière praticienne	Infirmière qui offre des services de santé de base qui complètent les soins dispensés par les médecins, tels la promotion de la santé, prévention et traitement des maladies et des blessures, etc. L'infirmière praticienne (contrairement à l'infirmière) peut établir un diagnostic pour certaines maladies, prescrire des tests, des traitements et certains médicaments.
Influenza	Maladie infectieuse, à virus, contagieuse et souvent épidémique, caractérisée par un abattement général et des symptômes variés (fièvre, courbature, atteintes des voies respiratoires parfois compliquées d'infections bactériennes.
Inhalateur	Dispositif servant à vaporiser un médicament directement dans les poumons de l'utilisateur.
I.O.V.	Les infirmières de l'Ordre de Victoria du Canada, fournissant des services de soins à domicile, de soutien à la personne et d'aide en milieu communautaire pour améliorer la qualité de vie et prodiguer à chacun l'assistance et le soutien nécessaires pour bien vivre au sein de son foyer.
Lorazépam	Produit sédatif obtenu d'un médecin, souvent utilisé pour le traitement des troubles anxieux, pour le soulagement à court-terme des symptômes d'anxiété et comme un agent sédatif hypnotique.

LSD (diéthylamide de l'acide lysergique)	Drogue hallucinogène et l'une des substances chimiques psychotrope les plus puissantes. Le LSD peut se présenter sous la forme de comprimés colorés, de petits morceaux de papier buvard, de liquide clair, de capsules, de comprimés ou de minces carrés de gélatine. Le LSD s'ingère par voie buccale, généralement imbibé sur un petit morceau de papier. Il peut aussi être introduit dans les yeux (noms de rue acide, beast, blue cheer, blue heaven, dot, Lucy in the sky with diamonds, cid (ou sid).)courants
Maladie cardiovasculaire (cardiaque)	Maladie touchant à la fois le cœur et les vaisseaux, tel qu'un infarctus, de l'angine et l'hypertension.
Maladie de céliaque (cœliaque)	Maladie auto-immune permanente caractérisée par une destruction de la paroi de l'intestin grêle due à une intolérance au gluten, qui se retrouve dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle.
Maladie de Crohn	Maladie caractérisée par une inflammation chronique de toute partie du tractus gastro-intestinal, mais affectant fréquemment l'iléon (partie de l'intestin grêle) et provoquant une scarification et un épaississement de la paroi intestinale. Il s'agit d'une forme de maladie inflammatoire de l'intestin.
Maladie de Parkinson	Une maladie caractérisée par une dégénérescence des neurones dans la partie du cerveau qui contrôle les mouvements musculaires.
Maladie d'Alzheimer	La forme la plus fréquente de démence chez les personnes âgées et cause la perte de mémoire et la détérioration d'autres habiletés mentales
Maladie (infectieuse) aiguë / problème de santé aigu	Maladie contagieuse à court-terme comme le rhume, la grippe, une autre infection respiratoire, ou la gastro-entérite.
Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique (MPOC)	Elle est caractérisée par une inflammation des voies aériennes principales dans le poumon caractérisée par une sécrétion de mucus et une toux chronique. Il s'agit d'un problème de santé de longue durée. (Autrefois appelé Broncho-pneumopathie chronique obstructive BPCO)

Mammographie (Mammo-gramme)	Examen radiographique du sein afin de déceler les tumeurs avant qu'elles ne puissent être décelées à la palpation.
Manie	Trouble de l'humeur associé à une humeur anormalement ou constamment exaltée ou irritable accompagnée de troubles du sommeil, de problèmes d'énergie, de difficultés de concentration et d'autres difficultés émotives ou de comportement
Maniaco-dépression	Aussi connu comme le trouble bipolaire, un trouble d'humeur caractérisé par des périodes d'humeur extrêmement élevée (manie) et des période d'humeur extrêmement basse (dépression), qui surviennent de façon totalement inattendue.
Marijuana	Drogue constituée de feuilles de chanvre séchées, fumées ou mastiquées pour leur effet euphorique (voir cannabis). Elle est considérée par certains comme une drogue douce. La marijuana peut être utilisée à des fins médicinales, particulièrement pour contrôler la douleur.
Mastectomie	Excision ou amputation partielle ou totale du sein.
Maux de dos	Lésion des vertèbres, des disques intervertébraux, des ligaments, des muscles, de la moelle épinière ou des nerfs qui causent des douleurs dans le dos.
Médecin de famille	Médecin qui ne limite pas sa pratique à une spécialité. Un médecin de famille peut posséder une spécialisation en médecine familiale.
Médecin généraliste (omnipraticien)	Aussi connu comme omnipraticien, un médecin qui pratique la médecine générale (qui n'est pas spécialisé).
Mescaline	Drogue hallucinogène, extrait du cactus peyotl.
Métham-phétamines	Une dérivée de l'amphétamine, qui crée une forte dépendance, avec action plus rapide et prolongée, ayant un effet euphorique et stimulant sur le système nerveux central et périphérique.

Microalbumine	Un test de microalbumine examine l'urine pour détecter la présence de la protéine albumine. La présence d'albumine peut indiquer des problèmes rénaux résultant du diabète.
MirenaMD	Un dispositif intra-utérin qui diffuse des hormones servant à la contraception.
Morphine	Un analgésique opioïde qui supprime ou atténue la sensibilité à la douleur.
MS Contin	Aussi connu comme Morphine à libération prolongée, un nom de marque déposée pour des préparations de morphine (analgésique opioïde) qui supprime ou atténue la sensibilité à la douleur.
Naturopathe	Personne qui pratique la naturopathie (méthode thérapeutique qui s'appuie sur le régime alimentaire, les plantes médicinales et d'autres méthodes et substances naturelles pour guérir la maladie et dont les objectifs consistent à établir un bon état de santé sans l'utilisation de médicaments, grâce à la stimulation des défenses naturelles).
Neige	Nom commun pour faire référence à la cocaïne.
Nutritionniste / Diététicien	Spécialiste des problèmes de nutrition offrant des conseils au sujet de la nourriture et la nutrition.
Nuva-ringMD	(Anneau vaginal) Un contraceptif pour femmes en forme d'anneau, mis en place dans le vagin pour une période de 3 semaines, qui diffuse des hormones pour l'inhibition de l'ovulation.
Oncologue	Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement du cancer.
Ophtalmologiste	Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement des maladies des yeux et dans la correction des problèmes visuels.
Opium	Une drogue contenant de la morphine qui crée une dépendance, obtenue à partir des graines de pavot et utilisée en médecine comme un analgésique et narcotique.

Opticien	Personne qualifiée pour préparer, ajuster et vendre des verres de lunettes et des verres de contact qui ont été prescrits par un optométriste ou par un ophtalmologiste.
Optométriste	Professionnel de la santé qui se spécialise dans des activités, comme l'examen des yeux, la mesure de la vision et le traitement de certains défauts au moyen de verres correcteurs ou d'autres méthodes, qui n'exigent pas l'obtention d'une licence pour exercer la médecine.
Orthodontiste	Un professionnel dentaire spécialisé en prévention et correction des mauvaises positions des mâchoires et des dents.
Orthopédiste	Médecin qui se spécialise dans le diagnostic et le traitement des maladies des os et des articulations.
Orthophoniste	Thérapeute spécialisé dans le traitement des enfants ou des adultes qui ont des difficultés d'apprentissage du langage ou qui ont perdu le pouvoir de la parole.
Ortho-EvraMD	Un timbre contraceptif (patch) utilisé par les femmes pour prévenir les grossesses par l'inhibition de l'ovulation.
Ostéoporose (os cassants)	Affection caractérisée par une perte des minéraux contenus dans les os qui les rend progressivement plus poreux et plus fragiles. Elle peut être généralisée ou localisée, devient plus fréquente à mesure que l'âge augmente et peut être causée, en partie, par l'inactivité (non usage), un traumatisme ou un trouble neurologique ou autre.
Oxycodone / Oxycontin	Un analgésique synthétique avec des effets similaires à la morphine.
Oxy-neo	Une nouvelle formulation d'Oxycontin crée pour décourager l'abus de la drogue.
Paralysie cérébrale	Causée par une lésion cérébrale survenue avant la naissance ou chez les jeunes enfants qui entraîne une désorganisation du mouvement, du contrôle des muscles ou de la posture.

PCP (Phéncyclidine)	Drogue hallucinogène, aussi connue sous le nom « angel dust ».
Pédiatre	Médecin qui se spécialise dans le soin des enfants et le traitement de leurs maladies.
Percocet	Nom de marque déposée pour des préparations de l'oxycodone, un produit analgésique opioïde, avec de l'acétaminophène (Tylénol).
Percodan	Nom de marque déposée pour de préparations de l'oxycodone, un produit analgésique opioïde, avec de l'aspirine.
Phobie	Toute crainte persistante et déraisonnée d'une activité, d'une situation ou d'un objet particulier qui aboutit à un désir incontrôlable d'éviter le stimulus suscitant la crainte ou la phobie.
Physio-thérapeute	Thérapeute qui se spécialise dans le traitement et la prévention des maladies, de la douleur, des blessures, etc., par des méthodes physiques (comme le massage, la gymnastique médicale, la manipulation, la thermothérapie, etc.) plutôt que le recours à un traitement médicamenteux ou à la chirurgie.
Pilule anticoncep-tionnelle	Un contraceptif oral contenant de la progestérone et souvent de l'estrogène, utilisé pour l'inhibition de l'ovulation et pour prévenir la grossesse.
Pinch (snuff)	Tabac non-fumé placé dans la bouche entre la joue et la mâchoire.
Pipe à eau	Appareil pour fumer du tabac avec de la vapeur d'eau, aussi connu sous les noms houka, chicha, narguilé ou gouza.
Pneumonie	Maladie infectieuse caractérisée par l'inflammation aiguë de l'un ou des deux poumons.
Poudre	Nom commun pour faire référence à la cocaïne.

Pression artérielle	Pression exercée par le sang sur les parois des artères, qui dépend de l'énergie de l'action du cœur, de l'élasticité de la paroi des artères et du volume et de la viscosité du sang.
Problème de santé chronique (de longue durée)	S'entend d'un état qui persiste ou qui devrait persister six mois ou plus. Les six mois sont mesurés à partir du moment où le problème de santé a commencé.
Professionnel de la santé dentaire	Professionnel qui fournit des soins dentaires comme un dentiste, un hygiéniste dentaire, un orthodontiste, un denturologue, un périodontiste et un thérapeute dentaire.
Professionnel de la santé mentale	Professionnel qui fournit des soins en santé mentale, comme un psychologue, un psychiatre et un travailleur social.
Prothèses dentaires	Un remplacement pour une ou plusieurs des dents ou autre structure orale, allant d'une dent unique à un dentier complet (inclut les couronnes, les bridges, les dentiers, etc.)
Psoriasis	Maladie de la peau caractérisée par des taches rouges recouvertes de squames abondantes, localisées surtout aux coudes et aux genoux.
Psychiatre	Médecin qui se spécialise dans l'étude, le diagnostic, le traitement et la prévention de la maladie mentale.
Psychologue	Spécialiste de l'étude du psychisme de l'homme et de ses fonctions, particulièrement celles influant sur le comportement.
Rayons X (Radiographie)	Rayonnement de courte longueur d'onde émis par une source électrique de haute énergie. Les rayons X permettent de produire des images des organes sur film à des fins diagnostiques.
Ritalin	Produit stimulant prescrit par un médecin pour le traitement des problèmes d'attention ou de concentration, tel que le TDAH.

Rivotril	Nom de marque déposée pour des préparations de clonazépam, un produit sédatif obtenu d'un médecin, souvent utilisé comme anticonvulsivant et pour favoriser la relaxation musculaire dans le traitement de crises épileptiques.
RSOS (recherche de sang occulte dans les selles)	Examen en vue de rechercher la présence de sang dans les selles.
Salvia	Aussi connue comme « Sauge des devins », une herbe vivace dans la famille de la menthe qui peut être fumée, mâchée ou brassée pour ses propriétés hallucinogènes.
Schizophrénie	Trouble mental majeur de cause inconnue, habituellement caractérisé par une dissociation des processus de réflexion et des émotions, une distorsion de la réalité accompagnée de délire et d'hallucinations, une fragmentation de la personnalité, des perturbations motrices, un comportement bizarre, etc., souvent sans aucune perte des fonctions intellectuelles fondamentales.
Sclérose en plaques	Également appelée SP, une maladie qui endommage la gaine protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière.
Scoliose	Affection dans laquelle il y a déviation de la colonne vertébrale dans le sens transversal.
Sédatif	Une drogue qui sert à calmer, modérer l'activité fonctionnelle exagérée d'un organe, ou induire le sommeil.
Sensibilité aux agresseurs chimiques (SAC) (Polytoxico-sensibilité)	Trouble acquis se caractérisant par des symptômes intermittents qui se présentent en réaction à l'exposition à de nombreux composés chimiques non liés entre eux à des doses sensiblement inférieures à celles qui causent des effets néfastes sur la santé de la population en général
Service de counselling (thérapie) à domicile	Services de counselling prenant place au domicile du client au lieu du bureau de thérapeute. Fournis aux gens avec accès difficile au counselling pour des raisons comme une maladie, une incapacité ou infirmité ou un manque de transport.

Soins à domicile	Services fournis par une infirmière, un médecin ou autre professionnel de la santé au domicile du client en raison de problème de santé. Ce type de service peut inclure des soins de blessures, des soins palliatifs, de l'éducation sur la santé, etc.
Soins de santé communautaires	Inclut les soins de services de santé reçus hors d'un hôpital ou d'un bureau de médecin, tels que les soins infirmiers à domicile, les services de thérapie ou de counselling à domicile, les soins personnels et les centres de santé communautaires.
Soins infirmiers	Prestation de services essentiels au maintien ou au rétablissement de la santé et du bien-être, ou qui aident à les promouvoir (c.-à-d., vérification de la pression artérielle, administration de médicaments, cathetérisation, irrigation).
Solvants	Substances volatiles pouvant être inhalées (reniflées) pour s'intoxiquer, par exemple, de la colle, de l'essence, etc.
Spécialiste	Médecin agréé pour exercer une spécialité (p. ex. cardiologie, oncologie, radiologie, psychiatrie, orthopédie, gynécologie, etc.). Ce groupe n'inclut ni les optométristes ni les omnipraticiens.
Spécialiste de la vue	Professionnel qui se spécialise dans les soins de l'œil (c'est à dire un ophtalmologue ou un optométriste, mais non un opticien).
Speed	Nom commun pour faire référence aux amphétamines (aussi méthamphétamine, cristal).
Spina-bifida	Une malformation de naissance dans laquelle la colonne vertébrale ne se développe pas complètement et la moelle épinière n'est pas entièrement protégée, ce qui entraîne habituellement des lésions aux nerfs et une paralysie partielle des jambes.
Spirométrie	Un test de contrôle de la fonction pulmonaire ayant pour but de diagnostiquer certaines pathologies pulmonaires telles que l'asthme ou BPCO, qui consiste à faire des expirations forcées dans un petit tube (spiromètre) rattaché à une machine.

Stéroïdes	Peut désigner des médicaments utilisés pour réduire l'enflure, la douleur et d'autres symptômes d'inflammation. La testostérone et ses dérivés sont des stéroïdes anabolisants qui peuvent être utilisés comme médicament (ou illicitement) pour augmenter la masse musculaire.
Stimulant	Une substance qui élève le niveau d'activité physiologique ou nerveuse dans le corps.
Syndrome de fatigue chronique (SFC)	Affection caractérisée par une fatigue persistante, inexpliquée, durant au moins six mois et qui ne peut être soulagée par le repos. Elle entraîne une réduction importante des activités professionnelles, sociales et personnelles.
Syndrome du canal carpien	État caractérisé par une lésion nerveuse à la face interne du poignet dû à un traumatisme causé par un travail répétitif.
Syndrome du côlon irritable (S I)	Trouble gastro-intestinal comportant un dérèglement des contractions des muscles de l'intestin (motilité) caractérisé par des douleurs abdominales, des ballonnements, la présence de mucus dans les selles et le dérèglement des habitudes intestinales avec alternance de diarrhée et de constipation, symptômes qui ont tendance à être chroniques et à croître et décroître au fil des ans.
Tendinite (Tennis elbow)	Une forme de tendinite. Il s'agit d'une blessure douloureuse d'un tendon du coude due à l'irritation et à l'inflammation causée par la torsion répétée du poignet ou de l'avant-bras. Toute action qui comprend une torsion répétée du poignet ou de l'avant-bras, comme l'utilisation d'un tournevis, peut causer cette blessure.
Test de l'antigène prostatique spécifique (dosage du PSA dans le sang)	Un test utilisé pour le dépistage du cancer de la prostate et pour surveiller ou contrôler son traitement.
Test de densité osseuse	Un test qui utilise un appareil à rayons X (appelé DEXA) pour déterminer la teneure minérale (calcium) de certains os, comme indicateur de la présence de l'ostéoporose.

Test de Papanicolaou (test Pap)	Test de dépistage, pratiqué par un médecin praticien, pour déceler la croissance anormale de cellules du col de l'utérus, laquelle est un signe précurseur de cancer. Le test comporte le prélèvement de cellules qui se détachent de la paroi vaginale au moyen d'un écouvillon.
Test diagnostique	Un test prescrit par un médecin pour déterminer ou confirmer un diagnostique, incluant les IRM, CT-SCAN ou test d'angiographie, les rayons X, les tests sanguins, etc.
Timbre à la nicotine (en anglais 'Patch')	Jeu de timbres autocollants qui fournissent une dose contrôlée de nicotine à travers la peau, afin de permettre aux fumeurs de réduire progressivement leur dépendance à l'égard de la cigarette.
Tomodensitométrie (CT-SCAN)	Tomographie axiale commandée par ordinateur. Examen comprenant l'utilisation de rayons X et d'un ordinateur pour produire une image d'une coupe transversale du corps.
Traumatisme cérébral	Une blessure au cerveau pouvant causer une vaste gamme de changements influant sur la mémoire, la sensation, la force, le langage, les mouvements et les émotions.
Trouble bipolaire	Trouble de l'humeur caractérisé par l'alternance d'épisodes maniaques et dépressifs.
Trouble de l'humeur (trouble effectif)	Trouble psychologique dont la caractéristique essentielle est une perturbation de l'humeur, comme la dépression, les troubles bipolaires, le trouble maniaco-dépressif ou la dysthymie.
Trouble déficitaire de l'attention (TDA)	Trouble neurobiologique chronique qui inclut une incapacité à soutenir l'attention et la concentration, de la distraction et de l'impulsivité.
Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH)	Trouble neurobiologique chronique qui inclut une incapacité à soutenir l'attention et la concentration, de la distraction et de l'impulsivité (TDA) avec hyperactivité.

Trouble obsessif compulsif	Trouble caractérisé par des obsessions et des compulsions récurrentes, suffisamment graves pour perturber le fonctionnement.
Trouble panique	Peut être une affection aiguë ou chronique caractérisée par des crises récurrentes de panique et (ou) un sentiment constant et vague d'anxiété. Les symptômes d'une crise, qui comprennent des palpitations, un essoufflement, de la transpiration, des étourdissements, des sensations de picotement, des bouffées de chaleur ou des frissons, ainsi qu'un sentiment de malheur imminent, semblent si terribles et menaçants que, souvent, la personne se présente au service d'urgence en étant convaincue qu'elle fait une crise cardiaque ou qu'elle devient folle.
Troubles anxieux	Maladies qui rendent la personne anxieuse la plupart du temps, sans raison évidente. Les personnes atteintes vivent des moments d'angoisse épisodiques, mais intenses qui les immobilisent.
Troubles neurologiques	Tout trouble du système nerveux. Il y a plus de 600 troubles neurologiques, tels que l'Alzheimer, l'épilepsie, tumeurs du cerveau.
Tuberculose	Une maladie infectieuse et contagieuse causant des tubercules (petits nodules arrondis), qui affecte le plus souvent les poumons.
Tylenol no 1, no 2, no 3, no 4.	Analgésiques contenant des niveaux variant d'acétaminophène et de codéine. Tylenol no 1 contient 325mg acétaminophène/8 mg codeine; Tylenol no 2 = 300/15; Tylenol no 3 = 300/30; Tylenol no 4 = 300/60. Au Canada, seul le Tylenol no 1 est disponible sans ordonnance.
Ulcère à l'estomac (ulcère à l'intestin)	Lésion dans la paroi de l'estomac ou de l'intestin qui ne guérit pas. Ce genre de lésion dans l'estomac est appelé ulcère gastrique, tandis qu'une lésion comparable dans la première partie de l'intestin grêle (duodénum) est appelée ulcère duodénal. Les ulcères gastriques et duodénaux forment la catégorie des ulcères gastroduodénaux ou peptiques.
Urologue	Spécialiste d'urologie, un domaine médico-chirurgical qui s'intéresse aux affections touchant l'appareil urinaire des deux sexes, et les organes génitaux chez les hommes.
Vaccin contre la grippe	Immunisation préventive contre les infections par le virus de la grippe.

Valium	Nom de marque déposée pour des préparations de diazépam, un produit sédatif obtenu d'un médecin, souvent utilisé pour le traitement de troubles anxieux, pour le soulagement à court-terme des symptômes d'anxiété, comme anticonvulsivant, agent anti-panique et pour favoriser la relaxation musculaire.
VIH	Virus de l'Immunodéficience Humaine, un type de virus pouvant causer le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise), qui affaiblit progressivement le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps à la maladie.
Wellbutrin	Médicament pour aider à réduire la consommation de cigarettes ou arrêter de fumer.
Xanax	Nom de marque déposée pour des préparations d'alprazolam, un produit sédatif obtenu auprès d'un médecin, souvent utilisé pour le traitement des troubles anxieux et du trouble panique, et pour le soulagement court-terme des symptômes d'anxiété.
Zyban (médicament)	Médicament vendu sur ordonnance qui, dans le cadre d'un programme global supervisé par un professionnel de la santé, peut aider une personne à arrêter de fumer.

Annexe B – Guide de référence / fiche de consultation rapide

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

	Page
Aperçu	B-1
Introduction	B-1
Guide de référence rapide	B-2

Aperçu

Introduction

La fiche de consultation rapide est un outil de référence pour l'ESCC. Elle fournit des renseignements utiles, par exemple, les utilisateurs et les utilisations des données de l'enquête à montrer aux répondants et/ou des conseils de navigation pour venir en aide aux intervieweurs.

Guide de référence rapide

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

CONTEXTE

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une **enquête nationale sur la santé**. Menée auprès de 110 000 Canadiens, elle pose des questions sur la santé, les facteurs influant sur la santé et l'utilisation de services de soins de santé.

OBJECTIFS

Cette enquête vise à améliorer la santé et les soins de santé en informant les décideurs au **niveau local**. L'ESCC va :

- **appuyer les services locaux de santé** en leur communiquant des renseignements à jour qui leur permettent d'évaluer les programmes et services en place et d'en concevoir de nouveaux, selon les besoins de leur collectivité;
- fournir, pour chaque province et territoire, des **renseignements actuels, détaillés et uniformes sur la santé**.

NATURE VOLONTAIRE DE L'ENQUÊTE

L'ESCC est une enquête **volontaire**. Il est important que chaque collectivité participe. Si le taux de réponse est bas dans un secteur, les décideurs n'auront pas accès à l'information sur la santé au sujet des habitants de leur collectivité.

De plus, pour que les résultats soient représentatifs de la population, il est important que divers types de personnes participent, y compris les personnes en santé.

PARTAGE ET COUPLAGE DES DONNÉES

Statistique Canada a conclu des ententes avec, les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada pour le partage des données de l'ESCC. Ainsi, les provinces et territoires éviteront de mener leurs propres enquêtes pour recueillir ces renseignements. Le couplage des données permet de faire des recherches approfondies; par exemple:

- Pour déterminer si les coûts des soins de santé sont moindres pour les personnes actives, un ministère de la santé a jumelé des données d'enquête sur l'activité physique avec des données tirées de factures de médecins.
- Pour connaître les médicaments prescrits le plus souvent pour soigner des maladies comme l'arthrite ou l'angine, le ministère de la santé d'une province a jumelé des données de l'ESCC sur les maladies chroniques avec l'information d'un programme d'assurance-médicaments.

Le partage et le jumelage des données que vous fournissez ne peuvent se faire qu'avec votre permission.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Comment pouvez-vous m'assurer que mes renseignements demeureront confidentiels?

Statistique Canada est obligé par la loi de protéger les données d'enquête. La *Loi sur la statistique* exige que les renseignements que vous nous fournissez demeurent strictement confidentiels. Statistique Canada prend toutes les mesures nécessaires pour vous protéger et tous ses employés doivent prêter un serment de discrétion.

Aucun renseignement permettant de vous identifier ou d'identifier votre famille ne sera divulgué à quiconque sans votre permission.

Qui se sert de ces renseignements? À quelles fins?

- **Les autorités locales de santé, les groupes communautaires et les organismes sociaux** se servent de ces renseignements pour déterminer la meilleure façon d'affecter les ressources dans le but d'améliorer la santé de leur collectivité.
- Les renseignements tirés de cette enquête serviront principalement **à l'élaboration de campagnes de sensibilisation** du public axées surtout sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
- **Les ministères provinciaux et territoriaux de la santé et les ministères du gouvernement fédéral** s'appuieront sur ces renseignements pour prendre des décisions de financement, déterminer les priorités et cerner les secteurs de préoccupation afin d'établir de nouveaux programmes, de nouvelles politiques et de nouvelles lois.
- **Les chercheurs** disposeront, plus que jamais, de données sur la santé leur permettant de suivre de près, d'analyser et de mesurer les facteurs qui nuisent à la santé et d'en faire état.
- **Les médias** utiliseront les renseignements obtenus pour sensibiliser la population par rapport à la santé, une question qui nous concerne tous.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE POUR L'ENQUÊTE

Service ATS (téléscripteur) : 1-866-753-7083

B.R. local :

B.R. : 1 800

Centre local de santé communautaire (CLSC) :

Ligne d'urgence :

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Annexe C – Codes de résultat

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

Page

Aperçu.....C-1
Introduction.....C-1
Codes de résultat de l'ESCC.....C-2

Aperçu

Introduction

Cette annexe fait un survol des codes de résultat qui sont utilisés dans tout l'environnement Blaise. Tous les codes de résultat disponibles pour les ITAO et les IPAO sont indiqués en ordre numérique croissant.

Un chiffrier plus détaillé décrivant les règles d'acheminement de tous les codes de résultat est disponible sur demande.

Codes de résultat de l’ESCC

Code	Mode (IPAO/ ITAO)	Base(Aérolaire/ CCTB)	En cours	Final	Attribution	Description
00	les deux	les deux				Pas commencé
02	ITAO	les deux		√	Manuel & Auto	Numéro de téléphone inexact
03	ITAO	les deux		√	Manuel	Numéro de téléphone hors service
04	ITAO	les deux	√	√	Manuel	Tonalité indiquant que tous les circuits sont occupés, bruits étranges, silence total
05	ITAO	les deux		√	Manuel	Message enregistré
11	les deux	les deux	√	√	Manuel	Personne à la maison/Pas de réponse
12	les deux	les deux	√	√	Manuel	Ligne occupée - tonalité normale
13	les deux	les deux	√		Manuel	Répondeur ou service de réponse — pas de message laissé
14	les deux	les deux	√		Manuel	Répondeur ou service de réponse — message laissé
15	les deux	les deux	√	√	Manuel	Filtrage, blocage ou appel acheminé à un autre numéro
18	IPAO	Aérolaire	√	√	Manuel	Aucun contact en raison de conditions atmosphériques
20	les deux	les deux	√	√	Manuel & Auto	Absent pour la durée de l'enquête
21	les deux	les deux	√		Manuel	Interview demandée dans l'autre langue officielle
22	les deux	les deux	√	√	Manuel	Barrière linguistique (pas une langue officielle)
23	les deux	les deux	√		Manuel	Interview interrompue ou en suspens

Codes de résultat de l'ESCC (suite)

Code	Mode (IPAO/ ITAO)	Base(Aérolaire/ CCTB	En cours	Final	Attribution	Description
24	les deux	les deux	√		Manuel & Auto	Rappel nécessaire; rendez-vous incertain
25	les deux	les deux	√		Manuel & Auto	Rappel nécessaire; rendez-vous précis
26	les deux	les deux	√		Manuel	Demande de vérification relative à l'enquête
27	les deux	les deux	√		Manuel	Téléphone des enfants / Contact avec une personne qui n'est pas membre du ménage.
28	les deux	les deux	√		Manuel	Demande d'interview par un autre intervieweur
29	ITAO	Aérolaire	√		Manuel	Interview en personne demandée / requise
30	ITAO	CCTB	√		Manuel	Dépistage/recherche requis
36	ITAO	CCTB		√	Manuel	Impossible de dépister / rechercher
38	ITAO	CCTB	√		Manuel	Rendez-vous avec la source de dépistage / recherche
39	les deux	Aérolaire		√	Manuel & Auto	Répondant a déménagé – Enquête ne fait pas de dépistage
40	les deux	les deux	√	√	Manuel	Hors de l'échantillon
42	ITAO	CCTB		√	Auto	Réserve Indienne
43	les deux	Aérolaire		√	Manuel & Auto	Entreprise
45	les deux	Aérolaire		√	Manuel & Auto	Établissement
51	les deux	Aérolaire		√	Manuel	Logement démoli
52	les deux	Aérolaire		√	Manuel	Logement en construction / rénovation
53	IPAO	Aérolaire		√	Manuel	Logement inoccupé
55	les deux	Aérolaire		√	Manuel & Auto	Logement saisonnier ou secondaire

Code	Mode (IPAO/ ITAO)	Base(Aérolaire/ CCTB	En cours	Final	Attribution	Description
56	les deux	Aérolaire		√	Manuel & Auto	Résidants non admissibles
57	ITAO	CCTB		√	Manual & Auto	Déménagé à l'extérieur du Canada
58	les deux	Aérolaire		√	Manuel	Visiteurs/Représentants de gouvernements étrangers
59	les deux	les deux		√	Manuel & Auto	Membres à temps plein des Forces canadiennes
60	ITAO	CCTB		√	Manuel & Auto	En établissement
61	les deux	les deux		√	Manual & Auto	Non admissible en raison de l'âge
63	les deux	les deux	√	√	Automatique	A déjà été interviewé pour cette enquête
64	ITAO	CCTB		√	Manual & Auto	Décédé
66	les deux	Aérolaire		√	Manuel	Chevauchement des échantillons
67	les deux	les deux		√	Manuel	Supprimé de l'échantillon
68	ITAO	Aérolaire	√	√	Manuel & Auto	Transféré sur le terrain
69	ITAO	les deux		√	Automatique	Maximum atteint
70	les deux	les deux		√	Automatique	Entièrement rempli
71	les deux	les deux	√	√	Manuel	Partiellement rempli
80	les deux	les deux	√	√	Manuel	Refus
81	les deux	les deux	√	√	Manuel	Refus – premier suivi
82	les deux	les deux	√	√	Manuel	Refus – deuxième suivi
83	les deux	les deux	√	√	Manuel	Refus – sans confirmation

Code	Mode (IPAO/ ITAO)	Base(Aérolaire/ CCTB	En cours	Final	Attribution	Description
85	les deux	les deux	√		Manuel	Raccroche l'appareil / refuse d'ouvrir la porte
86	les deux	les deux	√	√	Manuel	Refus par évitement
90	les deux	les deux	√	√	Manuel & Auto	Circonstances inhabituelles/particulières
91	IPAO	Aérolaire	√	√	Manuel	Menace à la sécurité
92	les deux	les deux	√	√	Manuel	Entretien impossible en raison de la condition mentale ou physique du répondant
93	ITAO	CCTB	√		Manuel	Lettre envoyée; suivi obligatoire pour un rendez-vous incertain
95	les deux	les deux	√	√	Manuel	Problèmes techniques

Codes de résultat de l'ESCC (suite)

Code	Description
00	**Pas commencé** – Le cas de l'enquête ou la composante n'est pas commencé par l'intervieweur. Ce code est assigné automatiquement par le système informatique.
02	**Numéro de téléphone inexact** - Ce code est attribué lorsque la composition du numéro de téléphone est exact mais qu'il ne s'agit pas du bon ménage ou le numéro a changé comme l'indique un message enregistré ou le (la) téléphoniste.
03	**Numéro de téléphone hors service** - Ce code est utilisé lorsqu'un message enregistré ou la téléphoniste informe l'intervieweur que le numéro composé n'est plus en service.
04	**Tonalité indiquant que tous les circuits sont occupés, bruits étranges, silence total** - Ce code est attribué lorsque l'intervieweur fait face à une tonalité indiquant que tous les circuits sont occupés, à un bruit étrange, par exemple, un clic, un bourdonnement, ou un silence total qui semblent indiquer une défectuosité technique. Des bruits étranges peuvent aussi provenir d'un télécopieur ou d'un système téléphonique spécial utilisé par les malentendants.
05	**Message enregistré-** Ce code est attribué lorsque l'intervieweur fait face à un message enregistré; par exemple, les prévisions météorologiques ou l'heure du jour, etc. Ne pas inclure les messages des boîtes vocales et des répondeurs automatiques.
11	**Personne à la maison / Pas de réponse** - Ce code est attribué quand la composition du numéro de téléphone produit une sonnerie, mais personne ne répond ou dans le cas d'une visite, personne ne répond à la porte.
12	**Ligne occupée tonalité normale** - Ce code est attribué quand la composition du numéro de téléphone produit une tonalité d'occupation normale.
13	**Répondeur ou service de réponse - pas de message laissé** - Ce code est attribué quand l'appel est reçu par un service de réponse téléphonique ou un répondeur qui enregistre les messages, mais **aucun message n'est laissé**.
14	**Répondeur ou service de réponse - message laissé**- Ce code est attribué quand l'appel est reçu par un service de réponse téléphonique ou un répondeur qui enregistre et **un message est laissé.**
15	**Filtrage, blocage, ou appel acheminé à un autre numéro** - Ce code est attribué quand l'intervieweur n'arrive pas à joindre le répondant parce que l'appel téléphonique est filtré, bloqué ou transféré à un message enregistré, et l'intervieweur ne peut pas laisser de message. Par exemple, l'appel aboutit à un message enregistré du genre « L'interlocuteur que vous avez joint a choisi de ne pas accepter ses appels pour le moment ».
18	**Aucun contact en raison des conditions atmosphériques** - Ce code est attribué quand l'intervieweur ne peut prendre contact avec le répondant en raison des conditions météorologiques; par exemple, le logement est enseveli par la neige pendant toute la durée de la collecte ou il n'y a pas de service téléphonique pendant toute la durée de la collecte en raison d'une tempête.
20	**Absent pour la durée de l'enquête** - Ce code est attribué quand un contact a été établi avec le répondant, mais l'interview n'a pas eu lieu et le répondant est absent pour le reste de la période d'enquête, par exemple, il est parti en vacances.
21	**Interview demandée dans l'autre langue officielle -** Ce code est attribué quand le répondant à demandé à ce qu'on l'interview dans la langue officielle de son choix et l'intervieweur n'est pas en mesure de communiquer dans cette langue.
22	**Barrière linguistique (pas langue officielle) -** Ce code est attribué quand l'interview ne peut avoir lieu parce que le répondant ne parle ni l'une ni l'autre des langues officielles et que l'intervieweur n'est pas en mesure de communiquer dans la langue du répondant.

Code	Description
23	**Interview Interrompue ou en suspens -** Ce code est attribué quand l'interview ou le listage initial ou la tenue de la liste était commencé et a été interrompu pour une raison quelconque. L'intervieweur doit rappeler le répondant ou doit continuer le listage initial ou la tenue de la liste plus tard.
24	**Rappel nécessaire; rendez-vous incertain -** Ce code est attribué quand l'intervieweur prend contact avec le répondant, mais celui-ci n'est pas disponible au moment de l'interview et demande à l'intervieweur de le rappeler. OU L'intervieweur prend contact avec une personne autre que le répondant et cette personne demande à l'intervieweur de le rappeler. Le moment fixé pour le nouvel appel est approximatif ou il s'agit d'une période de temps générale plutôt que d'un rendez-vous fixe.
25	**Rappel nécessaire; rendez-vous précis -** Ce code est attribué quand l'intervieweur prend contact avec le répondant, mais celui-ci n'est pas en mesure à ce moment de faire l'interview et demande à l'intervieweur de le rappeler à une date et heure précises.
26	**Demande de vérification relative à l'enquête -** Ce code est attribué quand le répondant ne veut pas participer à l'enquête sans s'être assuré de l'authenticité de l'enquête et avoir vérifié l'identité de l'intervieweur.
27	**Contact avec une personne non-admissible ou qui n'est pas un membre du ménage -** Ce code est attribué quand l'intervieweur entre en contact avec une personne qui ne fait pas partie du ménage, par exemple, une gardienne, ou un membre du ménage non admissible; un suivi est nécessaire.
28	**Demande d'entrevue par un autre intervieweur -** Ce code est attribué quand le répondant demande qu'un autre intervieweur mène l'interview.
29	**Interview en personne demandée / requise** - Ce code est attribué lorsque le répondant demande qu'un intervieweur se présente en personne à sa résidence parce qu'il ne veut pas répondre à l'interview au téléphone, ou lorsqu'un cas doit retourner sur le terrain pour le prochain cycle de collecte et que les renseignements sur le ménage sont intacts.
30	**Dépistage / recherche requis** - Ce code est attribué lorsque l'intervieweur ne peut pas contacter le répondant parce qu'il a déménagé ou que le numéro de téléphone n'est plus le même. Le dépistage doit être initié afin de trouver une nouvelle adresse ou un numéro de téléphone pour le répondant. Il est également attribué lorsqu'un dépistage/recherche a eu lieu, mais qu'un autre dépistage/recherche est nécessaire.
36	**Impossible de dépister/ rechercher** - Ce code est attribué lorsque toutes les sources ont été consultées et que le dépistage ou la recherche n'a pas été fructueux.
38	**Rendez-vous avec la source de dépistage / recherche** - Ce code est attribué lorsqu'un rendez-vous est pris afin de communiquer ultérieurement avec une source.
39	**Répondant a déménagé -** Ce code est attribué quand le répondant a déménagé du logement sélectionné (ou du ménage) et que l'enquête ne fait pas de dépistage.
40	**Hors de l'échantillon -** Ce code est attribué pour les cas qui ne cadrent pas dans les critères de l'échantillon lorsqu'un code plus précis n'est pas requis ou encore lorsque le motif ne fait pas partie des codes de cette catégorie. NOTE : La raison doit être notée, chaque fois que le code est utilisé.
42	**Réserve Indienne -** Ce code est attribué lorsque l'unité d'échantillonnage est située sur une réserve indienne et que les réserves indiennes ne font pas partie du champ de l'enquête.
43	**Entreprise -** Ce code est attribué lorsque l'unité d'échantillonnage est une entreprise et que les entreprises ne font pas partie du champ de l'enquête, par exemple, s'il s'agit d'une enquête – ménage.

Code	Description
45	**Établissement -** Ce code est attribué lorsque l'unité d'échantillonnage est un établissement et que les établissements ne font pas partie du champ de l'enquête, par exemple, s'il s'agit d'une enquête - ménage qui n'inclut que des ménages privés ou ordinaires.
51	**Logement démoli -** Ce code est attribué dans les situations suivantes : • logement démoli • logement converti en locaux commerciaux et qui ne sert plus de domicile • maison, roulotte ou maison mobile retirée de son terrain maison abandonnée, inhabitable
52	**Logement en construction / rénovation -** Ce code est attribué lorsque le logement est en voie de construction ou de rénovation et n'est pas prêt pour l'occupation.
53	**Logement inoccupé -** Ce code est attribué lorsqu'il n'y a pas d'occupants dans le logement. Un logement peut être inoccupé même s'il est meublé, puisque nombre de logements sont loués complètement meublés.
55	**Logement saisonnier ou secondaire -** Ce code est attribué pour les logements qui ne constituent pas le lieu habituel de résidence d'un ménage, par exemple, les chalets d'été, chalets de ski, camps de chasse, etc.
56	**Résidents non-admissible -** Ce code est attribué lorsque le répondant d'un logement ne répond pas aux conditions d'inclusion dans une enquête et lorsqu'un code plus précis n'est pas requis ou que les codes précis mentionnés ci-dessous ne s'appliquent pas.
57	**Déménagé à l'extérieur du Canada -** Ce code est attribué quand un ou plusieurs résidents du logement sont déménagés et ne sont plus résidents du Canada et l'enquête stipule que de tels résidents ne font pas partie du champ de l'enquête.
58	**Visiteurs/représentants de gouvernements étrangers -** Ce code est attribué quand un ou plusieurs résidents du logement ont un lieu habituel de résidence dans un autre pays, par exemple les représentants d'un gouvernement étranger, des étudiants détenteurs d'un visa, etc., et l'enquête stipule que de tels résidents ne font pas partie du champ de l'enquête.
59	**Membres à temps plein des forces armées canadiennes -** Ce code est attribué lorsqu'un ou plusieurs résidents du logement sont des membres à plein temps des Forces canadiennes et l'enquête stipule que de tels résidents ne font pas partie du champ de l'enquête.
60	**En établissement -** Ce code est attribué lorsqu'un ou plusieurs résidents du logement ont été institutionnalisés et l'enquête stipule que de tels résidents ne font pas partie du champ de l'enquête.
61	**Non admissible en raison de l'âge** - Ce code est attribué lorsqu'un ou plusieurs résidents du logement n'entrent pas dans les critères d'âge de l'enquête et ne font donc pas partie du champ de l'enquête.
63	**A déjà été interviewé pour cette enquête -** Ce code est attribué dans les cas suivants : résidents de logements dotés de deux numéros de téléphone différents dont les deux numéros de téléphones ont été sélectionnés pour l'enquête et un couple a la garde conjointe de leur enfant et les deux sont sélectionnés pour être interviewés au sujet de leur enfant.
64	**Décédé -** La personne sélectionnée est décédée.

Code	Description
66	**Chevauchement des échantillons -** Ce code est attribué par **les surveillants seulement**. On l'attribue pour retirer des unités d'échantillonnage dans les situations suivantes : • en raison d'une modification apportée au plan d'échantillonnage, le même logement est sélectionné à l'intérieur du délai de deux ans de rotation de l'échantillon de l'EPA; et/ou • un logement est sélectionné pour plus d'une enquête à la fois.
67	**Supprimé de l'échantillon -** Ce code est attribué par **les surveillants seulement**. Généralement, ce code reflète des décisions administratives ou qui font autorité et qui ont été prises concernant une unité qui présente des difficultés ou des circonstances inhabituelles.
68	**Transféré à un autre mode de collecte -** Ce code est disponible pour l'ITAO lorsqu'un cas est transféré à un autre mode de collecte : • Les cas EPA qui sont transférés de ITAO à IPAO sont enlevés de l'échantillon actif ITAO et sont traités 'non-admissibles' dans IDPP ou • toutes les autres enquêtes sociales traitent les cas QE en-cours jusqu'à ce que l'information soit terminée.
69	**Maximum atteint-** Ce code est automatiquement attribué par le système lorsqu'un nombre maximum de tentatives ont été faites.
70	**Entièrement rempli-** Ce code est attribué automatiquement par l'ordinateur lorsqu'une interview ou une composante ou une tenue de liste est complètement terminée.
71	**Partiellement rempli-** Ce code est attribué lorsqu'une interview ou une composante ou une tenue de liste n'est pas complètement achevée.
80	**Refus -** Ce code est attribué lorsque le répondant refuse de fournir une partie ou la totalité des renseignements liés à l'enquête.
81	**1er suivi d'un refus -** Ce code est attribué lorsque le répondant refuse de donner une partie ou la totalité des renseignements liés à l'enquête lors de la première tentative de suivi à la suite d'un refus.
82	**2ième suivi d'un refus -** Ce code sera utilisé lorsqu'à la deuxième et finale tentative de conversion d'un refus, le répondant refuse de donner une partie ou la totalité des renseignements liés à l'enquête.
83	**Refus sans confirmation -** Ce code est attribué lorsque l'intervieweur a établi le contact avec un membre du ménage, mais le membre refuse de participer à l'enquête et ne veut confirmer que l'intervieweur a atteint le bon logement ou répondant.
85	**Raccroche l'appareil/refuse d'ouvrir la porte** – Dans le cas d'une **ITAO**, ce code est utilisé lorsqu'un répondant raccroche le téléphone avant que l'interviewer puisse compléter l'introduction et sans même dire qu'il refuse de compléter l'enquête. / Dans le cas d'une **IPAO**, ce code est utilisé lorsque l'intervieweur peut constater qu'il y a quelqu'un à la maison, mais qu'il n'y a pas de réponse à la porte. Le cas est traité comme un non-contact.
86	**Refus par évitement -** Ce code est attribué par l'intervieweur lorsqu'un cas a reçu le code 85 dans les tentatives antérieures et que le cas doit maintenant être désigné comme refus et acheminé au groupe de refus.

Code	Description
90	**Circonstances inhabituelles/particulières -** Ce code est attribué lorsqu'une fois dans le module, Âge du répondant sélectionné (ANC), il est spécifié que le répondant sélectionné est âgé de moins de 12 ans. Le cas est alors automatiquement codé 90 et appelle le module Sortie. Ceci est une erreur dans la démographie; un commentaire, précédé de 3 astérisques, doit donc être ajouté dans les notes permanentes. Ce code sera également assigné dans des circonstances imprévisibles comme la maladie ou le décès d'un membre du ménage ou d'un employé d'une entreprise, un incendie, une inondation, un ménage mis en quarantaine, etc., empêchant l'intervieweur de mener une interview ou de faire une tenue de liste pendant la période de collecte.
91	**Menace à la sécurité** - Ce code est attribué lorsqu'une situation dangereuse présente une menace à la sécurité, par exemple un chien méchant ou un autre animal, un voisinage violent.
92	**Interview impossible en raison de la condition mentale ou physique du répondant -** Ce code est attribué quand le répondant n'est pas en mesure de prendre part à l'interview parce qu'il est handicapé, à savoir maladie d'Alzheimer, syndrome de Down, trouble déficitaire de l'attention, déficience auditive, etc.
93	**Lettre envoyée; suivi obligatoire pour un rendez-vous incertain** - Ce code est attribué si une lettre est envoyée au répondant et qu'un rappel est nécessaire, c.-à-d. un suivi pour une lettre à la suite d'un refus ou de l'impossibilité de prendre contact.
95	**Problèmes techniques -** L'intervieweur n'est pas en mesure de continuer en raison de problèmes techniques avec l'ordinateur portable.

Annexe D – Modules par province / territoire

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

Page

Aperçu.....D-1
Introduction.....D-1
Modules par province / territoire D-2

Aperçu

Introduction

Cette annexe présente tous les modules (avec le type : commun, optionnel et thématique) pour chaque province / territoire. Ces modules sont indiqués dans l'ordre où ils apparaissent dans l'application (sans les composantes Entrée et Sortie). Veuillez vous reporter au chapitre 3, Section C, pour voir la liste alphabétique.

Terre Neuve et Labrador

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
9	Optionnel	ADL	Activités de la vie quotidienne
14	Optionnel	DEN	Soins dentaires
15	Optionnel	CIH	Changements faits pour améliorer la santé
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
22	Optionnel	SCA	Méthodes pour cesser de fumer
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
34	Commun	PAA	Activités physique
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
46	Optionnel	BPC	Tension artérielle - Vérification
47	Optionnel	PAP	Test Pap
48	Optionnel	MAM	Mammographie
49	Optionnel	PSA	Dépistage du cancer de la prostate
50	Optionnel	CCS	Dépistage du cancer du côlon et du rectum
53	Optionnel	EYX	Examens de la vue

Terre Neuve et Labrador (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
62	Optionnel	WST	Stress au travail
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
74	Optionnel	UCN	Besoins de santé non comblés
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Ile-du-Prince-Édouard

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
9	Optionnel	ADL	Activités de la vie quotidienne
10	Optionnel	INJ	Blessures
15	Optionnel	CIH	Changements faits pour améliorer la santé
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
19	Optionnel	FGU	Utilisation du guide alimentaire canadien
20	Commun	SMK	Usage du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
29	Optionnel	MED	Utilisation de médicaments
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
38	Optionnel	SAC	Activités sédentaires
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
46	Optionnel	BPC	Tension artérielle - Vérification
47	Optionnel	PAP	Test Pap
50	Optionnel	CCS	Dépistage du cancer du côlon et du rectum
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale

Ile-du-Prince-Édouard (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
64	Optionnel	SPS	Provisions sociales
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Nouvelle-Écosse

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
9	Optionnel	ADL	Activités de la vie quotidienne
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
23	Optionnel	TAL	Produits alternatifs du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
42	Optionnel	MXA	Expériences maternelles - Consommation d'alcool
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
45	Optionnel	PCU	Examen général
46	Optionnel	BPC	Tension artérielle - Vérification
49	Optionnel	PSA	Dépistage du cancer de la prostate
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide

Nouvelle-Écosse (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
71	Optionnel	ACC	Accès aux services de soins de santé
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
74	Optionnel	UCN	Besoins de santé non comblés
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Nouveau-Brunswick

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
9	Optionnel	ADL	Activités de la vie quotidienne
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
36	Optionnel	UPE	Utilisation de l’équipement protecteur
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
50	Optionnel	CCS	Dépistage du cancer du côlon et du rectum
51	Optionnel	SPI	Spirométrie
52	Optionnel	DIA	Soins pour le diabète
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires

Nouveau-Brunswick (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
71	Optionnel	ACC	Accès aux services de soins de santé
72	Optionnel	WTM	Temps d’attente
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Québec

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
18	Optionnel	FDC	Choix alimentaires
20	Commun	SMK	Usage du tabac
24	Optionnel	NDE	Dépendance à la nicotine
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
33	Optionnel	NBE	Environnement du quartier
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
37	Optionnel	SSB	Protection contre le soleil
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
45	Optionnel	PCU	Examen général
48	Optionnel	MAM	Mammographie
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires

Québec (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
71	Optionnel	ACC	Accès aux services de soins de santé
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Ontario

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
16	Optionnel	SLP	Sommeil
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
19	Optionnel	FGU	Utilisation du guide alimentaire canadien
20	Commun	SMK	Usage du tabac
23	Optionnel	TAL	Produits alternatifs du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
31	Optionnel	DRG	Usage de substances
33	Optionnel	NBE	Environnement du quartier
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
37	Optionnel	SSB	Protection contre le soleil
38	Optionnel	SAC	Activités sédentaires
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
52	Optionnel	DIA	Soins pour le diabète
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale

Ontario (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
58	Optionnel	SFE	Estime de soi
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Manitoba

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
15	Optionnel	CIH	Changements faits pour améliorer la santé
16	Optionnel	SLP	Sommeil
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
33	Optionnel	NBE	Environnement du quartier
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
37	Optionnel	SSB	Protection contre le soleil
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
62	Optionnel	WST	Stress au travail
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé

Manitoba (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
68	Optionnel	PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Saskatchewan

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
15	Optionnel	CIH	Changements faits pour améliorer la santé
16	Optionnel	SLP	Sommeil
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
33	Optionnel	NBE	Environnement du quartier
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
37	Optionnel	SSB	Protection contre le soleil
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
62	Optionnel	WST	Stress au travail
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé

Saskatchewan (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
68	Optionnel	PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Alberta

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
14	Optionnel	DEN	Soins dentaires
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
31	Optionnel	DRG	Usage de substances
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
36	Optionnel	UPE	Utilisation de l’équipement protecteur
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
43	Optionnel	DRV	Conduite et sécurité
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
46	Optionnel	BPC	Tension artérielle - Vérification
47	Optionnel	PAP	Test Pap
48	Optionnel	MAM	Mammographie
50	Optionnel	CCS	Dépistage du cancer du côlon et du rectum
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
57	Optionnel	SWL	Satisfaction à l’égard de la vie

Alberta (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
63	Optionnel	STS	Sources de stress
64	Optionnel	SPS	Provisions sociales
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
74	Optionnel	UCN	Besoins de santé non comblés
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Colombie-Britannique

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
10	Optionnel	INJ	Blessures
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
23	Optionnel	TAL	Produits alternatifs du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d’alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
33	Optionnel	NBE	Environnement du quartier
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
38	Optionnel	SAC	Activités sédentaires
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
41	Optionnel	MXS	Expériences maternelles - Usage du tabac
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
54	Optionnel	STG	Stigmatisation à l’égard de la dépression
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
58	Optionnel	SFE	Estime de soi
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide

Colombie-Britannique (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Optionnel	MDA	Attachement au médecin –C.B seulement
67	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
76	Optionnel	LOP	Perte de productivité
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Yukon

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
8	Optionnel	HUI	Indice de l'état de santé
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
21	Optionnel	SCH	Usage du tabac - Les étapes du changement
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine
29	Optionnel	MED	Utilisation de médicaments
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
31	Optionnel	DRG	Usage de substances
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
51	Optionnel	SPI	Spirométrie
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide
64	Optionnel	SPS	Provisions sociales
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé

Yukon (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
68	Optionnel	PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
71	Optionnel	ACC	Accès aux services de soins de santé
72	Optionnel	WTM	Temps d’attente
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Territoires Du Nord-Ouest

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
8	Optionnel	HUI	Indice de l'état de santé
15	Optionnel	CIH	Changements faits pour améliorer la santé
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
20	Commun	SMK	Usage du tabac
23	Optionnel	TAL	Produits alternatifs du tabac
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine
29	Optionnel	MED	Utilisation de médicaments
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
52	Optionnel	DIA	Soins pour le diabète
54	Optionnel	STG	Stigmatisation à l'égard de la dépression
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
58	Optionnel	SFE	Estime de soi
60	Optionnel	DEP	Dépression
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide

Territoires Du Nord-Ouest (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
68	Optionnel	PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
74	Optionnel	UCN	Besoins de santé non comblés
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Nunavut

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
1	Commun	GR	Interview par personne interposée
2	Commun	ANC1	Âge du répondant
3	Commun	REL	Matrice des relations
4	Commun	MAC	Activité principale
5	Commun	GEN	État de santé général
6	Commun	HWT	Taille et poids - Autodéclarés
7	Commun	CCC	Problèmes de santé chroniques
8	Optionnel	HUI	Indice de l'état de santé
13	Optionnel	OHT	Santé buccodentaire
14	Optionnel	DEN	Soins dentaires
17	Commun	FVC	Consommation de fruits et de légumes
18	Optionnel	FDC	Choix alimentaires
20	Commun	SMK	Usage du tabac
22	Optionnel	SCA	Méthodes pour cesser de fumer
26	Commun	ETS	Exposition à la fumée secondaire
27	Commun	ALC	Consommation d'alcool
28	Thématique	ALW	Consommation d'alcool au cours de la dernière semaine
30	Thématique	DRM	Méthodes de consommation de drogues
31	Optionnel	DRG	Usage de substances
32	Optionnel	CPG	Jeu excessif
34	Commun	PAA	Activités physiques
35	Commun	PAY	Activités physiques pour les jeunes
39	Thématique	SXB	Comportements sexuels
40	Commun	MEX	Expériences maternelles
41	Optionnel	MXS	Expériences maternelles - Usage du tabac
44	Commun	FLU	Vaccins contre la grippe
47	Optionnel	PAP	Test Pap
55	Thématique	PMH	Santé mentale positive
56	Thématique	CMH	Consultations au sujet de la santé mentale
61	Thématique	SUI	Pensées suicidaires et tentatives de suicide

Nunavut (suite)

Ordre	Type	Acronyme	Nom du module
65	Commun	PHC	Soins de santé primaires
66	Commun	CHP	Contacts avec des professionnels de la santé
68	Optionnel	PSC	Satisfaction des patients - Soins de santé communautaires
70	Thématique	PEX	Expériences comme patient
73	Thématique	HMC	Services de soins de santé à domicile
75	Commun	LBF	Population active
77	Commun	SDC	Renseignements sociodémographiques
78	Commun	PMK	Personne la mieux renseignée au sujet du ménage
79	Thématique	INS	Couverture d'assurance
80	Optionnel	FSC	Sécurité alimentaire
81	Commun	INC	Revenu
82	Commun	ADM	Renseignements administratifs

Annexe E – Adresse dans le champ de l’enquête (18+)

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

Page

Aperçu..... E-1

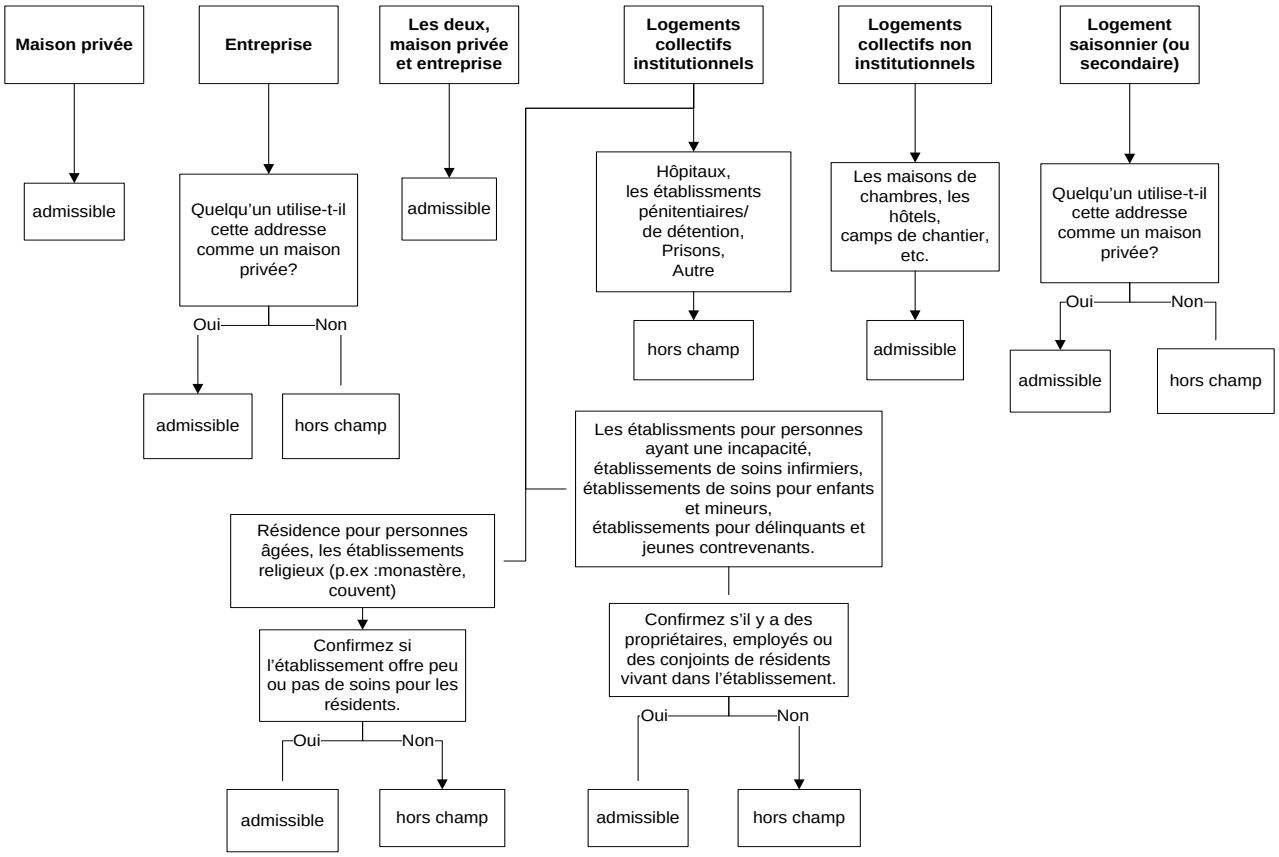
Introduction..... E-1

Questionnaire d’enquête E-2

Aperçu

Introduction

Cette annexe présente l’adresse dans le champ de l’enquête (18+).de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.


Maison privée
Entreprise
Les deux, maison privée et entreprise
Logements collectifs institutionnels
Logements collectifs non institutionnels
Logement saisonnier (ou secondaire)
admissible
Quelqu'un utilise-t-il cette addresse comme un maison privée?
Oui
Non
admissible
hors champ
admissible
Hôpitaux, les établissments pénitentiaires/ de détention, Prisons, Autre
hors champ
Les maisons de chambres, les hôtels, camps de chantier, etc.
admissible
Quelqu'un utilise-t-il cette addresse comme un maison privée?
Oui
Non
admissible
hors champ
Les établissments pour personnes ayant une incapacité, établissements de soins infirmiers, établissements de soins pour enfants et mineurs, établissements pour délinquants et jeunes contrevenants.
Résidence pour personnes âgées, les établissements religieux (p.ex :monastère, couvent)
Confirmez si l'établissement offre peu ou pas de soins pour les résidents.
Oui
Non
admissible
hors champ
Confirmez s'il y a des propriétaires, employés ou des conjoints de résidents vivant dans l'établissement.
Oui
Non
admissible
hors champ

Annexe F – Documents pour le répondant

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

	Page
Aperçu	F-1
Introduction	F-1
Lettre de présentation	F-2
Lettre de rendez-vous manqué	F-3
Lettre en cas de non-contact	F-4
Lettre en cas de refus	F-5
Lettre partiellement rempli	F-6
Note aux parents et tuteurs	F-7

Aperçu

Introduction

Cette annexe présente les documents adressés au répondant de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC).

Lettre de présentation

Date

Nom du répondant
Adresse

Madame, Monsieur,

L'**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,** menée par Statistique Canada, permet de recueillir des renseignements sur la santé et le bien-être des Canadiens, les facteurs qui influent sur leur santé, et leur utilisation des services de soins de santé.

Votre participation est importante

Les résultats de cette enquête aideront les communautés ainsi que les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé à mieux comprendre et traiter des enjeux tels que :

- l'accès aux services locaux de soins de santé et de soins à domicile;
- les habitudes de vie ayant une incidence sur la santé;
- les problèmes de santé chroniques.

Participer est facile et sûr

- Au cours des prochaines semaines, un intervieweur de Statistique Canada communiquera avec vous, et un membre de votre ménage de 12 ans et plus sera sélectionné au hasard pour participer à une interview[1].
- Afin de tenir compte de l'emploi du temps chargé des participants, nos intervieweurs travaillent le jour, le soir et les week-ends.
- Cette enquête volontaire est menée en vertu de la *Loi sur la statistique,* qui garantit que tous les renseignements que vous fournirez demeureront strictement confidentiels. Vos renseignements pourraient être utilisés par Statistique Canada à d'autres fins statistiques.

Pour obtenir plus de renseignements

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec xxx, sans frais, au

1-800-XXX -XXXX (ATS : 1-866-XXX-XXXX). Vous pouvez également consulter le dépliant ci-joint ou visiter notre site Web au www.statcan.gc.ca/escc.

Nous vous remercions à l'avance de votre participation.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

La directrice / le directeur,

[1]. Si la personne sélectionnée est âgée de moins de 16 ans, nous demanderons le consentement verbal d'un parent ou tuteur légal pour que cette personne participe à l'enquête.

Lettre de rendez-vous manqué

Date
Nom du répondant
Adresse

Madame, Monsieur,

Un intervieweur de Statistique Canada a récemment communiqué avec un membre de votre ménage au sujet de l'**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes** (ESCC). À ce moment-là, un rendez-vous a été fixé pour mener une interview. Depuis, nous n'avons réussi à joindre personne de votre ménage.

Veuillez communiquer avec nous

Afin de fixer un nouveau rendez-vous, veuillez communiquer avec nous au xxx-xxx-xxxx ou, sans frais, au 1-8XX-XXX-XXXX (ATS : 1-866-753-7083). Si vous ne téléphonez pas dans les prochains jours, un intervieweur de Statistique Canada fera un suivi. Il pourra également répondre à toutes vos questions.

Votre participation est importante

L'ESCC est une enquête nationale qui permet de recueillir des renseignements sur la santé et le bien-être des Canadiens, sur les facteurs influant sur leur santé ainsi que sur leur utilisation des services de soins de santé. Les renseignements sont recueillis à l'échelon des collectivités. Les données sont utilisées pour :

- soutenir les services de santé locaux en fournissant des renseignements qui permettent d'évaluer les programmes existants et d'en concevoir de nouveaux;
- fournir de l'information essentielle sur les questions d'accès et de temps d'attente.

Pour obtenir plus de renseignements

Veuillez visiter le www.statcan.gc.ca/escc.

Nous vous remercions à l'avance de votre participation à l'ESCC.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Nom
Gestionnaire de la collecte des données
Région xxx

Lettre en cas de non-contact

Date

(Adresse)

Madame, Monsieur,

Votre ménage a été sélectionné pour participer à l'**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes** (ESCC) menée par Statistique Canada. Après plusieurs tentatives, nous n'avons pas été en mesure de vous joindre.

Cette enquête permet de recueillir des renseignements au sujet de la santé et du bien-être des Canadiens, des facteurs qui influent sur leur santé et de leur utilisation des services de soins de santé.

Votre participation est importante

Les planificateurs des services de santé régionaux utilisent ces données pour :

- s'assurer que les services de santé existants satisfont aux besoins de votre collectivité;
- évaluer les programmes déjà en place en matière de santé;
- planifier de nouveaux programmes et services.

Participer est facile et sécuritaire

Afin de convenir d'un moment pour mener l'interview, veuillez communiquer directement avec xxx au xxx-xxx-xxxx ou, sans frais, au 1-8xx-xxx-xxxx (ATS : 1-866-753-7083).

L'ESCC est menée en vertu de la *Loi sur la statistique*, qui garantit que tous les renseignements que vous fournissez demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement à des fins statistiques. Nous ne diffusons aucun renseignement qui permettrait de vous identifier ou d'identifier d'autres membres de votre ménage.

Pour obtenir plus de renseignements

Veuillez prendre connaissance du dépliant ci-joint ou visiter le www.statcan.gc.ca/escc.

Nous vous remercions à l'avance de votre participation.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Nom
Gestionnaire de la collecte des données,
Région XX

Lettre en cas de refus

Date
(Adresse)

Madame, Monsieur,

Statistique Canada mène actuellement l'**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes** (ESCC), à laquelle vous avez mentionné ne pas souhaiter participer. Permettez-nous de prendre quelques instants pour vous expliquer l'importance de votre participation.

Votre participation est importante
Les résultats de l'ESCC sont utilisés pour planifier des services de soins de santé qui répondront aux besoins futurs de votre collectivité et pour évaluer les programmes de santé existants. Afin que les données tirées de cette enquête fournissent un portrait juste de la santé de la population canadienne dans son ensemble, il est important d'obtenir les réponses de tous les participants sélectionnés.

Vos renseignements représentent ceux de plusieurs autres personnes. En participant à cette enquête, vous contribuerez à faire une différence positive dans votre collectivité.

Participer est facile et sécuritaire
Au cours des prochains jours, un intervieweur communiquera de nouveau avec vous. Nous espérons que vous accepterez de prendre le temps de participer à l'enquête.

Cette enquête est menée en vertu de la *Loi sur la statistique*, qui garantit que tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement à des fins statistiques. Nous ne diffusons aucun renseignement qui permettrait de vous identifier ou d'identifier d'autres membres de votre ménage.

Pour obtenir plus de renseignements
Veuillez visiter le www.statcan.gc.ca/escc ou communiquer avec XXX au XXX-XXX-XXXX ou, sans frais, au 1-800-XXX-XXXX (ATS : 1-866-753-7083).

Sachant combien votre temps est précieux, nous vous remercions à l'avance de votre participation.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Nom
Gestionnaire de la collecte des données
Région XX

Lettre partiellement remplie

Date
(Adresse)

Madame OU Monsieur xxx,

Comme vous le savez, Statistique Canada mène actuellement l'**Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes** (ESCC). Nous vous remercions du temps que vous avez pris jusqu'à maintenant pour y participer.

Votre participation est très importante et il est essentiel que tous les questionnaires soient entièrement remplis pour que les résultats de l'enquête soient les plus justes et fiables possible. Nous avons tenté, sans succès, de vous joindre afin de terminer l'interview.

Communiquez avec nous
Afin de déterminer un moment qui vous conviendra pour terminer l'interview, veuillez communiquer avec xxx au xxx-xxx-xxxx ou, sans frais, au 1-8xx-xxx-xxxx (ATS : 1-866-753-7083).

Les résultats tirés de cette enquête fournissent l'information nécessaire pour élaborer de nouveaux programmes et services, évaluer les initiatives déjà en place et même adapter les programmes de santé publique pour répondre aux besoins de votre collectivité.

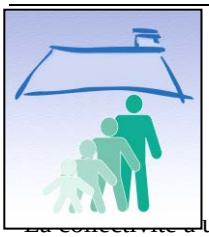
L'ESCC est menée en vertu de la *Loi sur la statistique*, qui garantit que tous les renseignements que vous fournissez demeureront confidentiels et seront utilisés uniquement à des fins statistiques. Nous ne diffusons aucun renseignement qui permettrait de vous identifier ou d'identifier d'autres membres de votre ménage.

Pour obtenir plus de renseignements
Veuillez visiter le www.statcan.gc.ca/escc.

Sachant combien votre temps est précieux, nous vous remercions encore une fois de votre participation.

Veuillez recevoir, Madame OU Monsieur xxx, nos meilleures salutations.

Nom
Gestionnaire de la collecte des données
Région XX



Note aux parents et tuteurs
Interview des jeunes dans le cadre de l'Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes

Vers un avenir en santé

La collectivité a un rôle important à jouer pour donner à la jeunesse d'aujourd'hui le plus de chances possible de mener une longue vie en bonne santé.

Offrir de bons services de santé à tous les jeunes est l'un des moyens dont dispose la collectivité pour s'acquitter de cette responsabilité. Ces services comprennent les programmes de prévention de la maladie et de promotion de la santé.

Pour mieux préciser quels devraient être ces programmes dans l'avenir, les planificateurs régionaux des services de santé ont besoin de renseignements à jour sur la santé des jeunes de leur région. Votre enfant/adolescent a été sélectionné au hasard pour participer à cette enquête.

Certains des sujets de l'enquête

- État de santé général
- Activités physiques
- Consommation d'alcool
- Problèmes de santé chroniques
- Utilisation des soins de santé
- Poids et taille
- Nutrition
- Usage du tabac
- Limitation des activités

Bien que l'interview soit menée avec votre enfant, parce qu'il est âgé de moins de 18 ans, nous vous demanderons de répondre à la dernière partie de l'enquête qui contient des questions d'ordre général concernant votre logement et auxquelles votre enfant pourrait ne pas pouvoir répondre avec précision.

Statistique Canada et votre province ou territoire procèderont au couplage de l'information recueillie lors de l'enquête avec d'autres dossiers de santé. Si votre enfant à moins de 14 ans, nous vous demanderons la permission pour partager l'information recueillie lors de l'enquête auprès de Santé Canada et les ministères provinciaux et territoriaux de la santé.

Plus nous obtenons de renseignements, plus ils seront utiles

Toute personne, quel que soit son âge, peut décider de répondre ou non à une question, n'importe quand durant l'interview. Naturellement, plus nous recueillerons de renseignements, mieux ce sera. Toutefois, même une interview partiellement achevée contient des données utiles.

Nous respectons la vie privée et la confidentialité

Nous devons recueillir les renseignements les plus précis possible, parce que ces renseignements permettront d'élaborer de meilleurs services, programmes et politiques en matière de santé. Puisque toute personne interviewée, quel que soit son âge, peut être réticente si elle pense que quelqu'un de son entourage peut entendre ses réponses, nous préférons réaliser l'interview de façon confidentielle.

Il existe des moyens d'assurer la confidentialité des réponses de votre enfant tout en veillant à ce que vous et votre enfant vous sentiez à l'aise par rapport aux procédures d'interview. L'intervieweur se fera un plaisir de discuter de ce point avec vous.

Nous espérons que nous pourrons compter sur votre appui!

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

CONTEXTE

L'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une **enquête nationale sur la santé**. Menée auprès de 110 000 Canadiens, elle pose des questions sur la santé, les facteurs influant sur la santé et l'utilisation de services de soins de santé.

OBJECTIFS

Cette enquête vise à améliorer la santé et les soins de santé en informant les décideurs au **niveau local**. L'ESCC va :

- **appuyer les services locaux de santé** en leur communiquant des renseignements à jour qui leur permettent d'évaluer les programmes et services en place et d'en concevoir de nouveaux, selon les besoins de leur collectivité;
- fournir, pour chaque province et territoire, des **renseignements actuels, détaillés et uniformes sur la santé**.

NATURE VOLONTAIRE DE L'ENQUÊTE

L'ESCC est une enquête **volontaire**. Il est important que chaque collectivité participe. Si le taux de réponse est bas dans un secteur, les décideurs n'auront pas accès à l'information sur la santé au sujet des habitants de leur collectivité.

De plus, pour que les résultats soient représentatifs de la population, il est important que divers types de personnes participent, y compris les personnes en santé.

PARTAGE ET COUPLAGE DES DONNÉES

Statistique Canada a conclu des ententes avec, les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada pour le partage des données de l'ESCC. Ainsi, les provinces et territoires éviteront de mener leurs propres enquêtes pour recueillir ces renseignements. Le couplage des données permet de faire des recherches approfondies; par exemple :

- Pour déterminer si les coûts des soins de santé sont moindres pour les personnes actives, un ministère de la santé a jumelé des données d'enquête portant sur l'activité physique avec des données tirées des factures de médecins.
- Pour connaître les médicaments prescrits le plus souvent pour soigner des maladies comme l'arthrite ou l'angine, le ministère de la santé d'une province a jumelé des données de l'ESCC sur les maladies chroniques avec l'information d'un programme d'assurance-médicaments.

Le partage et le couplage d'information à lieu seulement qu'avec votre permission.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Comment pouvez-vous m'assurer que mes renseignements demeureront confidentiels?

Statistique Canada est obligé par la loi de protéger les données d'enquête. La *Loi sur la statistique* exige que les renseignements que vous nous fournissez demeurent strictement confidentiels. Statistique Canada prend toutes les mesures nécessaires pour vous protéger et tous ses employés doivent prêter un serment de discrétion.

Aucun renseignement permettant de vous identifier ou d'identifier votre famille ne sera divulgué à quiconque sans votre permission.

Qui se sert de ces renseignements? À quelles fins?

- **Les autorités locales de santé, les groupes communautaires et les organismes sociaux** se servent de ces renseignements pour déterminer la meilleure façon d'affecter les ressources dans le but d'améliorer la santé de leur collectivité.
- Les renseignements tirés de cette enquête serviront principalement à **l'élaboration de campagnes de sensibilisation** du public axées surtout sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
- Les **ministères provinciaux et territoriaux de la santé et les ministères du gouvernement fédéral** s'appuieront sur ces renseignements pour prendre des décisions de financement, déterminer les priorités et cerner les secteurs de préoccupation afin d'établir de nouveaux programmes, de nouvelles politiques et de nouvelles lois.
- Les **chercheurs** disposeront, plus que jamais, de données sur la santé leur permettant de suivre de près, d'analyser et de mesurer les facteurs qui nuisent à la santé et d'en faire état.
- Les **médias** utiliseront les renseignements obtenus pour sensibiliser la population par rapport à la santé, une question qui nous concerne tous.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE POUR L'ENQUÊTE

Service ATS (téléscripteur) : 1 866 753 7083

B.R. local :

B.R. : 1 800

Centre local de santé communautaire (CLSC) :

Téléphone d'urgence :

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

Annexe G – Questions et réponses

Dans cette annexe

La présente annexe renferme les sections suivantes :

Page

Aperçu.....G-1
Introduction.....G-1
Questions et réponses.....G-2
Survol du module Ordonnances (Janvier – Juin 2016) G-11
Non-respect lié aux coûts (PCN) G-11

Aperçu

Introduction

Cette section présente les questions et réponses courantes à propos de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Questions et réponses

Introduction

Les renseignements suivants vous aideront à répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées par les répondants. Veuillez vous familiariser avec toutes les réponses pour vous sentir à l'aise quand on vous posera des questions semblables pendant une interview.

En général

1.

Q. Qu'est-ce que l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes?

R. L'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes est une **enquête nationale sur la santé** composée d'un échantillon représentatif de personnes habitant au Canada qui répondront à des questions sur leur santé et leur bien-être, les facteurs influant sur leur santé et leur utilisation des services de santé.

L'enquête fournira des renseignements aux intervenants locaux de santé à des fins d'évaluation et de planification des programmes de promotion de la santé.

2.

Q. Quels sont les objectifs de l'Enquête?

R. Appuyer les services locaux de santé en leur communiquant des renseignements à jour qui leur permettent d'évaluer les politiques et les programmes existants et d'en concevoir de nouveaux, adaptés à leurs collectivités.

Obtenir de chaque province, des renseignements sur la santé qui soient actuels, détaillés et uniformes.

3.

Q. Quels genres de questions poserez-vous?

R. L'enquête pose une variété de questions sur les sujets suivants :

- l'état actuel de votre santé
- les comportements que l'on croit associés à votre santé
- l'utilisation que vous faites des services de santé
- des données sociodémographiques au sujet de votre ménage

---

4. **Q. Qui se sert de ces renseignements? À quelles fins?**

R.

- **Les ministères provinciaux de la santé et les ministères du gouvernement fédéral** s'appuieront sur ces renseignements pour prendre des décisions de financement, élaborer des priorités et cerner les secteurs de préoccupation afin d'établir de nouveaux programmes, de nouvelles politiques et de nouvelles lois.
- **Les chercheurs** disposeront, plus que jamais, de données sur la santé leur permettant de suivre de près, d'analyser et de mesurer les facteurs qui nuisent à la santé et d'en faire état.
- À partir de ce genre de renseignements, **les autorités locales de santé, les groupes communautaires et les organismes sociaux** déterminent la meilleure façon d'affecter les ressources dans le but d'améliorer la santé des personnes de leur collectivité. Les renseignements tirés de cette enquête serviront principalement à l'élaboration de campagnes de sensibilisation du public axées surtout sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie.
- **Les médias** utiliseront les renseignements obtenus pour contribuer à la sensibilisation de la population par rapport aux questions concernant la santé, des questions qui nous concernent tous.

---

5. **Q. Qui participe à la réalisation de l'Enquête?**

R. L'enquête est menée par Statistique Canada, avec l'appui de Santé Canada, des ministères provinciaux de la santé et des planificateurs locaux de santé. Les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé contribuent au contenu du questionnaire.

---

6. **Q. Pourquoi consacrez-vous des fonds à une telle enquête alors que vous pourriez investir dans les soins de santé?**

R. Les gouvernements fédéraux et provinciaux dépensent des milliards de dollars dans le domaine de la santé. Il est donc important que les décisions au sujet des priorités en matière de santé soient prises de façon éclairée. Les renseignements recueillis dans cette enquête contribueront à ce que les fonds publics soient dépensés de façon efficace.

Participation

7.

Q. Comment sélectionne-t-on les participants à l'Enquête?

R. IPAO/ITAO (18+) : Votre adresse a été sélectionnée au hasard pour participer à cette enquête. Nous dresserons ensuite la liste des membres du ménage pour savoir qui y vit actuellement, puis nous sélectionnerons une personne de 18 ans ou plus pour faire une interview.

En étant sélectionné, vous représentez les points de vue d'autres personnes de votre collectivité. Votre participation à notre enquête permet de nous assurer que nous avons une image exacte et à jour de l'état de santé de la population.

R. ITAO (12-17) : Les répondants ont été choisis au hasard à partir des données administratives produites par Statistique Canada. Un jeune admissible entre 12 et 17 ans est présélectionné pour l'ESCC.

Votre participation à notre enquête nous assure que nous avons une image exacte et à jour de l'état de santé de la population des jeunes de 12 à 17 ans. En étant choisi, vous représentez les points de vue des autres jeunes de votre collectivité.

8.

Q. Comment avez-vous choisi mon ménage?

R. (18+) : Votre ménage a été choisi au hasard pour l'ESCC à partir d'une liste d'adresses. Les numéros de téléphone sont fournis par différentes sociétés de téléphonie au Canada. Votre participation à notre enquête assure que nous avons une image représentative et à jour de l'état de santé de la population.

R. (12-17) : Un membre admissible de votre ménage, âgé de 12 à 17 ans, a été choisi au hasard dans les données administratives produites par Statistique Canada. Votre participation à notre enquête nous assure que nous avons une image représentative et à jour de l'état de santé de la population des jeunes de 12 à 17 ans. En étant choisi, vous représentez les points de vue des autres jeunes de votre collectivité.

9.

Q. Je viens tout juste de participer à une enquête semblable. Pourquoi communiquez-vous encore avec moi?

R. Demandez au répondant le nom de l'enquête.

Un certain nombre d'enquêtes sont menées en ce moment. Tous les efforts possibles sont faits pour réduire le nombre d'enquêtes auxquelles on demandera à chaque personne de participer. Il est possible que vous ayez été choisi pour plus d'une enquête. Toutes les enquêtes que nous effectuons sont importantes et portent sur différents aspects de la vie au Canada.

10.

Q. Mon numéro n'est pas inscrit à l'annuaire, comment l'avez-vous obtenu?

R. Des numéros non inscrits à l'annuaire peuvent figurer sur ces listes en raison des délais possibles entre le moment où le numéro est non inscrit et le moment où Statistique Canada reçoit les fichiers à jour. Cette situation se produit rarement et c'est la façon dont nous avons obtenu votre numéro non inscrit.

11.

Q. C'est impossible, mon numéro est non inscrit depuis longtemps, alors comment l'avez-vous obtenu?

R. **IPAO :** Je suis désolé d'apprendre cela. La raison pour laquelle on m'a donné votre numéro de téléphone m'est inconnue. Je vais toutefois signaler la situation à mon superviseur pour qu'une enquête plus poussée soit menée. Acceptez-vous de poursuivre l'interview?

12.

Q. Dois-je prendre part à l'Enquête?

R. La santé est une partie importante de la vie de tous. Afin que les résultats de l'enquête soient représentatifs, il est nécessaire qu'une variété de personnes soit représentée, même les personnes en bonne santé.

Votre participation à l'enquête se fait sur une base volontaire. Cependant, comme chaque personne sélectionnée représente plusieurs autres personnes, votre participation est déterminante pour que les résultats de l'enquête soient exacts.

13.

Q. Combien de temps l'Enquête prendra-t-elle?

R. L'interview dure en moyenne 45 minutes. La durée de l'interview varie selon les réponses des répondants.

14.

Q. Je suis trop vieux. D'autres répondraient mieux que moi aux questions.

R. La santé est une partie importante de la vie de tous. Nous devons interviewer des personnes de divers horizons, des personnes âgées et des jeunes, des hommes et des femmes pour que les résultats de l'enquête soient représentatifs. Les réponses que vous fournissez sur votre usage des services de santé ou les médicaments que vous prenez sont utiles pour nous afin de dresser un portrait général de la santé au Canada. De plus, vos réponses aideront les programmeurs de santé locaux afin d'améliorer et développer des programmes adaptés à vos besoins.

15.

Q. Mon enfant est trop jeune pour répondre à ces questions.

R. Si nous voulons concevoir des programmes de santé qui conviennent aux jeunes Canadiens, nous devons les interroger directement. Nous préférerions toutefois que les répondants soient interviewés seuls de manière à ce qu'ils répondent aux questions en toute liberté. Soyez assuré que nous n'insisterons pas si certaines questions rendent votre enfant mal à l'aise.

16.

Q. Puis-je participer à cette enquête au nom de mon enfant?

R. Pour concevoir des programmes de santé appropriés pour les jeunes au Canada, nous devons recueillir l'information directement auprès d'eux. Les seuls cas où un parent ou un autre adulte peut répondre aux questions au nom d'un enfant répondant sont lorsqu'un problème de santé physique ou mentale de l'enfant l'empêche de faire l'interview. Soyez assuré que nous ne poursuivrons pas avec certaines questions s'il devient évident que votre enfant n'est pas à l'aise.

Protection des renseignements personnels et confidentialité

17.

Q. Comment peut-on vérifier la légitimité de l'Enquête?

R. Pour obtenir la confirmation que Statistique Canada mène l'enquête, vous n'avez qu'à :

- composer le numéro sans frais *(préciser) : 1 800 xxx-xxxx*. En plus de confirmer la légitimité de l'enquête, la personne que vous contacterez pourra vous confirmer que je suis un intervieweur de Statistique Canada.
- téléphoner au bureau régional de Statistique Canada au numéro de téléphone qui est dans l'annuaire. En plus de confirmer la légitimité de l'enquête, la personne que vous contacterez pourra vous confirmer que je suis un intervieweur de Statistique Canada.
- visiter le site Web de Statistique Canada : www.statcan.gc.ca et à cliquer sur « Renseignements pour les répondants aux enquêtes » sur la page d'accueil et regarder dans Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

18.

Q. Le Gouvernement détient déjà trop de renseignements.

R. Au fil du temps, les priorités en matière de santé ont changé. Nous mettons maintenant l'accent sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, ainsi les besoins en information ne sont plus les mêmes. Les services locaux de santé, en particulier, ont besoin d'information sur la santé des gens dans leur collectivité afin de concevoir des programmes et des services qui leur conviennent. C'est pourquoi l'enquête comprend des questions choisies par les services locaux de santé de votre collectivité, afin de répondre précisément à leurs besoins.

19.

Q. Pourquoi voulez-vous savoir combien je gagne?

R. Pour déterminer la situation économique globale d'une personne, nous devons connaître son revenu total. Bien que de nombreux frais de santé soient couverts par l'assurance santé, il y a tout de même un lien entre la santé des gens et leur situation économique. L'enquête nous permettra d'approfondir la question. Soyez assuré que, tout comme les autres renseignements que vous nous avez fournis, votre revenu demeurera strictement confidentiel.

20.

Q. Pourquoi voulez-vous connaître mon orientation sexuelle?

R. L'information sur l'orientation sexuelle est nécessaire pour mieux comprendre une gamme d'enjeux reliés à la santé des homosexuels, des bisexuels et des hétérosexuels, par exemple, les expériences de discrimination, l'accès aux soins de santé, et des comportements tels que l'activité physique et le tabagisme.

Ces renseignements aideront les décideurs à déterminer quels sont les problèmes sur lesquels ils doivent se pencher pour améliorer la santé et les soins de santé prodigués à divers groupes. Par exemple, en sachant que le tabagisme est plus élevé chez les homosexuels que chez les hétérosexuels, les ministères responsables des politiques pourront mieux déterminer comment s'attaquer au problème et comment cibler les initiatives de prévention et de recherche en santé.

21.

Q. Pourquoi désirez-vous connaître mon numéro d'assurance maladie?

R. Le numéro d'assurance maladie nous permet de lier les renseignements recueillis au moyen du questionnaire, comme l'état de santé et les facteurs nuisant à la santé, aux dossiers de santé provinciaux. Ces dossiers renferment des renseignements sur l'utilisation des services de santé et l'apparition de certains types de maladie.

Ces liens vous évitent de devoir répondre à des questions additionnelles pour cette enquête, réduisent les coûts associés à la collecte de l'information et fournissent un ensemble de données plus complet et plus riche à analyser.

22.

Q. Comment puis-je savoir que le tout demeurera confidentiel?

R.

- La Loi sur la statistique garantit que toute information que vous nous donnez demeure strictement confidentielle. Statistique Canada prend toutes les mesures nécessaires pour vous protéger. Aucune personne non autorisée à l'extérieur de Statistique Canada ne pourra jamais voir vos réponses personnelles sans votre permission.
- Tous les employés de Statistique Canada ont prêté serment, ce qui signifie qu'ils sont passibles de pénalités sévères, y compris une poursuite judiciaire, s'ils n'assurent pas la confidentialité de vos renseignements.
- Statistique Canada ne publie jamais de renseignements personnels qu'il obtient dans le cadre d'enquêtes. Toutes les publications et autres diffusions sont passées au peigne fin.
- Par ailleurs, les renseignements que vous accepterez de partager avec les ministères de la santé provinciaux et Santé Canada, afin d'épargner temps et argent, demeureront confidentiels.

23.

Q. Allez-vous vendre mes renseignements?

R. Non. Nous ne vendons jamais les renseignements personnels obtenus des répondants.

24.

Q. Est-ce que mon nom se retrouvera sur des listes d'envoi?

R. Non. Les listes d'enquête sont réservées à l'usage interne de Statistique Canada et demeurent strictement confidentielles. Elles ne servent à aucune fin commerciale ni ne sont vendues à des entreprises privées.

25.

Q. En quoi consiste l'entente relative au partage des données?

R. Il s'agit d'une entente entre Statistique Canada, Santé Canada et les ministères provinciaux de la santé concernant le partage des renseignements recueillis par l'enquête. Son but est de réduire le fardeau du répondant, et de diminuer les coûts liés à la collecte des données. Ça permet ainsi aux différentes provinces d'avoir accès à des renseignements sans avoir à refaire une telle enquête. Les renseignements que vous nous communiquez ne peuvent être partagés que si vous y consentez.

La loi interdit également à ces ministères de divulguer tout renseignement susceptible de vous identifier à partir des données recueillies par Statistique Canada.

26.

Q. Comment les gens peuvent-ils obtenir une copie des résultats?

R. Le public a accès aux résultats d'enquête de diverses façons. Il peut entre autres consulter le site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca), les centres régionaux de consultation de Statistique Canada, environ 700 bibliothèques publiques au Canada et en entendre parler par les médias.

27.

Q. Quand les résultats de l'Enquête seront-ils disponibles?

R. Les premiers résultats seront disponibles dès le printemps de l'année après la collecte de données.

28.

Q. Comment puis-je savoir que la vie privée de mon enfant sera protégée?

R. Pour toutes les enquêtes effectuées par Statistique Canada, les données sont recueillies en vertu de la *Loi sur la statistique*. En vertu de cette loi, tous les renseignements obtenus demeureront confidentiels. Tous les employés de Statistique Canada ont prêté serment et sont passibles de poursuites et de peines importantes s'ils ne respectent pas cette confidentialité. Les résultats de l'enquête seront groupés pour garantir qu'aucune personne ne puisse être identifiée.

29.

Q. Jeune : Vous avez posé des questions très personnelles au sujet de mon corps et de mon activité sexuelle. Pourquoi posez-vous des questions sur ces sujets?

R. Nous voulons connaître toute la gamme d'expériences que vous vivez. De nombreux jeunes ont à prendre des décisions importantes en matière de sexualité, et nous voulons connaître l'incidence de ces décisions sur leur vie.

30.

Q. Mes parents ou les policiers pourraient-ils voir mes réponses?

R. Toutes vos réponses aux questionnaires et à l'interview demeurent confidentielles. Personne ne pourra donc associer votre nom aux réponses que vous avez données. Nous n'envoyons pas les réponses à la police; ce serait même une infraction à la loi (*Loi sur la statistique*).

Une fois que l'entrevue est terminée, les questions auxquelles vous avez répondu ne peuvent pas être reouvertes, même par l'intervieweur. Vos réponses sont enregistrées puis elles sont transmises à Statistique Canada. L'intervieweur ne peut rien dire à vos parents, à vos professeurs ou à n'importe qui d'autre au sujet de vos réponses à l'enquête. Statistique Canada fournira à tous les répondants (ou à leurs parents si le répondant a moins de 18 ans) une copie de leurs réponses s'ils écrivent une lettre signée à Statistique Canada. Comme l'ESCC de 2015 est une étude d'envergure, nous prévoyons qu'il faudra au moins un an pour traiter les données. Nous sommes dans l'impossibilité de fournir vos informations à vos parents avant l'automne 2016.

Nous espérons vous avoir convaincu que vous pouvez répondre aux questions avec franchise.

Survol du module Ordonnances (Janvier – Juin 2016)

Non-respect lié aux coûts (PCN)

Aperçu

Ce module de réponse rapide recueille des données sur le non-respect d'une ordonnance de médicaments en raison des coûts. Le non-respect peut être défini par des comportements comme ne pas remplir une ordonnance ou retarder le moment de le faire, ne pas aller chercher un médicament prescrit, ou bien sauter ou réduire des doses de médicament.

Les questions concernant l'aspect financier du non-respect des ordonnances visent à déterminer le coût direct des médicaments, que les répondants ont eu ou non les moyens d'acheter, au cours des 12 derniers mois.

En outre, on pose aux répondants des questions sur ce que font les professionnels de la santé et les pharmaciens pour aider à alléger le fardeau lié au coût des médicaments pour leurs patients.

Les répondants sont invités à déclarer les problèmes de santé pour lesquels les médicaments ont été prescrits, mais n'ont pu être achetés, de même que les effets négatifs sur leur santé et d'autres aspects de leur vie, en raison de leur incapacité à payer leurs médicaments sur ordonnance.

Les données recueillies serviront à déterminer le segment de la population canadienne qui ne respecte pas les ordonnances de médicaments en raison des coûts, les problèmes de santé touchés, et les compromis faits aux autres dépenses pour compenser.

PCN_Q005

Au cours des 12 derniers mois, ^DT_ESTILARRIVE de ne pas faire remplir ^DT_VOTRE1 ordonnance, de ne pas aller chercher ^DT_VOTRE1 médicament prescrit ou de sauter des doses de ^DT_VOTRE1 médicaments à cause des coûts?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Si quelqu'un répond pour le compte d'un enfant, veuillez vous assurer qu'on ne considère que l'ordonnance de cet enfant. Veuillez inclure si un parent ou quelqu'un dans le ménage a pris la décision pour le compte de l'enfant.

1 **Oui**
2 **Non**
3 **Sans objet, ^DT_ILELLE pas eu d'ordonnance à remplir au cours des 12 derniers mois.**
NSP, RF

PCN_Q010

Au cours des 12 derniers mois, ^DT_ESTILARRIVE de réduire la dose de ^DT_VOS1 propres médicaments ou d'attendre de faire remplir ^DT_VOTRE1 ordonnance à cause du coût?

1 Oui
2 Non
3 Sans objet, ^DT_ILELLE pas eu d'ordonnance à remplir au cours des 12 derniers mois.
NSP, RF

PCN_Q015

Au cours des 12 derniers mois, pour combien de médicaments différents ^DT_AVEZ-^DT_VOUST reçu une ordonnance, y compris les ordonnances en continu?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **0**
2 **1 ou 2**
3 **3 ou 4**
4 **5 ou plus**
NSP, RF

PCN_R020

Maintenant quelques questions au sujet du coût de ^DT_VOS1 médicaments sur ordonnance.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PCN_Q020

Au cours des 12 derniers mois, combien d'argent a été dépensé pour ^DT_VOS1 propres médicaments prescrits par un professionnel des soins de santé? Veuillez exclure tout montant remboursé par un régime d'assurance.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Le répondant peut se référer à la dernière année fiscale au lieu des 12 derniers mois si nécessaire.

1 **0**
2 **1 à 200 dollars**
3 **201 à 500 dollars**
4 **501 à 1000 dollars**
5 **Plus de 1000 dollars**
NSP, RF

PCN_Q025

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence ^DT_FNAME2F attendu ou omis de faire remplir ^DT_VOTRE1 ordonnance ou n'^DT_AVEZ pas pris ^DT_VOS1 médicaments tels que prescrits, en raison des coûts?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Veuillez inclure si un parent ou quelqu'un dans le ménage a pris la décision pour le compte de l'enfant.

1 **Rarement**
2 **Parfois**
3 **Souvent**
4 **Toujours**
NSP, RF

PCN_R030

Les quelques prochaines questions concernent toutes les ordonnances pour ^DT_VOS1 médicaments ^DT_AVIEZ_AVAIT pas les moyens de payer au cours des 12 derniers mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PCN_Q030

Quels problèmes de santé ces ordonnances étaient-elles censées traiter?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées. Si la réponse est TDA/TDAH, sélectionnez 'Autre condition/maladie'.

01 **Maladie cardiaque, taux élevé de cholestérol ou hypertension**
02 **Asthme ou MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)**
03 **Dépression, anxiété ou autres maladies mentales**
04 **Diabète**
05 **Problèmes intestinaux (p. ex. ulcère, brûlures d'estomac, maladie intestinale)**
06 **Arthrite ou autre douleur chronique**
07 **Une infection (p. ex. bactérienne, fongique ou virale)**
08 **Un type de cancer**
09 **Autre maladie**
NSP, RF

PCN_Q035

Pensez-vous que ^DT_VOTRE1 incapacité de payer ^DT_VOS1 médicaments sur ordonnance a détérioré ^DT_VOTRE2 santé?

1 Oui
2 Non
NSP, RF

PCN_Q040

^DT_VOTRE1 incapacité de payer ^DT_VOS1 médicaments sur ordonnance ^DT_LELA3 a-t-elle amené à faire une des actions suivantes :

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées.

1 **^DT_VOUS3 rendre au service des urgences?**
2 **Être admis à l'hôpital?**
3 **^DT_VOUS3 rendre chez le médecin, ce ^DT_QUE ^DT_VOUS1 n'aur^DT_IEZ pas eu à faire autrement?**
4 Aucun des choix ci-dessus
NSP, RF

PCN_R050

Les quelques prochaines questions concernent <u>la dernière fois</u> où ^DT_NÉTIEZ_NÉTAIT pas en mesure de payer ^DT_VOS1 médicaments sur ordonnance au cours des 12 derniers mois.

INTERVIEWEUR : Appuyez sur <1> pour continuer.

PCN_Q055

Quel était le montant approximatif ^DT_QUE ^DT_VOUS1 aur^DT_IEZ payé pour cette ordonnance? Veuillez exclure tout montant remboursé par un régime d'assurance.

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.

1 **1 à 25 dollars**
2 **26 à 50 dollars**
3 **51 à 200 dollars**
4 **201 à 1000 dollars**
5 **1001 dollars ou plus**
NSP, RF

PCN_Q060

Le médecin, a-t-il aidé à trouver des moyens de réduire le coût, par exemple en suggérant des médicaments de remplacement moins chers ou en fournissant des échantillons gratuits?

INTERVIEWEUR : Si le professionnel des soins de santé suggère des alternatives seulement à la suite d'un commentaire du patient, inscrire la réponse comme « Non ».

1 Oui
2 Non
3 Ne s'applique pas, aucun médicament de remplacement ou échantillon gratuit n'existe pour ce que le répondant ne peut se payer.
NSP, RF

PCN_Q065

Le pharmacien qui a rempli l'ordonnance a-t-il demandé si il avez les moyens de payer les médicaments? INTERVIEWEUR : Si le pharmacien s'est informé de la capacité de payer seulement à la suite d'un commentaire du patient, inscrire la réponse comme « Non ».

1 Oui
2 Non
3 ^DT_ILELLE1_C pas essayé de remplir l'ordonnance
NSP, RF

PCN_Q070

Le pharmacien il a-t-il aidé à trouver des moyens de réduire le coût des médicaments, par exemple en suggérant des produits de remplacement moins chers ou en fournissant une carte de réduction pour les médicaments?

INTERVIEWEUR : Si le pharmacien suggère des alternatives seulement à la suite d'un commentaire du patient, inscrire la réponse comme « Non ».

1 Oui
2 Non
3 Ne s'applique pas, aucun produit de remplacement ou carte de réduction n'existe pour ce que le répondant ne peut se payer.
NSP, RF

PCN_Q075

Au cours des 12 derniers mois, avez vous déjà réduit les dépenses suivantes afin de pouvoir payer vos médicaments sur ordonnance?

INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. Choisissez toutes les réponses appropriées. Veuillez inclure si un parent ou quelqu'un dans le ménage a pris la décision pour le compte de l'enfant.

01 **Alimentation**
02 **Logement**
03 **Chauffage pour ^DT_VOTRE1 logement**
04 **Véhicule, transport en commun ou autre dépense de transport**
05 **Loisirs ou vacances**
06 **Autre dépense de soins de santé pour ^DT_VOUS5-même ou ^DT_VOTRE2 famille**
07 **Autres dépenses non déjà mentionnées**
08 **Non - Aucune dépense n'a été réduite**
NSP, RF

Au cours des 12 derniers mois, avez vous déjà eu à emprunter afin de pouvoir payer vos médicaments sur ordonnance?

INTERVIEWEUR : Par exemple, auprès d'amis, de la famille ou d'une institution bancaire.

1 Oui
2 Non
NSP, RF

RFH_END